



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Bunga Rampai **KESELAMATAN PASIEEN**

Melalui Handover Keperawatan Yang Efektif

Muhammad Syahid Hidayat BS • Halimatussakdiah • Silvana Evi Linda
Fitriana Dewi • Asih Minarningtyas • Sri Wahyuni • Vera Sesrianty

Editor: Amik Muladi



BUNGA RAMPAI: KESELAMATAN PASIEN MELALUI HANDOVER KEPERAWATAN YANG EFEKTIF

Penulis:

Dr. Muhammad Syahid Hidayat BS, S.H., S.Kep., M.H., M.S.

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., Ph.D.

Ns. Fitriana Dewi, S.Kep., M.Kep.

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.

Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Vera Sesrianty, M.Kep.

Editor:

Amik Muladi, S.Kep., Ns., M.Kep.



Bunga Rampai: Keselamatan Pasien Melalui Handover Keperawatan Yang Efektif

Penulis:

Dr. Muhammad Syahid Hidayat BS, S.H., S.Kep., M.H., M.S.

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., Ph.D.

Ns. Fitriana Dewi, S.Kep., M.Kep.

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.

Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Vera Sesrianty, M.Kep.

Editor: Amik Muladi, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-37-4

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul “ *bunga rampai Keselamatan Pasien melalui Handover Keperawatan yang Efektif*” ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan tenaga keperawatan dalam menjaga keselamatan pasien melalui proses handover yang terstandar, jelas, dan berorientasi pada mutu pelayanan.

Keselamatan pasien merupakan inti dari pelayanan kesehatan, terutama dalam praktik keperawatan yang berlangsung selama 24 jam dan melibatkan pergantian shift secara berkesinambungan. Pada titik inilah handover memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi klinis, rencana asuhan, serta identifikasi risiko yang harus dipantau. Komunikasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak terstruktur berpotensi menimbulkan kesalahan, keterlambatan tindakan, hingga kejadian tidak diharapkan. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami konsep, prinsip, dan penerapan handover yang efektif sebagai salah satu intervensi kunci dalam pencegahan kesalahan dan peningkatan keselamatan pasien.

Bunga rampai ini disajikan dalam tujuh bab yang saling melengkapi. Bab 1 membahas konsep dasar keselamatan pasien dalam pelayanan keperawatan sebagai fondasi berpikir dan bertindak. Bab 2 menguraikan pengertian serta tujuan handover keperawatan dalam konteks kontinuitas asuhan. Bab 3 menitikberatkan pada prinsip komunikasi efektif dalam handover sebagai prasyarat utama pertukaran informasi yang aman. Bab 4 menjelaskan penerapan metode SBAR sebagai pendekatan komunikasi terstruktur yang terbukti membantu meningkatkan kejelasan dan ketepatan pesan klinis. Bab 5 mengulas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas handover, baik dari sisi individu, lingkungan kerja, maupun sistem. Bab 6 menegaskan peran perawat dalam mencegah kesalahan melalui handover yang aman, profesional, dan bertanggung jawab. Bab 7 menutup dengan pembahasan evaluasi efektivitas handover terhadap keselamatan pasien, termasuk indikator dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi menyampaikan gagasan dan pengalaman praktik, para penyunting, serta semua pihak yang membantu proses penyusunan hingga penerbitan. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi

perawat, mahasiswa keperawatan, pendidik, serta praktisi kesehatan lainnya dalam menguatkan budaya keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan.

Akhir kata, kami menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.

Juni, 2026

Penulis



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KESELAMATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KEPERAWATAN

Dr. Muhammad Syahid Hidayat BS, S.H., S.Kep., M.H., M.S.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Keperawatan.....	2
C. Risiko dan Sumber Insiden Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan.....	6
D. Budaya Keselamatan Pasien sebagai Fondasi Handover Keperawatan yang Efektif.....	11
E. Simpulan	16
Referensi	17
Glosarium	19

CHAPTER 2 PENGERTIAN DAN TUJUAN HANDOVER KEPERAWATAN

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Pengertian Umum Handover Keperawatan.....	22
C. Pengertian Handover menurut Organisasi dan Literatur	23
D. Tujuan Handover Keperawatan	25
E. Relevansi Handover dalam Praktik Keperawatan Modern.....	28
F. Dampak Handover yang Tidak Efektif.....	29
G. Hambatan dalam pelaksanaan Handover Keperawatan.....	30
H. Simpulan	33
Referensi	35

CHAPTER 3 PRINSIP KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM HANDOVER

Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., Ph.D.	38
A. Pendahuluan.....	38
B. Konsep Komunikasi Efektif.....	39
C. Konsep Handover dalam Keperawatan.....	41
D. Pengertian Check-Back Communication.....	47
E. Pengertian Readback Information.....	49

F. KESIMPULAN	53
Referensi	54

CHAPTER 4 PENERAPAN METODE SBAR DALAM HANDOVER KEPERAWATAN

Ns. Fitriana Dewi, S.Kep., M.Kep.	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Konsep Hand Over	58
C. Klasifikasi Hand over.....	58
D. Konsep Metode SBAR	62
E. Komponen SBAR.....	62
F. Manfaat Metode SBAR dalam Handover Keperawatan.....	65
G. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Metode SBAR dalam Handover Keperawatan.....	68
H. Kesimpulan.....	71
Referensi	74

CHAPTER 5 FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS HANDOVER

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Konsep Handover Pasien	78
C. Faktor faktor yang memengaruhi Kualitas Hand Over.....	79
D. Dampak Kualitas Handover terhadap Keselamatan Pasien.....	96
E. Simpulan	99
Referensi	100

CHAPTER 6 PERAN PERAWAT DALAM MENCEGAH KESALAHAN MELALUI HANDOVER

Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.	102
A. Pendahuluan.....	102
B. Konsep Hand Over dalam Keperawatan.....	103
C. Faktor Penghambat Handover Efektif	104
D. Faktor Pendukung Handover Berkualitas.....	105
E. Peran Perawat dalam Mencegah Kesalahan Hand Over	106
F. Strategi Hand Over yang Aman.....	110
G. Implikasi Praktik Keperawatan	112
H. Kesimpulan.....	113
Referensi	115
Glosarium	116

CHAPTER 7 EVALUASI EFEKTIVITAS HANDOVER TERHADAP KESELAMATAN PASIEN

Ns. Vera Sesrianty, M.Kep.....	119
A. Pendahuluan.....	119
B. Pengertian Handover.....	119
C. Hubungan Handover dengan Keselamatan Pasien.....	120
D. Efektifitas Handover Terhadap Keselamatan Pasien.....	121
E. Evaluasi Efektifitas Handover.....	122
F. Indikator Efektifitas Handover.....	123
G. Metode Evaluasi handover.....	124
H. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Handover.....	125
I. Hambatan dalam Pelaksanaan Handover.....	128
J. Strategi Meningkatkan Efektifitas Handover.....	129
K. Simpulan.....	131
Referensi	132
Glosarium.....	134
 PROFIL PENULIS	 135



CHAPTER 1



KONSEP DASAR KESELAMATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KEPERAWATAN

Dr. Muhammad Syahid Hidayat BS, S.H., S.Kep., M.H., M.S.

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien merupakan salah satu fondasi utama dalam pelayanan kesehatan modern. Dalam praktik keperawatan, keselamatan pasien tidak hanya dipahami sebagai upaya mencegah cedera fisik, tetapi juga sebagai sistem pelayanan yang memastikan setiap tindakan keperawatan dilakukan secara aman, tepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Perawat berada pada posisi yang sangat strategis karena mereka berinteraksi langsung dengan pasien selama dua puluh empat jam, memantau perubahan kondisi pasien, memberikan intervensi keperawatan, melakukan edukasi, berkoordinasi dengan profesi lain, serta mendokumentasikan perkembangan pasien dari waktu ke waktu.

World Health Organization mendefinisikan keselamatan pasien sebagai tidak adanya bahaya yang dapat dicegah pada pasien serta pengurangan risiko bahaya yang tidak perlu hingga pada tingkat seminimal mungkin. WHO juga menekankan bahwa keselamatan pasien bukan sekadar tanggung jawab individu tenaga kesehatan, melainkan kerangka kerja sistem yang mencakup budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan pelayanan yang mampu menurunkan risiko, mengurangi kejadian cedera, serta meminimalkan dampak ketika insiden terjadi.

Dalam konteks Indonesia, keselamatan pasien telah menjadi bagian penting dari regulasi dan standar mutu pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa keselamatan pasien adalah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, antara lain melalui asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, tindak lanjut, serta implementasi solusi untuk meminimalkan risiko dan mencegah cedera akibat kesalahan tindakan atau kelalaian mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan.

Dalam pelayanan keperawatan, salah satu titik kritis yang sangat berkaitan dengan keselamatan pasien adalah handover keperawatan. Handover merupakan proses pengalihan informasi, tanggung jawab, dan kewenangan perawatan dari satu

perawat kepada perawat lain atau dari satu tim kepada tim berikutnya. AHRQ menjelaskan bahwa handoff atau handover adalah metode terstandar untuk mentransfer informasi sekaligus tanggung jawab dan kewenangan selama transisi perawatan pasien; ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan kapan tanggung jawab itu berpindah dapat berkontribusi terhadap kesalahan medis.

Oleh karena itu, keselamatan pasien dan handover keperawatan memiliki hubungan yang sangat erat. Handover yang tidak lengkap, tidak sistematis, atau dilakukan dalam suasana tergesa-gesa dapat menyebabkan informasi penting terlewat, seperti perubahan kondisi pasien, hasil pemeriksaan terbaru, obat yang harus diwaspadai, risiko jatuh, alergi, instruksi dokter, rencana tindakan, atau kebutuhan monitoring khusus. Sebaliknya, handover yang efektif dapat membantu menjaga kontinuitas asuhan, mencegah miskomunikasi, memperkuat koordinasi tim, dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Bab ini membahas konsep dasar keselamatan pasien dalam pelayanan keperawatan sebagai dasar untuk memahami pentingnya handover yang efektif. Pembahasan diawali dengan definisi, prinsip, dan dimensi keselamatan pasien, dilanjutkan dengan sumber risiko dan bentuk insiden keselamatan pasien dalam praktik keperawatan, kemudian diakhiri dengan penjelasan mengenai budaya keselamatan pasien sebagai fondasi komunikasi dan handover yang aman.

B. Konsep Dasar Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Keperawatan

1. Pengertian Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah kondisi ketika pasien terlindungi dari risiko cedera yang dapat dicegah selama menerima pelayanan kesehatan. Pengertian ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pelayanan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses yang dilalui pasien sejak masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, menerima asesmen, mendapatkan tindakan, menjalani pengobatan, hingga pulang atau dirujuk ke fasilitas lain.

Dalam pelayanan keperawatan, keselamatan pasien mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan perawat untuk memastikan pasien menerima asuhan secara aman. Aktivitas tersebut meliputi identifikasi pasien yang benar, pemberian obat sesuai prinsip benar, pencegahan risiko jatuh, pencegahan infeksi, pengawasan kondisi klinis, komunikasi efektif, dokumentasi akurat, edukasi pasien dan keluarga, serta pelaporan insiden apabila terjadi kejadian yang berpotensi atau telah menimbulkan cedera.

Keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan dari mutu pelayanan. Pelayanan yang bermutu harus aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, dan adil. Dengan demikian, pelayanan keperawatan yang baik bukan hanya pelayanan yang ramah dan cepat, tetapi juga pelayanan yang mampu mencegah kesalahan, mengelola risiko, serta menjamin bahwa setiap keputusan keperawatan didasarkan pada data yang benar dan komunikasi yang jelas.

WHO menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas global melalui Global Patient Safety Action Plan 2021–2030. Rencana aksi ini memiliki visi bahwa tidak seorang pun mengalami cedera dalam pelayanan kesehatan dan setiap pasien menerima pelayanan yang aman dan penuh penghormatan, setiap waktu dan di mana pun. Dokumen tersebut juga memberikan arah strategis bagi negara dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi bahaya yang dapat dicegah dalam pelayanan kesehatan.

2. Tujuan Keselamatan Pasien

Tujuan utama keselamatan pasien adalah mencegah terjadinya cedera yang tidak perlu selama pasien menerima pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan keperawatan, tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan operasional, yaitu:

- a. Mencegah kesalahan identifikasi pasien.
- b. Meningkatkan komunikasi efektif antarperawat dan antarprofesi.
- c. Menjamin keamanan pemberian obat, terutama obat berisiko tinggi.
- d. Mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan.
- e. Mengurangi risiko pasien jatuh dan cedera.
- f. Menjamin tindakan keperawatan dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien.
- g. Mendorong pelaporan insiden untuk pembelajaran dan perbaikan sistem.
- h. Membangun budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan tidak menyalahkan secara berlebihan.

Tujuan-tujuan tersebut memperlihatkan bahwa keselamatan pasien bukan hanya tugas manajemen rumah sakit, melainkan juga bagian dari praktik harian perawat. Setiap tindakan sederhana, seperti mengecek gelang identitas pasien, mencuci tangan, memastikan dosis obat, membaca ulang instruksi lisan, melakukan dokumentasi tepat waktu, dan menyampaikan informasi pasien secara lengkap saat handover, memiliki dampak besar terhadap keselamatan pasien.

3. Prinsip-Prinsip Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien dibangun atas beberapa prinsip penting. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan yang aman dan bertanggung jawab.

a. Berorientasi pada pasien

Pelayanan yang aman harus menempatkan pasien sebagai pusat perhatian. Pasien bukan hanya objek tindakan, tetapi subjek yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, menyampaikan keluhan, dan memahami rencana perawatannya. Keterlibatan pasien dan keluarga dapat membantu tenaga kesehatan mengenali risiko lebih dini, misalnya riwayat alergi obat, perubahan kondisi, kesalahan identitas, atau ketidaksesuaian tindakan.

b. Pencegahan lebih utama daripada koreksi

Keselamatan pasien menekankan upaya pencegahan sebelum insiden terjadi. Dalam keperawatan, pencegahan dilakukan melalui asesmen risiko, monitoring berkala, komunikasi efektif, edukasi, penerapan standar prosedur, penggunaan checklist, serta dokumentasi yang akurat. Tindakan pencegahan jauh lebih baik daripada memperbaiki dampak cedera setelah insiden terjadi.

c. Berbasis sistem, bukan sekadar menyalahkan individu

Banyak kesalahan dalam pelayanan kesehatan terjadi bukan semata-mata karena kelalaian individu, tetapi karena sistem kerja yang tidak mendukung keselamatan. WHO menekankan pentingnya pendekatan sistem karena kesalahan yang menimbulkan cedera sering berkaitan dengan desain proses, alur kerja, koordinasi, beban kerja, teknologi, komunikasi, dan budaya organisasi.

Dalam praktik keperawatan, contoh kegagalan sistem dapat berupa format handover yang tidak standar, lingkungan kerja yang terlalu bising, jumlah perawat yang tidak seimbang dengan jumlah pasien, dokumentasi yang tidak terintegrasi, atau tidak adanya mekanisme konfirmasi instruksi. Jika organisasi hanya menyalahkan individu, akar masalah tidak akan terselesaikan. Sebaliknya, pendekatan sistem memungkinkan organisasi belajar dari insiden dan memperbaiki proses pelayanan.

d. Komunikasi efektif sebagai inti keselamatan

Komunikasi yang jelas, lengkap, tepat waktu, dan terstruktur merupakan salah satu kunci keselamatan pasien. Banyak insiden keselamatan pasien berawal dari komunikasi yang tidak lengkap, salah tafsir, atau tidak terdokumentasi. Dalam konteks keperawatan, komunikasi efektif sangat penting pada saat pemberian obat, pelaporan perubahan kondisi pasien, koordinasi dengan dokter, edukasi kepada pasien, dan terutama pada saat handover.

Salah satu alat komunikasi yang banyak digunakan adalah SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. AHRQ menjelaskan

bahwa SBAR merupakan kerangka komunikasi terstruktur yang membantu tim menyampaikan informasi tentang kondisi pasien atau masalah klinis secara jelas dan ringkas.

e. Pembelajaran berkelanjutan dari insiden

Keselamatan pasien tidak hanya menuntut pencegahan, tetapi juga kemampuan organisasi untuk belajar dari kesalahan. Setiap insiden, baik yang menimbulkan cedera maupun yang hampir terjadi, harus dipandang sebagai sumber pembelajaran. Pelaporan insiden bukan bertujuan mencari siapa yang salah, melainkan memahami mengapa insiden terjadi dan bagaimana mencegah agar kejadian serupa tidak terulang.

4. Dimensi Keselamatan Pasien dalam Keperawatan

Keselamatan pasien dalam pelayanan keperawatan dapat dilihat dari beberapa dimensi utama.

a. Dimensi klinis

Dimensi klinis berkaitan dengan keamanan tindakan dan intervensi yang diberikan kepada pasien. Perawat harus memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar, indikasi, kondisi pasien, serta rencana asuhan. Contohnya adalah pemantauan tanda vital, pemberian obat, perawatan luka, pemasangan infus, tindakan pencegahan dekubitus, pengelolaan nyeri, dan pemantauan risiko jatuh.

b. Dimensi komunikasi

Dimensi komunikasi mencakup proses penyampaian informasi yang akurat antarperawat, antara perawat dan dokter, serta antara perawat dengan pasien dan keluarga. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan salah pengertian, duplikasi tindakan, keterlambatan intervensi, atau bahkan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Handover keperawatan merupakan bagian penting dari dimensi ini.

c. Dimensi dokumentasi

Dokumentasi keperawatan adalah bukti tertulis mengenai kondisi pasien, tindakan yang diberikan, respons pasien, edukasi, dan rencana tindak lanjut. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat mengganggu kontinuitas asuhan dan meningkatkan risiko kesalahan. Dalam handover, dokumentasi menjadi sumber informasi utama yang membantu perawat shift berikutnya memahami kondisi pasien secara utuh.

d. Dimensi lingkungan

Lingkungan pelayanan yang aman mencakup kebersihan, pencahayaan, ketersediaan alat, tata ruang, pengendalian infeksi, keselamatan tempat tidur pasien, serta pengurangan risiko jatuh. Lingkungan yang tidak aman dapat

menimbulkan cedera, terutama pada pasien lansia, pasien pascaoperasi, pasien dengan gangguan kesadaran, atau pasien dengan keterbatasan mobilitas.

e. Dimensi organisasi

Dimensi organisasi berkaitan dengan kebijakan, kepemimpinan, budaya keselamatan, pelatihan staf, sistem pelaporan, audit mutu, dan tindak lanjut insiden. Keselamatan pasien tidak akan berjalan optimal jika organisasi tidak menyediakan sistem pendukung yang jelas. Komitmen pimpinan menjadi penting karena budaya keselamatan harus dibangun melalui kebijakan, keteladanan, supervisi, dan evaluasi berkelanjutan.

C. Risiko dan Sumber Insiden Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan

1. Pengertian Risiko Keselamatan Pasien

Risiko keselamatan pasien adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menyebabkan cedera, memperburuk kondisi, memperpanjang masa rawat, menimbulkan kecacatan, atau menyebabkan kematian pada pasien. Risiko dapat muncul pada setiap tahap pelayanan, mulai dari penerimaan pasien, asesmen, pemberian tindakan, pemberian obat, observasi, pemindahan pasien, hingga proses pulang.

Dalam keperawatan, risiko keselamatan pasien sering berkaitan dengan tindakan rutin yang tampak sederhana tetapi memiliki konsekuensi besar apabila dilakukan tanpa kehati-hatian. Misalnya, tidak memverifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat dapat menyebabkan obat diberikan kepada pasien yang salah. Tidak menyampaikan hasil pemeriksaan kritis saat handover dapat menyebabkan keterlambatan tindakan. Tidak melakukan asesmen risiko jatuh dapat membuat pasien mengalami cedera saat turun dari tempat tidur.

WHO mencatat bahwa sumber umum bahaya dalam pelayanan kesehatan meliputi kesalahan obat, tindakan bedah yang tidak aman, infeksi terkait pelayanan kesehatan, kesalahan diagnosis, pasien jatuh, luka tekan, salah identifikasi pasien, transfusi darah tidak aman, dan tromboemboli vena. (World Health Organization)

2. Jenis-Jenis Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pemahaman terhadap jenis insiden penting agar perawat mampu mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti kejadian secara tepat.

a. Kejadian Tidak Diharapkan

Kejadian tidak diharapkan adalah kejadian yang menyebabkan cedera pada pasien akibat pelayanan kesehatan, bukan karena perjalanan alami

penyakit. Contohnya adalah pasien jatuh hingga mengalami fraktur, kesalahan pemberian obat yang menyebabkan reaksi berat, atau infeksi akibat prosedur yang tidak sesuai prinsip aseptik.

b. Kejadian Nyaris Cedera

Kejadian nyaris cedera adalah kejadian yang hampir menimbulkan cedera, tetapi belum sampai mengenai pasien karena berhasil dicegah atau diketahui lebih awal. Misalnya, obat pasien A hampir diberikan kepada pasien B, tetapi perawat menemukan kesalahan setelah memeriksa ulang identitas pasien.

c. Kejadian Tidak Cedera

Kejadian tidak cedera adalah insiden yang sudah terjadi pada pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera. Walaupun tidak menyebabkan dampak langsung, kejadian ini tetap penting dilaporkan karena menunjukkan adanya kelemahan sistem.

d. Kondisi Potensial Cedera

Kondisi potensial cedera adalah keadaan yang berisiko menyebabkan insiden apabila tidak segera diperbaiki. Contohnya adalah lantai licin di ruang rawat, tidak adanya tanda risiko jatuh pada pasien berisiko tinggi, atau obat high-alert yang tidak diberi label khusus.

3. Sumber Risiko dalam Pelayanan Keperawatan

a. Kesalahan identifikasi pasien

Identifikasi pasien merupakan langkah dasar dalam keselamatan pasien. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan tindakan, obat, pemeriksaan, atau transfusi diberikan kepada pasien yang salah. Risiko ini dapat terjadi ketika pasien memiliki nama yang mirip, tidak memakai gelang identitas, gelang identitas tidak terbaca, atau perawat tidak melakukan verifikasi minimal dua identitas.

Dalam praktik keperawatan, identifikasi harus dilakukan sebelum pemberian obat, pengambilan sampel darah, pemberian transfusi, tindakan invasif, pemindahan pasien, dan pemberian diet khusus. Identifikasi yang benar juga harus menjadi bagian dari handover, terutama pada pasien baru, pasien pindahan, atau pasien dengan kondisi kritis.

b. Kesalahan komunikasi

Kesalahan komunikasi adalah salah satu sumber risiko paling dominan dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan informasi penting tidak sampai kepada perawat berikutnya. Dalam handover, risiko komunikasi dapat muncul ketika perawat hanya menyampaikan informasi umum, tidak menyebutkan perubahan kondisi

terbaru, tidak menyampaikan rencana tindakan, atau tidak memberi kesempatan kepada penerima handover untuk bertanya.

Komunikasi yang efektif harus bersifat dua arah. Perawat pemberi handover perlu menyampaikan informasi secara terstruktur, sedangkan perawat penerima handover perlu melakukan klarifikasi apabila ada informasi yang kurang jelas. Prinsip read-back atau repeat-back dapat digunakan untuk memastikan informasi penting telah dipahami dengan benar.

c. Kesalahan pemberian obat

Pemberian obat merupakan salah satu tindakan keperawatan yang berisiko tinggi. Kesalahan dapat terjadi pada tahap peresepan, penyimpanan, penyiapan, pemberian, maupun monitoring efek obat. Perawat bertanggung jawab memastikan prinsip benar obat, benar pasien, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar dokumentasi, benar indikasi, benar edukasi, dan benar evaluasi.

Risiko meningkat pada obat-obatan high-alert, obat dengan nama atau kemasan mirip, obat intravena, insulin, antikoagulan, elektrolit pekat, opioid, sedatif, dan obat kemoterapi. Pada saat handover, informasi tentang obat yang baru diberikan, obat yang ditunda, reaksi alergi, efek samping, dan monitoring lanjutan harus disampaikan secara jelas.

d. Risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan

Infeksi terkait pelayanan kesehatan merupakan salah satu masalah utama keselamatan pasien. Perawat berperan penting dalam pencegahan infeksi melalui kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, teknik aseptik, perawatan luka, perawatan kateter, pengelolaan limbah medis, serta edukasi pasien dan keluarga.

Dalam handover, informasi terkait risiko infeksi harus disampaikan, misalnya status isolasi pasien, hasil kultur, penggunaan antibiotik, kondisi luka, tindakan invasif, dan kebutuhan kewaspadaan transmisi. Kelalaian menyampaikan informasi ini dapat menyebabkan pelanggaran prosedur isolasi atau keterlambatan tindakan pencegahan infeksi.

e. Risiko pasien jatuh

Pasien jatuh dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat, seperti luka, fraktur, perdarahan, kecacatan, bahkan kematian. Risiko jatuh meningkat pada pasien lanjut usia, pasien dengan gangguan kesadaran, pasien pascaoperasi, pasien yang menggunakan obat sedatif, pasien dengan gangguan keseimbangan, dan pasien dengan keterbatasan mobilitas.

Perawat harus melakukan asesmen risiko jatuh sejak awal pasien dirawat dan melakukan asesmen ulang apabila terjadi perubahan kondisi. Informasi

tentang risiko jatuh perlu disampaikan saat handover, termasuk skor risiko jatuh, kebutuhan pendampingan, penggunaan pagar tempat tidur, bel pasien, alat bantu jalan, serta edukasi kepada keluarga.

f. Risiko luka tekan

Luka tekan terjadi akibat tekanan terus-menerus pada area tubuh tertentu, terutama pada pasien tirah baring lama, pasien dengan gangguan mobilitas, pasien dengan status nutrisi buruk, atau pasien dengan gangguan perfusi jaringan. Pencegahan luka tekan merupakan bagian penting dari keselamatan pasien dalam keperawatan.

Informasi tentang kondisi kulit, area kemerahan, jadwal perubahan posisi, penggunaan matras khusus, status nutrisi, dan perawatan luka harus disampaikan secara konsisten saat handover. Apabila informasi ini tidak diteruskan, tindakan pencegahan dapat terputus dan risiko luka tekan meningkat.

g. Risiko keterlambatan respons terhadap perubahan kondisi pasien

Pasien dapat mengalami perubahan kondisi secara cepat, terutama di ruang rawat intensif, ruang gawat darurat, ruang pascaoperasi, atau ruang rawat pasien dengan penyakit akut. Keterlambatan mengenali perubahan tanda vital, penurunan kesadaran, sesak napas, nyeri dada, perdarahan, atau penurunan produksi urine dapat membahayakan pasien.

Perawat harus mampu mengenali tanda perburukan klinis dan menyampaikan informasi tersebut secara cepat kepada tim yang berwenang. Dalam handover, pasien dengan kondisi tidak stabil harus mendapat perhatian khusus dan disampaikan dengan prioritas utama.

4. Handover sebagai Titik Rawan Keselamatan Pasien

Handover merupakan salah satu titik rawan karena terjadi perpindahan tanggung jawab. Pada saat handover, informasi klinis harus berpindah dari satu perawat ke perawat lain secara lengkap dan akurat. Apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, perawat penerima dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang keliru atau tidak utuh.

Risiko handover meningkat apabila:

- a. Tidak ada format standar.
- b. Handover dilakukan terlalu cepat.
- c. Lingkungan terlalu bising.
- d. Banyak interupsi selama handover.
- e. Perawat lelah atau terburu-buru.
- f. Dokumentasi tidak lengkap.
- g. Informasi penting hanya disampaikan secara lisan tanpa catatan.

- h. Tidak ada kesempatan untuk klarifikasi.
- i. Pasien dengan kondisi kritis tidak diprioritaskan.
- j. Tidak ada evaluasi terhadap kualitas handover.

Oleh karena itu, handover harus dipandang sebagai tindakan keselamatan pasien, bukan sekadar rutinitas pergantian shift. Handover yang baik membantu perawat memahami masalah utama pasien, risiko klinis, prioritas tindakan, rencana perawatan, serta tanggung jawab yang harus dilanjutkan.

5. Contoh Informasi Penting yang Harus Disampaikan dalam Handover

Informasi yang perlu disampaikan dalam handover keperawatan antara lain:

Tabel 1. 1 komponen isi handover

Komponen Informasi	Contoh Isi Handover
Identitas pasien	Nama, usia, nomor rekam medis, diagnosis utama
Kondisi terkini	Tanda vital, tingkat kesadaran, keluhan utama
Masalah prioritas	Nyeri, sesak, perdarahan, risiko jatuh, risiko infeksi
Tindakan yang sudah dilakukan	Obat diberikan, perawatan luka, pemasangan infus
Tindakan yang belum selesai	Pemeriksaan laboratorium, pemberian obat berikutnya
Hasil pemeriksaan penting	Laboratorium kritis, radiologi, kultur
Risiko keselamatan	Alergi, high-alert medication, isolasi, risiko jatuh
Respons pasien	Perbaikan, perburukan, efek samping obat
Rencana tindak lanjut	Monitoring, konsultasi dokter, edukasi keluarga
Hal yang harus diwaspadai	Tanda bahaya dan tindakan jika kondisi memburuk

Tabel tersebut menunjukkan bahwa handover yang aman harus lebih dari sekadar menyebut diagnosis dan terapi. Handover harus menggambarkan kondisi pasien secara menyeluruh, terutama aspek yang berkaitan langsung dengan keselamatan.

D. Budaya Keselamatan Pasien sebagai Fondasi Handover Keperawatan yang Efektif

1. Pengertian Budaya Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan pasien adalah nilai, sikap, keyakinan, perilaku, dan kebiasaan organisasi yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Budaya keselamatan tercermin dalam cara tenaga kesehatan berkomunikasi, melaporkan insiden, merespons kesalahan, bekerja sama, mengambil keputusan, dan memperbaiki sistem pelayanan.

Budaya keselamatan yang baik tidak hanya terlihat dari adanya kebijakan tertulis, tetapi juga dari perilaku sehari-hari. Misalnya, perawat berani bertanya ketika instruksi tidak jelas, melakukan konfirmasi sebelum tindakan, melaporkan kejadian nyaris cedera, tidak menyalahkan rekan kerja secara berlebihan, dan bersedia belajar dari kesalahan. Dalam lingkungan seperti ini, handover akan menjadi lebih terbuka, jujur, dan efektif.

WHO menekankan bahwa sistem kesehatan yang aman memerlukan komitmen kepemimpinan, lingkungan kerja yang aman, prosedur klinis yang aman, kompetensi tenaga kesehatan, kerja tim, komunikasi, keterlibatan pasien dan keluarga, serta sistem pelaporan insiden untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. (World Health Organization)

2. Unsur-Unsur Budaya Keselamatan Pasien

a. Kepemimpinan yang berkomitmen

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan pasien melalui kebijakan, pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya, dan evaluasi mutu. Tanpa dukungan pimpinan, keselamatan pasien sering hanya menjadi slogan administratif.

Dalam konteks handover, pimpinan keperawatan perlu memastikan adanya standar operasional prosedur, format komunikasi, jadwal handover yang realistis, lingkungan yang mendukung, serta mekanisme evaluasi. Kepala ruang juga perlu memberi contoh dengan mendukung komunikasi terbuka dan mengurangi budaya menyalahkan.

b. Komunikasi terbuka

Komunikasi terbuka memungkinkan setiap anggota tim menyampaikan kekhawatiran klinis tanpa takut dipermalukan. Dalam handover, komunikasi terbuka berarti perawat pemberi informasi tidak menyembunyikan masalah, sedangkan perawat penerima tidak ragu bertanya apabila ada informasi yang belum jelas.

Komunikasi terbuka sangat penting pada pasien dengan kondisi kompleks. Misalnya, apabila pasien mengalami penurunan tekanan darah pada shift sebelumnya, informasi tersebut harus disampaikan secara jelas, termasuk tindakan yang telah dilakukan dan respons pasien. Menyederhanakan atau mengabaikan informasi kritis dapat membahayakan pasien.

c. Kerja tim

Keselamatan pasien tidak dapat dicapai oleh satu profesi saja. Pelayanan pasien melibatkan perawat, dokter, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, analis laboratorium, radiografer, petugas administrasi, pasien, dan keluarga. Oleh karena itu, kerja tim menjadi unsur penting dalam budaya keselamatan.

Handover keperawatan merupakan bagian dari kerja tim internal perawat. Namun, hasil handover juga berpengaruh terhadap koordinasi dengan profesi lain. Jika perawat menerima informasi yang lengkap, ia dapat menyampaikan kondisi pasien kepada dokter dengan lebih tepat dan mengambil tindakan keperawatan secara lebih terarah.

d. Pelaporan insiden tanpa rasa takut

Budaya keselamatan mendorong pelaporan insiden sebagai proses belajar. Perawat perlu merasa aman untuk melaporkan kesalahan, kejadian nyaris cedera, atau kondisi berisiko. Jika pelaporan selalu diikuti dengan hukuman, staf akan cenderung menyembunyikan insiden. Akibatnya, organisasi kehilangan kesempatan untuk memperbaiki sistem.

Pelaporan insiden harus dilihat sebagai langkah profesional. Misalnya, jika terjadi kejadian nyaris cedera karena informasi obat tidak tersampaikan saat handover, maka fokus perbaikan bukan hanya pada perawat yang lupa, tetapi juga pada sistem handover: apakah format sudah jelas, apakah obat high-alert diberi kolom khusus, apakah ada proses konfirmasi, dan apakah dokumentasi mudah diakses.

e. Pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan

Budaya keselamatan menuntut organisasi untuk terus belajar. Setiap insiden harus dianalisis, dicari akar masalahnya, kemudian diikuti dengan tindakan perbaikan. Perbaikan dapat berupa revisi SOP, pelatihan ulang, penggunaan checklist, perubahan alur kerja, atau penguatan supervisi.

Dalam handover, perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui audit kelengkapan informasi, observasi proses handover, diskusi kasus, simulasi SBAR, dan evaluasi kepuasan perawat terhadap sistem handover.

3. Hubungan Budaya Keselamatan dengan Handover Keperawatan

Handover yang efektif tidak hanya bergantung pada format, tetapi juga pada budaya kerja. Format SBAR atau ISBAR tidak akan berjalan optimal jika perawat tidak memiliki kebiasaan komunikasi terbuka, tidak mau bertanya, takut melaporkan masalah, atau menganggap handover sebagai formalitas.

Budaya keselamatan membuat handover menjadi proses yang bermakna. Perawat tidak sekadar “mengoperkan pasien”, tetapi benar-benar memastikan bahwa perawat berikutnya memahami kondisi pasien, risiko yang harus diwaspadai, dan tindakan yang harus dilanjutkan. Dalam budaya keselamatan yang baik, handover menjadi ruang untuk berpikir klinis bersama, memprioritaskan pasien berisiko tinggi, dan mencegah kesalahan sebelum terjadi.

4. Strategi Membangun Budaya Keselamatan dalam Handover

a. Menggunakan format komunikasi standar

Penggunaan format standar membantu memastikan informasi penting tidak terlewat. Format yang sering digunakan adalah SBAR atau ISBAR. SBAR terdiri dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Dalam praktik keperawatan, format ini dapat membantu perawat menyampaikan informasi secara ringkas, logis, dan mudah dipahami. (ahrq.gov)

Contoh penerapan SBAR dalam handover:

Tabel 1. 2 Komponen SBAR

Komponen SBAR	Contoh Isi
Situation	Pasien Ny. A, 65 tahun, dirawat dengan pneumonia. Saat ini pasien masih sesak ringan.
Background	Riwayat hipertensi dan diabetes. Masuk hari kedua. Terpasang oksigen nasal kanul 3 liter/menit.
Assessment	Tanda vital terakhir: TD 140/90 mmHg, Nadi 96 kali/menit, RR 26 kali/menit, SpO ₂ 94%. Masih tampak lemah.
Recommendation	Mohon monitor pola napas tiap 2 jam, observasi SpO ₂ , dan laporkan bila SpO ₂ turun di bawah 92%.

b. Mengurangi interupsi saat handover

Interupsi dapat menyebabkan informasi terputus atau terlupakan. Ruang handover sebaiknya dibuat kondusif, tidak terlalu bising, dan tidak dipenuhi percakapan yang tidak relevan. Jika handover dilakukan di dekat pasien, perawat tetap harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi.

c. Memberi kesempatan klarifikasi

Handover yang aman harus memberikan kesempatan kepada penerima informasi untuk bertanya. Klarifikasi penting untuk memastikan tidak ada informasi yang disalahpahami. Perawat penerima handover dapat menanyakan hal seperti: "Obat antibiotik terakhir diberikan jam berapa?", "Apakah pasien sudah diedukasi risiko jatuh?", atau "Apa rencana jika tekanan darah kembali turun?"

d. Memprioritaskan pasien berisiko tinggi

Tidak semua pasien memiliki tingkat risiko yang sama. Pasien kritis, pasien pascaoperasi, pasien dengan obat high-alert, pasien risiko jatuh tinggi, pasien dengan alergi berat, atau pasien dengan perubahan kondisi harus menjadi prioritas dalam handover. Informasi tentang pasien-pasien ini harus disampaikan lebih rinci.

e. Mengintegrasikan handover dengan dokumentasi

Handover lisan harus didukung oleh dokumentasi tertulis atau elektronik. Dokumentasi membantu memastikan informasi dapat ditelusuri kembali. Namun, dokumentasi tidak boleh menggantikan komunikasi lisan sepenuhnya, terutama untuk informasi kritis yang membutuhkan penekanan dan klarifikasi.

f. Melibatkan pasien dan keluarga secara proporsional

Pada beberapa situasi, bedside handover dapat melibatkan pasien dan keluarga agar mereka memahami rencana perawatan dan dapat mengoreksi informasi yang kurang tepat. Namun, pelibatan pasien harus mempertimbangkan privasi, kondisi klinis, kesiapan pasien, serta jenis informasi yang disampaikan.

5. Tantangan Penerapan Keselamatan Pasien dalam Keperawatan

Walaupun konsep keselamatan pasien sudah dikenal luas, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam pelayanan keperawatan antara lain:

- a. Beban kerja perawat yang tinggi.
- b. Jumlah pasien tidak seimbang dengan jumlah perawat.
- c. Dokumentasi yang banyak dan memakan waktu.
- d. Kurangnya pelatihan komunikasi efektif.
- e. Kebiasaan handover yang belum terstandar.

- f. Budaya menyalahkan ketika terjadi insiden.
- g. Kurangnya supervisi dari kepala ruang.
- h. Fasilitas dan teknologi pendukung yang belum optimal.
- i. Kurangnya keterlibatan pasien dan keluarga.
- j. Perbedaan kemampuan komunikasi antarstaf.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan pasien tidak dapat dicapai hanya dengan meminta perawat lebih berhati-hati. Organisasi perlu memperbaiki sistem, menyediakan pelatihan, menguatkan budaya keselamatan, dan memastikan bahwa setiap proses keperawatan mendukung pelayanan yang aman.

6. Peran Perawat dalam Keselamatan Pasien

Perawat memiliki peran penting dalam keselamatan pasien karena berada paling dekat dengan pasien. Peran tersebut meliputi:

a. Sebagai pemberi asuhan

Perawat memberikan asuhan langsung kepada pasien. Setiap tindakan harus dilakukan sesuai standar, berdasarkan asesmen, dan terdokumentasi dengan baik.

b. Sebagai pengamat kondisi pasien

Perawat memantau perubahan kondisi pasien secara berkelanjutan. Kemampuan mengenali tanda bahaya sangat penting untuk mencegah keterlambatan tindakan.

c. Sebagai komunikator

Perawat menyampaikan informasi kepada pasien, keluarga, perawat lain, dokter, dan tim kesehatan. Komunikasi yang efektif menjadi dasar keselamatan pasien.

d. Sebagai edukator

Perawat memberikan edukasi mengenai pengobatan, pencegahan jatuh, kebersihan tangan, diet, aktivitas, perawatan luka, dan tanda bahaya yang harus diperhatikan.

e. Sebagai advokat pasien

Perawat membela kepentingan pasien ketika ada risiko, ketidakjelasan instruksi, atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat harus berani menyampaikan kekhawatiran klinis demi keselamatan pasien.

f. Sebagai pelapor dan pembelajar

Perawat harus melaporkan insiden, kejadian nyaris cedera, dan kondisi berisiko. Pelaporan tersebut menjadi dasar pembelajaran organisasi.

E. Simpulan

Keselamatan pasien merupakan inti dari pelayanan keperawatan yang bermutu. Dalam praktik keperawatan, keselamatan pasien tidak hanya berarti mencegah cedera, tetapi juga membangun sistem asuhan yang aman melalui asesmen risiko, komunikasi efektif, dokumentasi akurat, pencegahan infeksi, keamanan obat, pencegahan jatuh, serta pelaporan dan pembelajaran dari insiden.

Perawat memiliki peran strategis karena berada di garis depan pelayanan dan berinteraksi langsung dengan pasien selama proses perawatan. Oleh sebab itu, setiap tindakan keperawatan harus dilakukan dengan kesadaran keselamatan. Tindakan sederhana seperti memverifikasi identitas pasien, mencuci tangan, memastikan obat, mendokumentasikan tindakan, memantau perubahan kondisi, dan menyampaikan informasi secara lengkap saat handover memiliki kontribusi besar terhadap keselamatan pasien.

Handover keperawatan merupakan salah satu titik penting dalam keselamatan pasien karena pada saat itulah informasi, tanggung jawab, dan kewenangan asuhan berpindah dari satu perawat kepada perawat lain. Handover yang tidak efektif dapat menyebabkan informasi penting hilang, terjadi miskomunikasi, keterlambatan tindakan, kesalahan obat, dan meningkatnya risiko cedera pasien. Sebaliknya, handover yang efektif mendukung kontinuitas asuhan, memperkuat kerja tim, dan membantu perawat mengambil keputusan yang tepat.

Budaya keselamatan pasien menjadi fondasi utama agar handover berjalan efektif. Budaya tersebut mencakup komunikasi terbuka, kerja tim, pelaporan insiden tanpa rasa takut, kepemimpinan yang mendukung, serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan budaya keselamatan yang kuat, handover tidak lagi dipandang sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai proses klinis yang menentukan keberlangsungan dan keamanan asuhan pasien.

Referensi

- Azyabi, A., Karwowski, W., & Davahli, M. R. (2021). Assessing patient safety culture in hospital settings. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 2466. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052466>
- Bates, D. W., Levine, D. M., Salmasian, H., Syrowatka, A., Shahian, D. M., Lipsitz, S., Zebrowski, J. P., Myers, L. C., Logan, M. S., & Roy, C. L. (2023). The safety of inpatient health care. *The New England Journal of Medicine*, 388(2), 142–153. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa2206117>
- Dall'Ora, C., Saville, C., Rubbo, B., Turner, L., Jones, J., & Griffiths, P. (2022). Nurse staffing levels and patient outcomes: A systematic review of longitudinal studies. *International Journal of Nursing Studies*, 134, 104311. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104311>
- Hodkinson, A., Zhou, A., Johnson, J., Geraghty, K., Riley, R., Zhou, A., Panagopoulou, E., Chew-Graham, C. A., Peters, D., Esmail, A., & Panagioti, M. (2022). Associations of physician burnout with career engagement and quality of patient care: Systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 378, e070442. <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-070442>
- Jun, J., Ojemeni, M. M., Kalamani, R., Tong, J., & Crecelius, M. L. (2021). Relationship between nurse burnout, patient and organizational outcomes: Systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 119, 103933. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103933>
- Lasater, K. B., Aiken, L. H., Sloane, D. M., French, R., Martin, B., Reneau, K., Alexander, M., & McHugh, M. D. (2021). Chronic hospital nurse understaffing meets COVID-19: An observational study. *BMJ Quality & Safety*, 30(8), 639–647. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2020-011512>
- Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., Cameron, I. D., Camicioli, R., Clemson, L., Close, J., Delbaere, K., Duan, L., Duque, G., Dyer, S. M., ... Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. (2022). World guidelines for falls prevention and management for older adults: A global initiative. *Age and Ageing*, 51(9), afac205. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac205>
- Morris, M. E., Webster, K., Jones, C., Hill, A. M., Haines, T., McPhail, S., Jazayeri, D., Heng, H., Shorr, R. I., Carey, L., Barker, A. L., & Cameron, I. D. (2022). Interventions to reduce falls in hospitals: A systematic review and meta-analysis. *Age and Ageing*, 51(5), afac077. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac077>
- Ocloo, J., Garfield, S., Franklin, B. D., & Dawson, S. (2021). Exploring the theory, barriers and enablers for patient and public involvement across health,

social care and patient safety: A systematic review of reviews. *Health Research Policy and Systems*, 19, 8. <https://doi.org/10.1186/s12961-020-00644-3>

- Shi, C., Dumville, J. C., Cullum, N., Rhodes, S., Jammali-Blasi, A., & McInnes, E. (2021). Beds, overlays and mattresses for preventing and treating pressure ulcers: An overview of Cochrane Reviews and network meta-analysis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(8), CD013761.
- Tartari, E., Tomczyk, S., Pires, D., Zayed, B., Coutinho Rehse, A. P., Kariyo, P., Stempliuk, V., Zingg, W., Pittet, D., & Allegranzi, B. (2021). Implementation of the infection prevention and control core components at the national level: A global situational analysis. *Journal of Hospital Infection*, 108, 94–103.
- Tomczyk, S., Twyman, A., de Kraker, M. E. A., Rehse, A. P. C., Tartari, E., Toledo, J. P., Cassini, A., Pittet, D., & Allegranzi, B. (2022). The first WHO global survey on infection prevention and control in health-care facilities. *The Lancet Infectious Diseases*, 22(6), 845–856.

Glosarium

Istilah	Pengertian
Keselamatan pasien	Sistem pelayanan yang bertujuan mencegah cedera yang dapat dicegah dan mengurangi risiko bahaya dalam pelayanan kesehatan.
Handover keperawatan	Proses pengalihan informasi, tanggung jawab, dan kewenangan asuhan dari satu perawat kepada perawat lain.
Insiden keselamatan pasien	Kejadian atau kondisi yang dapat menimbulkan atau telah menimbulkan cedera pada pasien.
Kejadian tidak diharapkan	Insiden yang menyebabkan cedera pada pasien akibat pelayanan kesehatan.
Kejadian nyaris cedera	Kejadian yang hampir mencederai pasien tetapi berhasil dicegah sebelum sampai kepada pasien.
Kejadian tidak cedera	Insiden yang sudah terjadi pada pasien tetapi tidak menimbulkan cedera.
Kondisi potensial cedera	Situasi yang berisiko menimbulkan cedera apabila tidak segera diperbaiki.
Budaya keselamatan pasien	Nilai, sikap, dan perilaku organisasi yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
Komunikasi efektif	Proses penyampaian informasi secara jelas, akurat, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipahami.
SBAR	Kerangka komunikasi yang terdiri dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation.
ISBAR	Pengembangan SBAR yang menambahkan komponen Identification sebelum Situation.
Identifikasi pasien	Proses memastikan identitas pasien secara benar sebelum tindakan, obat, pemeriksaan, atau prosedur dilakukan.
High-alert medication	Obat yang memiliki risiko tinggi menimbulkan cedera serius apabila terjadi kesalahan penggunaan.
Risiko jatuh	Kemungkinan pasien mengalami jatuh selama berada di fasilitas pelayanan kesehatan.
Infeksi terkait pelayanan kesehatan	Infeksi yang terjadi selama pasien menerima pelayanan kesehatan dan tidak ada sebelumnya saat masuk fasilitas kesehatan.

Istilah	Pengertian
Luka tekan	Kerusakan kulit atau jaringan akibat tekanan berkepanjangan, biasanya pada pasien dengan mobilitas terbatas.
Dokumentasi keperawatan	Catatan tertulis atau elektronik mengenai kondisi pasien, tindakan, respons pasien, dan rencana asuhan.
Kontinuitas asuhan	Keberlanjutan pelayanan pasien secara terkoordinasi antarshift, antarunit, atau antarprofesi.
Read-back	Teknik mengulang kembali instruksi atau informasi penting untuk memastikan kebenaran pemahaman.
Repeat-back	Teknik mengulang informasi yang diterima sebagai bentuk konfirmasi komunikasi.
Just culture	Budaya organisasi yang menyeimbangkan akuntabilitas individu dengan pembelajaran sistem tanpa menyalahkan secara berlebihan.
Root cause analysis	Analisis akar penyebab insiden untuk mengetahui faktor utama yang menyebabkan kejadian.
Asesmen risiko	Proses menilai kemungkinan terjadinya bahaya pada pasien.
Patient-centered care	Pelayanan yang menempatkan kebutuhan, nilai, preferensi, dan keselamatan pasien sebagai pusat asuhan.
Mutu pelayanan	Tingkat pelayanan kesehatan dalam memenuhi standar, kebutuhan pasien, keamanan, efektivitas, dan efisiensi.



CHAPTER 2



PENGERTIAN DAN TUJUAN HANDOVER KEPERAWATAN

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan

Handover keperawatan merupakan proses komunikasi dan serah terima tanggung jawab pasien antar perawat pada setiap pergantian shift maupun perpindahan unit pelayanan. Proses ini memiliki peranan penting dalam menjaga kesinambungan asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta mutu pelayanan rumah sakit. Dalam praktiknya, handover tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi klinis, tetapi juga sebagai sarana koordinasi antar tenaga kesehatan dalam menentukan tindakan lanjutan bagi pasien. Penggunaan komunikasi efektif berbasis SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) pada handover mampu meningkatkan akurasi informasi dan mengurangi risiko kesalahan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa handover yang dilakukan secara terstruktur berkontribusi terhadap peningkatan *patient safety* dan kualitas pelayanan keperawatan. Pelaksanaan handover di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu, komunikasi yang tidak lengkap, dokumentasi yang kurang jelas, serta gangguan lingkungan kerja yang dapat menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan secara optimal (Pratama & Maryani, 2026).

Permasalahan dalam pelaksanaan handover menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Banyak perawat mengalami kesulitan dalam menyampaikan kondisi pasien secara sistematis akibat beban kerja yang tinggi, kurangnya standar komunikasi, serta minimnya pelatihan terkait handover efektif (Saefulloh et al., 2020). Hasil penelitian bahwa komunikasi SBAR dalam handover memiliki hubungan signifikan dengan pelaksanaan indikator keselamatan pasien. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas komunikasi saat handover sangat memengaruhi keberhasilan penerapan *patient safety* di rumah sakit (Yetti et al., 2021). Selain itu dijelaskan bahwa handover yang tidak efektif dapat menyebabkan miskomunikasi antar perawat, keterlambatan tindakan, kesalahan pemberian obat, hingga penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik dan penggunaan

metode handover terstruktur menjadi kebutuhan penting dalam praktik keperawatan modern.

Perkembangan penelitian terbaru tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas handover keperawatan semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dan supervisi berkelanjutan. Penggunaan *Electronic Medical Record* (EMR) dalam *bedside handover* berbasis SBAR mampu meningkatkan efektivitas komunikasi, ketepatan dokumentasi, serta keselamatan pasien (Siswadi et al., n.d.). Penelitian lain menegaskan bahwa pelatihan komunikasi terstruktur dan supervisi rutin berpengaruh positif terhadap kualitas handover dan kinerja perawat di rumah sakit. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa handover bukan sekadar rutinitas pergantian shift, tetapi merupakan strategi penting untuk mencegah kesalahan medis, meningkatkan keselamatan pasien, memperkuat koordinasi antarprofesi, dan mendukung mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Kavitha et al., 2026).

B. Pengertian Umum Handover Keperawatan

Handover keperawatan (serah terima pasien) merupakan suatu proses komunikasi klinis yang terstruktur dalam praktik keperawatan, yang bertujuan untuk mentransfer informasi penting, tanggung jawab, dan akuntabilitas perawatan pasien dari satu perawat kepada perawat lainnya, terutama pada pergantian shift. Proses ini mencakup penyampaian kondisi terkini pasien, tindakan yang telah dilakukan, serta rencana asuhan keperawatan selanjutnya guna menjamin kesinambungan pelayanan (Keebler et al., 2023).

Secara konseptual, handover dipahami sebagai suatu kegiatan fundamental dalam pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan interaksi profesional untuk memastikan kejelasan data klinis dan pengambilan keputusan yang tepat. Handover menjadi titik kritis dalam sistem pelayanan karena berkaitan langsung dengan transfer tanggung jawab dan keselamatan pasien (Sharplin et al., 2019).

Dalam praktik keperawatan sehari-hari, handover biasanya dilakukan antar shift (*shift-to-shift handover*), di mana perawat yang selesai bertugas menyampaikan informasi secara sistematis kepada perawat yang akan melanjutkan perawatan pasien. Proses ini mencakup diagnosis, kondisi klinis, terapi, serta prioritas tindakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, handover menjadi mekanisme utama untuk menjaga *continuity of care* dan mencegah terjadinya kesalahan pelayanan akibat miskomunikasi (Commission & Care, 2021).

C. Pengertian Handover menurut Organisasi dan Literatur

1. Definisi menurut World Health Organization

World Health Organization (WHO), tidak selalu memberikan definisi tunggal yang sangat operasional dalam satu kalimat, tetapi melalui *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030*, WHO menegaskan bahwa handover merupakan bagian dari komunikasi kritis dalam transisi pelayanan yang melibatkan transfer informasi pasien secara aman untuk menjamin kesinambungan perawatan dan keselamatan pasien. Dalam konteks ini, *handover* dipahami sebagai: a) Proses komunikasi antar tenaga kesehatan saat terjadi perpindahan perawatan, b) Transfer informasi klinis yang akurat dan tepat waktu dan c) Komponen utama dalam strategi keselamatan pasien global. WHO menekankan bahwa handover bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga intervensi keselamatan pasien (*patient safety intervention*) yang harus dilakukan secara sistematis (WHO, 2021).

WHO menempatkan handover sebagai bagian dari komunikasi kritis dalam transisi pelayanan (*transition of care*). Handover dipahami sebagai proses penyampaian informasi pasien secara aman, akurat, dan tepat waktu saat terjadi perpindahan tanggung jawab pelayanan. Makna penting menurut WHO, bahwa handover bukan sekadar laporan rutin, tetapi strategi keselamatan pasien global. Fokusnya pada akurasi informasi, Ketepatan waktu, Kelengkapan data klinis. Hal ini dikarenakan handover terjadi pada setiap transisi yaitu antar shift perawat, antar unit (IGD ke ruang rawat) bahkan antar penanggung jawab fasilitas Kesehatan. Jika handover tidak efektif, maka risiko *adverse event* meningkatkan berbagai masalah pada pasien (WHO, 2021).

2. Definisi menurut Joint Commission International

Menurut standar *Joint Commission International*, *handover (handoff)* didefinisikan sebagai proses komunikasi yang terjadi ketika terdapat transfer tanggung jawab perawatan pasien antar tenaga kesehatan atau antar unit pelayanan. Dalam standar JCI dijelaskan bahwa handover terjadi pada situasi a) Antar tenaga kesehatan (misalnya perawat ke perawat), b) Antar unit (ICU ke ruang rawat) dan c) Antar tingkat pelayanan (Keebler et al., 2023).

Penekanan utama dari JCI dalam kegiatan handover meliputi beberapa hal, diantaranya: 1) Handover wajib memiliki proses yang terstruktur, b) diharapkan terjadi transfer tanggung jawab dan akuntabilitas dan c) Merupakan bagian dari standar keselamatan pasien rumah sakit (Sriningsih et al., 2020).

JCI mendefinisikan handover (*handoff*) sebagai proses komunikasi saat terjadi transfer tanggung jawab dan akuntabilitas perawatan pasien antar tenaga kesehatan atau unit pelayanan. Penekanan utama JCI pada Handover harus

terstruktur (misalnya menggunakan SBAR), interaktif (ada kesempatan bertanya) serta lengkap dan jelas. Selain itu bahwa handover, disarankan tidak hanya serah terima informasi, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab (ketua tim) dan apa rencana tindakan pada shift berikutnya. Diharapkan handover merupakan proses transfer tanggung jawab profesional, bukan hanya "laporan pasien" (Pun, 2021).

3. Definisi menurut Literatur (2021–2026)

Beberapa literatur terbaru memberikan definisi yang lebih operasional tentang handover, diantaranya :

- a. Handover adalah proses saat tanggung jawab perawatan pasien berpindah dari satu tim ke tim lain dengan penyampaian informasi yang akurat (Joint Commission International, 2007).
- b. Handover merupakan pertukaran informasi klinis dan transfer tanggung jawab serta aspek legal pasien antar tenaga kesehatan (Pun, 2021).
- c. Handover adalah peristiwa komunikasi berisiko tinggi karena melibatkan transfer akuntabilitas pasien (Commission & Care, 2021).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa handover adalah:

- a. Proses komunikasi klinis berisiko tinggi

Menurut penelitian menyebutkan bahwa, handover merupakan momen kritis karena terjadi perpindahan tanggung jawab, rentan miskomunikasi dan menjadi penyebab utama insiden keselamatan pasien.

- b. Transfer informasi, tanggung jawab dan keputusan klinis

Sebagian besar Literatur menambahkan bahwa handover bukan hanya menyampaikan data, tetapi juga interpretasi kondisi pasien, transfer prioritas masalah dan perpindahan rencana Tindakan. Jadi, handover adalah clinical reasoning yang dikomunikasikan antara 2 atau lebih shift perawat yang bertugas dalam 1 hari. Beberapa literatur terbaru memberikan definisi yang lebih operasional. Dalam handover diatur dan megandung beberapa unsur berikut ini:

1) Transfer informasi klinis

Transfer informasi klinis dalam handover merujuk pada proses penyampaian data penting terkait kondisi pasien secara lengkap dan akurat, seperti diagnosis, tanda vital, hasil pemeriksaan, terapi yang telah diberikan, serta respon pasien terhadap tindakan. Informasi ini harus disampaikan secara sistematis agar perawat penerima dapat memahami kondisi pasien secara menyeluruh tanpa kehilangan data penting. Ketepatan dan kelengkapan informasi klinis sangat menentukan keberlanjutan asuhan serta mencegah terjadinya kesalahan medis akibat miskomunikasi (Lazzari & Rabottini, 2025).

2) Transfer tanggung jawab dan akuntabilitas

Handover juga mencerminkan perpindahan tanggung jawab dan akuntabilitas dari perawat yang telah menyelesaikan shift kepada perawat yang akan melanjutkan perawatan. Artinya, setelah handover dilakukan, perawat penerima memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab penuh terhadap kondisi dan keselamatan pasien. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki aspek legal dan etis, sehingga harus dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin keamanan pasien (Djajasasana et al., 2024).

3) Proses komunikasi profesional

Handover merupakan bentuk komunikasi profesional yang melibatkan interaksi antar tenaga kesehatan secara terstruktur, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Komunikasi ini menuntut penggunaan bahasa yang jelas, tidak ambigu, serta didukung oleh metode standar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Dengan komunikasi yang baik, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan dan pengambilan keputusan klinis menjadi lebih tepat (Moss-sherman, 2025).

4) Tujuan utama: keselamatan dan kesinambungan perawatan

Tujuan utama dari handover adalah menjamin keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan (*continuity of care*). Melalui handover yang efektif, setiap perubahan kondisi pasien dapat dipantau secara berkelanjutan tanpa adanya jeda informasi, sehingga risiko insiden keselamatan dapat diminimalkan. Selain itu, kesinambungan perawatan memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan yang konsisten, terkoordinasi, dan berkualitas tinggi selama proses perawatan berlangsung (Kavitha et al., 2026).

D. Tujuan Handover Keperawatan

Handover keperawatan merupakan proses penting dalam praktik profesional yang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan rutin pergantian shift, tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam menjamin kualitas dan keselamatan pelayanan pasien. Handover yang dilakukan secara sistematis dengan metode komunikasi SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dan menurunkan risiko kesalahan pelayanan pada pasien. Selain itu, handover yang optimal dapat meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan serta memperkuat mutu pelayanan keperawatan di rumah

sakit (Chien et al., 2022). Oleh karena itu, setiap tujuan handover memiliki makna yang mendalam dalam praktik klinis, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Menjamin Kesenambungan Asuhan Keperawatan (*Continuity of Care*)

Salah satu tujuan utama handover adalah memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien berlangsung secara berkesinambungan tanpa terputus. Dalam praktik klinis, pasien seringkali dirawat oleh beberapa perawat secara bergantian sesuai dengan sistem shift. Tanpa adanya handover yang efektif, informasi penting mengenai kondisi pasien, intervensi yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut dapat hilang atau tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pelayanan. Handover yang didukung dokumentasi elektronik (*Electronic Medical Record/EMR*) mampu meningkatkan kontinuitas pelayanan dan ketepatan informasi pasien selama pergantian shift (Tiorentap, 2020).

Konsep *continuity of care* menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara konsisten dan terintegrasi dari waktu ke waktu. Melalui handover yang baik, setiap perawat yang melanjutkan perawatan memiliki pemahaman yang utuh terhadap kondisi pasien, sehingga asuhan yang diberikan tetap selaras dengan tujuan perawatan sebelumnya. Dengan demikian, pasien tidak mengalami perubahan arah perawatan yang tidak perlu, dan proses penyembuhan dapat berjalan optimal (Tatiwakeng, R.V., Mayulu, N & Larira, 2021).

2. Meningkatkan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Handover memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam banyak kasus, kesalahan dalam pelayanan kesehatan seringkali terjadi akibat kegagalan komunikasi saat perpindahan tanggung jawab, termasuk pada saat handover. Kesalahan tersebut dapat berupa *medication error*, tindakan yang tidak sesuai, atau bahkan keterlambatan dalam penanganan kondisi kritis. Komunikasi SBAR dalam handover memiliki hubungan signifikan dengan pelaksanaan indikator keselamatan pasien dengan nilai *p-value* 0,000 (Saefulloh et al., 2020).

Melalui handover yang dilakukan secara sistematis dan lengkap, informasi penting seperti alergi obat, perubahan kondisi klinis, serta tindakan yang harus segera dilakukan dapat disampaikan dengan jelas. Hal ini membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat membahayakan pasien. Oleh karena itu, handover tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai bagian integral dari sistem keselamatan pasien yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian (Aly et al., 2023).

3. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan

Handover juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan, khususnya antar perawat. Dalam praktiknya, komunikasi yang tidak terstruktur seringkali menyebabkan informasi penting terlewatkan atau disampaikan secara tidak jelas (Tatiwakeng, R.V., Mayulu, N & Larira, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang sistematis, seperti metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), untuk memastikan bahwa informasi disampaikan secara lengkap dan mudah dipahami. Penggunaan metode SBAR terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi antarperawat selama proses timbang terima pasien (Chaica & Marques, 2024).

Komunikasi yang efektif memungkinkan terjadinya klarifikasi informasi, diskusi klinis, serta pertanyaan yang dapat memperjelas kondisi pasien. Dengan demikian, risiko miskomunikasi dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, handover menjadi sarana interaksi profesional yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat koordinasi tim dalam memberikan pelayanan yang optimal (Dúason et al., 2021).

4. Memastikan Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Profesional

Tujuan lain dari handover adalah memastikan adanya kejelasan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam perawatan pasien. Ketika terjadi pergantian shift, tanggung jawab terhadap pasien berpindah dari perawat yang menyerahkan kepada perawat yang menerima. Proses ini harus dilakukan secara jelas agar tidak terjadi ambiguitas mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi pasien pada waktu tertentu (Ghosh & Ramamoorthy, 2021). Handover yang dilakukan dengan komunikasi terstruktur mampu meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab perawat dalam memberikan pelayanan.

Perawat yang menerima handover diharapkan memahami kondisi pasien secara menyeluruh, termasuk masalah yang sedang dihadapi dan rencana perawatan yang harus dilanjutkan. Selain itu, handover juga memiliki implikasi hukum dan etika, karena setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dengan demikian, handover berfungsi sebagai mekanisme formal dalam menjamin akuntabilitas pelayanan keperawatan (Soed et al., 2025).

5. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

Handover yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Ketika informasi disampaikan secara lengkap dan jelas, perawat yang menerima tidak perlu mengulang pengkajian yang sama atau mencari informasi tambahan yang seharusnya sudah tersedia. Hal ini dapat menghemat waktu dan memungkinkan perawat untuk segera fokus pada

tindakan yang diperlukan. Handover yang efektif dapat mempercepat koordinasi pelayanan dan meningkatkan efisiensi kerja perawat di ruang rawat inap.

Selain itu, handover yang efektif membantu mempercepat proses pengambilan keputusan klinis, terutama pada kondisi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Dengan informasi yang akurat dan terkini, perawat dapat menentukan prioritas tindakan secara tepat. Perawat dan tim pelayanan idealnya menyadari bahwa, handover tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mendukung penggunaan sumber daya secara optimal dalam lingkungan pelayanan klinis (Saefulloh et al., 2020).

6. Mendukung Pengambilan Keputusan Klinis

Handover merupakan salah satu sumber utama informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan klinis. Informasi yang disampaikan selama handover mencakup data objektif dan subjektif pasien, hasil pengkajian, serta respons terhadap terapi yang telah diberikan. Data ini menjadi dasar bagi perawat dalam melakukan *clinical judgment* terhadap kondisi pasien. Dokumentasi handover berbasis EMR membantu meningkatkan ketepatan informasi klinis yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan keperawatan (Kavitha et al., 2026).

Pengambilan keputusan klinis yang tepat sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima. Jika informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak akurat, maka keputusan yang diambil berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebaliknya, handover yang dilakukan secara komprehensif akan mendukung perawat dalam menentukan intervensi yang tepat, mengantisipasi risiko, serta merencanakan tindakan yang efektif. Dengan demikian, handover memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara keseluruhan (Saputra, 2024).

E. Relevansi Handover dalam Praktik Keperawatan Modern

Dalam praktik keperawatan modern, handover memiliki relevansi yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan dan kebutuhan akan koordinasi multidisiplin. Handover tidak lagi dipandang sebagai aktivitas rutin pergantian shift, melainkan sebagai proses komunikasi klinis yang krusial dalam menjaga kesinambungan asuhan pasien (Wang et al., 2025). Dalam lingkungan pelayanan yang dinamis, di mana pasien dapat berpindah antar unit dan ditangani oleh berbagai tenaga kesehatan, handover menjadi penghubung utama dalam memastikan bahwa informasi penting tetap tersampaikan secara utuh. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas handover berpengaruh langsung terhadap

kontinuitas pelayanan dan kualitas asuhan keperawatan, sehingga praktik ini menjadi bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan modern (Lestari et al., 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan turut memperkuat relevansi handover, terutama melalui penggunaan sistem elektronik seperti *electronic nursing handover*. Sistem ini memungkinkan penyampaian informasi pasien secara lebih akurat, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh tenaga Kesehatan (Halimatussakdiah et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan handover berbasis elektronik dapat meningkatkan efisiensi komunikasi serta mengurangi kehilangan informasi klinis, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan keselamatan pasien. Di sisi lain, penggunaan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR atau ISBAR juga menjadi standar dalam praktik modern karena terbukti mampu meningkatkan kejelasan komunikasi, mengurangi miskomunikasi, serta mendukung transisi perawatan yang aman dan efektif (Lazzari & Rabottini, 2025).

Lebih jauh lagi, handover memiliki peran strategis dalam mendukung budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan modern, handover dianggap sebagai titik kritis yang berisiko tinggi terhadap terjadinya kesalahan jika tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas handover menjadi fokus dalam berbagai kebijakan dan standar pelayanan kesehatan global. Penelitian terbaru menegaskan bahwa komunikasi handover yang efektif tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien dan profesionalisme tenaga kesehatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa handover merupakan komponen esensial dalam praktik keperawatan modern yang berkontribusi terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlangsungan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Pratama & Maryani, 2026).

F. Dampak Handover yang Tidak Efektif

Handover yang tidak efektif memiliki dampak serius terhadap keselamatan pasien, terutama dalam meningkatkan risiko terjadinya kesalahan medis (*medical error*). Ketika informasi klinis tidak disampaikan secara lengkap, akurat, atau jelas, maka perawat yang menerima tanggung jawab dapat mengambil keputusan yang tidak tepat. Misalnya, ketidaksampaian informasi terkait alergi obat, perubahan kondisi pasien, atau instruksi terapi dapat menyebabkan kesalahan pemberian obat (*medication error*), tindakan yang tidak sesuai, maupun keterlambatan intervensi. Dalam praktik klinis, situasi ini sering terjadi akibat komunikasi yang terburu-buru,

tidak terstruktur, atau kurangnya kesempatan untuk klarifikasi. Handover yang tidak optimal menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kesalahan medis di fasilitas pelayanan Kesehatan (Ghosh & Ramamoorthy, 2021).

Selain itu, handover yang tidak efektif juga berdampak pada penurunan mutu pelayanan keperawatan. Mutu pelayanan sangat ditentukan oleh kesinambungan dan konsistensi asuhan yang diberikan kepada pasien. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan baik, maka terjadi ketidaksinambungan dalam perawatan, seperti pengulangan tindakan yang tidak perlu, ketidaktepatan prioritas intervensi, atau bahkan pengabaian masalah pasien yang penting. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses penyembuhan pasien, tetapi juga mencerminkan rendahnya kualitas koordinasi antar tenaga kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi citra profesionalisme perawat dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan (Pun, 2021).

Lebih jauh lagi, handover yang tidak efektif berpotensi menimbulkan insiden keselamatan pasien (*patient safety incidents*) serta berdampak negatif terhadap kepuasan pasien. Kesalahan komunikasi pada saat handover dapat menyebabkan kejadian tidak diharapkan, seperti cedera pasien, komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah, hingga perpanjangan masa rawat inap. Dari perspektif pasien, pelayanan yang tidak konsisten dan kurang terkoordinasi dapat menimbulkan rasa tidak aman, kebingungan, dan ketidakpercayaan terhadap tenaga kesehatan. Akibatnya, tingkat kepuasan pasien menurun karena mereka merasa kebutuhan dan kondisi kesehatannya tidak ditangani secara optimal. Setiap tim pelaksana pelayanan keperawatan diruangan, diharapkan menghindari handover yang tidak efektif, seperti masalah teknis komunikasi, laporan tidak akurat dan minim data pasien. Isu tersebut akan berdampak luas terhadap keselamatan, mutu pelayanan, dan pengalaman pasien secara keseluruhan (Ashidiqi & Shariff, 2025).

G. Hambatan dalam pelaksanaan Handover Keperawatan

1. Komunikasi yang Tidak Efektif

Salah satu hambatan utama dalam handover keperawatan adalah komunikasi yang tidak efektif antarperawat. Informasi pasien yang disampaikan secara tidak lengkap, tidak sistematis, atau kurang jelas dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam proses perawatan. Kondisi ini sering terjadi ketika perawat hanya menyampaikan informasi secara singkat tanpa menggunakan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (Tatiwakeng, R.V., Mayulu, N & Larira, 2021). Komunikasi yang tidak terstandarisasi saat handover berisiko menyebabkan kehilangan informasi penting mengenai kondisi pasien

dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pelayanan. Selain itu, rendahnya kualitas komunikasi dalam handover berhubungan dengan menurunnya penerapan indikator keselamatan pasien di rumah sakit (Commission & Care, 2021).

2. Beban Kerja Perawat yang Tinggi

Beban kerja yang tinggi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan handover keperawatan. Perawat yang menangani banyak pasien sering mengalami kelelahan fisik maupun mental sehingga proses handover dilakukan secara terburu-buru dan kurang optimal. Kondisi ini menyebabkan beberapa informasi penting mengenai pasien tidak tersampaikan dengan baik kepada perawat penerima shift berikutnya. Tingginya beban kerja perawat dapat memengaruhi konsentrasi dan efektivitas komunikasi selama handover. Akibatnya, proses timbang terima menjadi kurang akurat dan dapat berdampak pada kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien (Pratama & Maryani, 2026).

3. Gangguan Lingkungan dan Keterbatasan Waktu

Hambatan lain dalam handover adalah adanya gangguan lingkungan kerja, seperti suasana ruangan yang bising, interupsi dari tenaga kesehatan lain, telepon, atau kondisi unit pelayanan yang sibuk. Gangguan tersebut dapat mengurangi fokus perawat saat menyampaikan maupun menerima informasi pasien (Ashidiqi & Shariff, 2025). Selain itu, keterbatasan waktu pada saat pergantian shift sering membuat handover dilakukan dengan cepat tanpa pembahasan mendalam mengenai kondisi pasien. Lingkungan kerja yang tidak kondusif serta kurangnya waktu pelaksanaan handover dapat menurunkan efektivitas komunikasi dan ketepatan dokumentasi pasien. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kesalahan tindakan maupun keterlambatan penanganan pasien (Yusuf et al., 2024).

4. Kurangnya Pengetahuan dan Pelatihan tentang Handover

Kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai teknik handover yang efektif juga menjadi hambatan penting dalam praktik keperawatan. Tidak semua perawat memiliki kemampuan komunikasi klinis yang baik atau memahami standar handover yang benar. Akibatnya, proses handover sering dilakukan hanya sebagai rutinitas administratif tanpa memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan (Pun, 2021). Pelatihan komunikasi terstruktur dan supervisi rutin dapat meningkatkan kualitas handover serta kinerja perawat di rumah sakit. Oleh karena itu, kurangnya pelatihan dan evaluasi berkala dapat menyebabkan pelaksanaan handover menjadi tidak optimal dan berpotensi memengaruhi keselamatan pasien (Jeremia, 2025).

5. Kurangnya Dukungan dan Pengawasan dari Pimpinan

Kinerja pimpinan atau kepala ruangan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan handover keperawatan. Pimpinan yang kurang aktif dalam melakukan supervisi, evaluasi, serta pembinaan terhadap perawat dapat menyebabkan pelaksanaan handover berjalan tidak sesuai standar. Dalam beberapa kasus, handover dilakukan hanya sebagai rutinitas tanpa pengawasan kualitas komunikasi maupun kelengkapan informasi pasien (Ghosh & Ramamoorthy, 2021). Supervisi dan pelatihan yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan mampu meningkatkan kualitas handover, keselamatan pasien, dan kinerja perawat. Sebaliknya, lemahnya fungsi kepemimpinan dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan perawat terhadap prosedur handover serta menurunkan koordinasi dalam tim keperawatan (Soed et al., 2025).

6. Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas

Hambatan lain dalam handover adalah tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur. Tanpa pedoman yang baku, setiap perawat dapat memiliki cara berbeda dalam menyampaikan informasi pasien, sehingga kualitas handover menjadi tidak konsisten (Keebler et al., 2023). Penggunaan metode standar seperti SBAR dapat membantu meningkatkan konsistensi komunikasi dan meminimalkan kehilangan informasi penting. Oleh karena itu, rumah sakit yang belum menerapkan SOP handover secara optimal berisiko mengalami miskomunikasi dan ketidakefektifan dalam pelayanan pasien (Villagracia et al., 2025).

7. Dokumentasi Keperawatan yang Tidak Lengkap

Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak diperbarui menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan handover. Informasi pasien yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat menyebabkan perawat penerima tidak memperoleh gambaran kondisi pasien secara menyeluruh. Hal ini dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan klinis dan tindakan keperawatan selanjutnya. Penggunaan dokumentasi elektronik berbasis *Electronic Medical Record* (EMR) mampu meningkatkan ketepatan informasi dan efektivitas bedside handover. Sebaliknya, dokumentasi manual yang kurang lengkap sering menyebabkan keterlambatan pelayanan dan risiko kesalahan Tindakan (Tataei et al., 2023).

8. Rendahnya Motivasi dan Disiplin Perawat

Motivasi dan disiplin kerja perawat juga memengaruhi keberhasilan handover. Perawat yang kurang disiplin sering datang terlambat saat pergantian shift atau tidak mengikuti proses handover secara penuh. Selain itu, rendahnya motivasi kerja dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada perawat berikutnya. Keberhasilan

komunikasi dalam handover sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dan tanggung jawab profesional perawat. Oleh karena itu, budaya kerja yang disiplin dan profesional sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan handover yang efektif (Delima, A.Z.P., Maidin, A., & Saleh, 2020).

H. Simpulan

Permasalahan handover keperawatan perlu dipahami dengan baik oleh setiap elemen yang terlibat dalam pelayanan keperawatan. Handover tidak akan berjalan dengan baik, jika komunikasi antar tim belum baik. Hal ini dikarenakan handover merupakan proses komunikasi penting dalam praktik pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan asuhan, keselamatan pasien, serta kualitas pelayanan keperawatan. Melalui handover, informasi mengenai kondisi pasien, tindakan yang telah dilakukan, serta rencana perawatan selanjutnya dapat disampaikan secara jelas dan sistematis kepada perawat yang melanjutkan tugas. Pelaksanaan handover yang efektif membantu mencegah terjadinya miskomunikasi, kesalahan tindakan, dan keterlambatan penanganan pasien, sehingga keselamatan pasien dapat lebih terjamin.

Dalam pelaksanaannya dipelayanan kesehatan, handover dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 1) kualitas komunikasi, 2) beban kerja perawat, 3) dukungan pimpinan, 4) kelengkapan dokumentasi, serta 5) adanya standar prosedur yang jelas. Hambatan-hambatan tersebut dapat memengaruhi efektivitas handover apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode komunikasi terstruktur seperti 1) SBAR, 2) supervisi yang optimal dari pimpinan, serta 3) pelatihan berkala bagi perawat agar proses handover berjalan secara profesional dan sesuai standar pelayanan. Dengan demikian, handover tidak hanya dipandang sebagai rutinitas pergantian shift, tetapi sebagai bagian penting dalam sistem keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit. Handover yang dilakukan secara tepat, lengkap, dan terstruktur akan meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan, mendukung pengambilan keputusan klinis, serta memberikan dampak positif terhadap kualitas asuhan keperawatan secara keseluruhan.

Sebagai saran, perawat diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, keterampilan komunikasi, serta ketelitian dalam menyampaikan informasi pasien secara lengkap, akurat, dan terstruktur selama proses handover dengan menggunakan metode komunikasi standar seperti SBAR. Kepala ruangan perlu berperan aktif dalam melakukan supervisi, evaluasi, serta memberikan pembinaan secara berkala guna memastikan handover terlaksana sesuai standar operasional prosedur dan berlangsung dalam suasana kerja yang kolaboratif. Selain itu,

pimpinan rumah sakit diharapkan dapat memberikan dukungan melalui penyediaan kebijakan yang jelas, pelatihan berkelanjutan, kelengkapan sarana dokumentasi, serta pengaturan beban kerja yang proporsional agar proses handover dapat berjalan optimal. Sinergi antara perawat, kepala ruangan, dan pimpinan rumah sakit menjadi kunci penting dalam mewujudkan handover yang efektif, sehingga keselamatan pasien, kontinuitas pelayanan, dan mutu asuhan keperawatan dapat terus ditingkatkan.

Referensi

- Aly, E., Hashish, A., Asiri, A. A., & Alnajjar, Y. K. (2023). *Shift handover quality in Saudi critical care units: determinants from nurses' perspectives*. 1–14.
- Ashidiqi, A. I., & Shariff, S. (2025). *Harmonizing Faith and Care: Analyzing Inpatient Satisfaction in Islamic Healthcare at Unimus Hospital, Indonesia*. 14(April), 79–97.
- Chaica, V., & Marques, R. (2024). *ISBAR: A Handover Nursing Strategy in Emergency*. 1–11.
- Chien, L. J., Slade, D., Dahm, M. R., Brady, B., Roberts, E., Goncharov, L., Taylor, J., Eggins, S., & Thornton, A. (2022). *Improving patient- - centred care through a tailored intervention addressing nursing clinical handover communication in its organizational and cultural context*. September 2021, 1413–1430. <https://doi.org/10.1111/jan.15110>
- Commission, A., & Care, H. (2021). *National Safety and Quality Health Service Standards*.
- Delima, A.Z.P., Maidin, A., & Saleh, L. . (2020). Analysis of the Implementation Patient Safety Targets at The Makasar City Regional General Hospital. *Journal of Asian Multicultural Research for Medical and Health Science Study*, 1(2), 47–56.
- Djajasasana, C. N., Listyani, N. K., & Sihombing, V. D. (2024). *Pengaruh Penerapan IPSG (International Patient Safety Goals) terhadap Kepuasan Pasien Layanan Home Care Smartcare Jakarta*. 4, 14934–14949.
- Dúason, S., Gunnarsson, B., & Svavarsdóttir, M. H. (2021). *Patient handover between ambulance crew and healthcare professionals in Icelandic emergency departments: a qualitative study*. 1–11.
- Ghosh, S., & Ramamoorthy, L. (2021). *Impact of Structured Clinical Handover Protocol on Communication and Patient Satisfaction*. 1–6. <https://doi.org/10.1177/2374373521997733>
- Halimatussakdiah, H., Faisal, T. I., Nuraskin, C. A., Ahmad, A., & Alhuda, A. (2022). The Effect of Electronic Nursing Documentation (END) Implementation on Nursing Services Toward Patients' Satisfaction. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 237–246. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i1.842>
- Jeremia, A. (2025). *Jurnal ARSI: Administrasi Rumah Sakit Indonesia Implementation of Patient Safety Incident Reporting Using Web- Based Quality Management Information System in Hospital X Tangerang*. 11(2). <https://doi.org/10.7454/arsi.v11i2.1217>
- Joint Commission International, W. (2007). *Communication During Patient Hand-Overs*. 1(May).

- Kavitha, N. K., Rami, M. A., Vanaja, P., Manjula, A. K., M, J. J., D, I. J. P., Lakshimi, K., Katiyar, J., Umar, M., & Prabha, N. (2026). *Nursing shift handover methods and their impact on patient safety*. 14(4), 1600–1611.
- Keebler, J. R., Lynch, I., Ngo, F., Phelps, E., & Huang, N. (2023). Leveraging the Science of Teamwork to Sustain Handoff. *The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 49(8), 373–383. <https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2023.05.006>
- Lazzari, C., & Rabottini, M. (2025). *The use of Introduction , Situation , Background , Assessment , and Recommendation handover in the COVID-19 pandemic and non-COVID clinical settings : a systematic review and meta-analysis. August*. <https://doi.org/10.3389/frhs.2025.1380948>
- Lestari, H. D., Ottu, E. R., Hamu, A. H., & Vanchapo, A. R. (2025). *Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit : Systematic Literature Review Strategies for Improving Healthcare Service Quality in Hospitals : A Systematic Literature Review*. 155–166.
- Moss-sherman, B. A. (2025). *Enhancing Emergency Department Communication : Structural Walden University*.
- Pratama, I. Y., & Maryani, L. (2026). *Implementation of SBAR Communication among Nurses During Shift Handover Before and After a Mini Seminar in the Inpatient Ward of a Hospital*. 4(1), 35–42.
- Pun, J. (2021). *Factors associated with nurses ' perceptions , their communication skills and the quality of clinical handover in the Hong Kong context*. 1–8.
- Saefulloh, A., Pranatha, A., Mulyani, R., & Kuningan, S. (2020). *Komunikasi pada saat handover memengaruhi pelaksanaan indikator patient*. 6(1), 27–33.
- Saputra, T. E. (2024). *Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien The Use of Electronic Medical Records in Realizing Legal Protection of Patient Personal Data Security*. 13, 57–75.
- Sharplin, G., Adelson, P., Kennedy, K., Williams, N., Hewlett, R., Wood, J., Bonner, R., Dabars, E., & Eckert, M. (2019). Establishing and sustaining a culture of evidence-based practice: an evaluation of barriers and facilitators to implementing the best practice spotlight organization program in the Australian healthcare context. *Healthcare (Switzerland)*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/healthcare7040142>
- Siswadi, Y., Keperawatan, S., Keperawatan, F., Harapan, U. P., & Keperawatan, D. (n.d.). *EMR Terhadap Efektifitas Bedside Handover Metode Sbar : Systematic Review*.
- Soed, N., Ludin, S. M., Nurulakla, S., Abdullah, S., & Al-zahrawi, R. (2025). *Exploring the Impact of the SBAR on Nursing Handover : A Scoping Review*. 17(July),

233–245. <https://doi.org/10.31674/mjn.2025.v17i01.024>

- Sriningsih, N. N., Kep, S., Marlina, M. K. E., Sriningsih, N. N., Kep, S., Kep, M., Sakit, R., & Kabupaten, U. (2020). *Pengetahuan Penerapan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Pada Petugas Kesehatan* 9(1). <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v9i1.120>
- Tataei, A., Rahimi, B., Afshar, H. L., Alinejad, V., & Jafarizadeh, H. (2023). *The effects of electronic nursing handover on patient safety in the general (non-COVID-19) and COVID-19 intensive care units: a quasi-experimental study*. 1–9.
- Tatiwakeng, R.V., Mayulu, N & Larira, D. . (2021). ,Hubungan Penggunaan Metode Komunikasi Efektif Sbar Dengan Pelaksanaan Timbang Terima (Handover) Systematic Review. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 77–88.
- Tioorentap, D. R. . (2020). Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review. *Indonesian of Health Information Management Journal Vol.8*, 8(2), 69–79.
- Villagrancia, H. N., Alanezi, A. J., Alshammri, R. Z., Alblwei, K. H., Falah, F., Harbi, A., Alanezi, F. M., Alanazi, S. M., Berdida, D. J. E., Grande, R. A. N., & Villagrancia, R. W. A. (2025). *Intensive Care Unit Nurses ' Organizational Climate and Clinical Competency in Saudi Government Hospitals : Cross-Sectional and Multicenter Study*. 2025. <https://doi.org/10.1155/jonm/5041633>
- Wang, M., Gao, Z., Wang, M., & Gao, Z. (2025). *Effect of ISBAR Communication Mode on the Bedside Delivery Quality of Nurses Working in the Department of Rheumatology and Immunology Effect of ISBAR Communication Mode on the Bedside Delivery Quality of Nurses Working in the Department of Rheumatology and Immunology*. 2390. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S501261>
- WHO. (2021). *Towards eliminating avoidable harm in health care*.
- Yetti, K., Dewi, N. A., Wigiarti, S. H., & Warashati, D. (2021). *Nursing handover in the Indonesian and barriers*. 7(2), 113–117.
- Yusuf, S. A., Herlina, C., & Sibarani, L. (2024). *Aspek Legal dan Etika Penggunaan Data Pasien dalam Teknologi Big Data dan Kecerdasan Buatan di Sektor Kesehatan*. 381–393.



CHAPTER 3



PRINSIP KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM HANDOVER

Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., Ph.D.

A. Pendahuluan

Indikator utama mutu pelayanan kesehatan dirumah sakit adalah keselamatan pasien (*patient safety*). Keselamatan pasien merupakan upaya penting dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah kesalahan medis dan melindungi pasien.

Jaminan Keselamatan pasien menjadi prioritas utama karena tingginya risiko kejadian tidak diinginkan (KTD), medication error, keterlambatan tindakan, hingga kesalahan prosedur akibat komunikasi yang tidak efektif antar tenaga kesehatan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menegaskan bahwa kegagalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, komunikasi efektif menjadi elemen mendasar dalam pelayanan keperawatan profesional.

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki interaksi paling lama dengan pasien selama 24 jam pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan perawat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesinambungan asuhan keperawatan, terutama saat pergantian shift kerja.

Gerak langkah komitmen menjaga keselamatan pasien dimulai sejak menjadi calon perawat. Program Diploma 3 keperawatan mempunyai kurikulum terstandar dan pengalaman klinik bervariasi. Namun demikian 6 kata kunci atau domain kompetensi keselamatan pasien harus tetap di prioritaskan dalam penerapannya. 6 domain tersebut yaitu penegakan budaya keselamatan pasien, bekerja dalam tim keselamatan pasien, komunikasi efektif untuk menjamin keselamatan pasien, pengelolaan ancaman keselamatan pasien, optimalisasi factor manusia dan lingkungan dan pengenalan respon kejadian yang tidak diharapkan. (Linda, Silvana, 2024).

Salah satu bentuk komunikasi profesional yang efektif dan berpengaruh terhadap pelayanan keperawatan dan keamanan pasien diruang rawat adalah handover atau timbang terima pasien. (Anwar, Suryani, 2024).

Handover merupakan proses pengalihan informasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelayanan pasien dari satu perawat kepada perawat berikutnya secara sistematis dan terstruktur. Proses handover bertujuan memastikan bahwa seluruh

informasi penting mengenai kondisi pasien dapat tersampaikan secara lengkap sehingga pelayanan tetap berkesinambungan dan aman. Handover yang tidak dilakukan dengan baik dapat menyebabkan kehilangan informasi klinis penting, kesalahan tindakan, duplikasi terapi, serta meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien.

Komunikasi efektif dalam handover menjadi faktor utama keberhasilan transfer informasi antar tenaga kesehatan. Salah satu metode komunikasi yang saat ini banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*). Metode ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas komunikasi karena informasi disampaikan secara sistematis, singkat, jelas, dan mudah dipahami.

Komunikasi efektif metode SBAR berhubungan signifikan dengan peningkatan pelaksanaan handover serta keselamatan pasien. SBAR sangat berperan penting dalam pelaksanaan proses timbang terima, karena dapat meningkatkan keselamatan pasien (Tatiwaekeng, 2021)

Hasil penelitian yang dilakukan diruang rawat pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi efektif dengan pelaksanaan handover, sebagian besar responden memiliki komunikasi yang baik yaitu sebanyak 38 orang (51,4%) dan sebagian besar memiliki pelaksanaan *handover* yang baik sebanyak 38 orang (51,4%). (Anwar, Suryani, 2025)

Sementara hasil penelitian lain menunjukan pula bahwa penerapan inovasi manajemen handover metode SBAR memiliki pengaruh terhadap kemampuan ketua tim dalam melakukan handover. Hasil evaluasi menunjukan bahwa sebanyak 75% ketua tim mempunyai kemampuan dalam melakukan pengisian form handover dan penyampaian handover dengan menggunakan metode SBAR dengan baik.

Dengan demikian, pemahaman mengenai prinsip komunikasi efektif melalui handover menjadi sangat penting bagi tenaga keperawatan dalam menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

B. Konsep Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara jelas, tepat, lengkap, dan dapat dipahami oleh penerima pesan sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Dalam keperawatan, komunikasi efektif menjadi dasar koordinasi antar tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan yang aman dan berkualitas.

Komunikasi efektif memiliki beberapa prinsip, yaitu:

1. Kejelasan pesan

Kejelasan pesan dalam komunikasi efektif merupakan unsur utama yang mendukung keberhasilan handover (timbang terima) pada pelayanan keperawatan. Seperti diketahui handover adalah proses penyampaian informasi pasien antarperawat saat pergantian shift agar kontinuitas asuhan tetap terjaga dan keselamatan pasien meningkat.

Dalam praktik keperawatan, kejelasan pesan sangat penting karena kesalahan komunikasi dapat menyebabkan *medication error*, tindakan yang tidak sesuai, keterlambatan pelayanan, hingga kejadian tidak diharapkan (KTD).

Kejelasan pesan berarti informasi diberikan secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami oleh penerima. Dalam handover, komunikasi yang terlalu panjang atau tidak terarah dapat menyebabkan informasi penting terlewat. Oleh karena itu, metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) digunakan untuk membantu perawat menyampaikan informasi secara terstruktur.

Metode SBAR membantu perawat fokus pada kondisi utama pasien, mengurangi informasi yang ambigu, meningkatkan efisiensi waktu handover, dan memudahkan pengambilan keputusan klinis.

2. Informasi akurat dan relevan

Pesan yang jelas harus berisi data yang benar, terkini, dan sesuai dengan kondisi pasien. Informasi yang tidak relevan atau tidak akurat dapat menyebabkan miskomunikasi antar tenaga kesehatan. Pada handover, informasi yang biasanya harus dijelaskan meliputi identitas pasien, diagnosis, kondisi terkini, hasil observasi, tindakan yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut. Komunikasi efektif menekankan bahwa informasi harus lengkap tetapi tetap relevan terhadap kebutuhan pelayanan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi SBAR meningkatkan ketepatan informasi karena data disampaikan sesuai urutan prioritas klinis (Maku, 2025).

3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami

Kejelasan pesan juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa yang sederhana, profesional, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam handover, penggunaan istilah medis harus dipahami oleh seluruh anggota tim keperawatan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Bahasa yang jelas membantu berupa meningkatkan pemahaman penerima pesan, mempercepat respon tindakan, serta meningkatkan koordinasi antarperawat dan profesi kesehatan lain.

4. Adanya konfirmasi dan umpan balik

Komunikasi efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan diterima dengan benar. Dalam handover, penerima

informasi perlu melakukan klarifikasi atau konfirmasi ulang terhadap informasi penting. (Irianti, fitriana,2023)

5. Tepat waktu

Pesan yang jelas harus diberikan pada waktu yang tepat agar tindakan keperawatan dapat segera dilakukan. Keterlambatan dalam penyampaian informasi dapat memengaruhi kondisi pasien, terutama pada pasien kritis. Komunikasi yang tepat waktu membantu kesinambungan pelayanan, percepatan intervensi, dan penurunan risiko insiden keselamatan pasien. (Anwar, Suryani, 2025}

6. Fokus pada keselamatan pasien

Kejelasan pesan dalam handover bertujuan utama menjaga keselamatan pasien. Informasi yang jelas memungkinkan perawat berikutnya memahami prioritas masalah pasien dan tindakan yang harus segera dilakukan.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi SBAR dapat menurunkan kejadian tidak diharapkan, meningkatkan mutu pelayanan, serta meningkatkan kualitas handover keperawatan. (Tatiwakeng, 2021).

Penerapan komunikasi efektif dengan metode SBAR terbukti membantu meningkatkan kualitas handover, memperkuat koordinasi antarperawat, dan menurunkan risiko kesalahan pelayanan dalam praktik keperawatan.

C. Konsep Handover dalam Keperawatan

Handover atau timbang terima merupakan proses komunikasi, pengalihan tanggung jawab, dan penyampaian informasi penting mengenai kondisi pasien dari perawat yang selesai bertugas kepada perawat yang akan melanjutkan pelayanan.

Handover menjadi bagian penting dalam kesinambungan asuhan keperawatan karena berfungsi memastikan bahwa seluruh informasi klinis pasien tersampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sehingga keselamatan pasien tetap terjaga.

Dalam keperawatan, handover biasanya dilakukan saat pergantian shift, perpindahan pasien antar ruangan, perpindahan unit pelayanan, atau saat rujukan pasien.

Tujuan utama handover adalah menjaga kesinambungan asuhan keperawatan, mencegah kesalahan pelayanan, meningkatkan koordinasi tim kesehatan, dan menjamin keselamatan pasien. (Tati Wakeng, 2021).

Menurut World Health Organization, komunikasi yang buruk saat handover merupakan salah satu penyebab utama terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, handover harus dilakukan secara sistematis, terstruktur,

dan menggunakan komunikasi efektif seperti metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).

Beberapa Konsep Handover yang Menjamin Keselamatan Pasien dibawah ini:

1. Handover sebagai Proses Komunikasi Klinis

Konsep utama handover adalah komunikasi klinis yang efektif antarperawat. Informasi yang disampaikan harus meliputi identitas pasien, diagnosis medis, kondisi terkini pasien, tindakan yang telah dilakukan, hasil observasi, terapi yang diberikan, risiko pasien, dan rencana tindak lanjut.

Komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan medication error, kesalahan tindakan, keterlambatan intervensi, hingga kejadian tidak diharapkan (KTD). Karena itu, komunikasi saat handover harus jelas, lengkap, akurat, singkat, dan sistematis.)

2. Handover sebagai Upaya Menjamin *Continuity of Care*

Handover memastikan bahwa pelayanan pasien tetap berlanjut tanpa terputus meskipun terjadi pergantian petugas. Perawat penerima shift dapat memahami perkembangan kondisi pasien, prioritas tindakan, dan masalah yang perlu dipantau.

Dengan continuity of care yang baik tindakan keperawatan menjadi konsisten, risiko kesalahan menurun, dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara optimal. (Anwar, Suryani)

3. Handover Berbasis Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Keselamatan pasien merupakan inti dari pelaksanaan handover. Handover yang baik membantu mengurangi insiden keselamatan pasien, meningkatkan ketepatan tindakan, dan mempercepat respon terhadap kondisi kritis pasien.

Dalam konsep patient safety, informasi yang berisiko tinggi harus menjadi prioritas, seperti alergi obat, risiko jatuh, penggunaan alat medis, perubahan tanda vital, dan kondisi kegawatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa handover yang efektif dapat menurunkan angka kesalahan medis dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. (Nasrianti, Mulyati)

4. Handover pendekatan Metode SBAR

Metode SBAR merupakan standar komunikasi yang paling sering digunakan dalam handover karena membantu penyampaian informasi menjadi lebih sistematis.

Komponen SBAR meliputi:

- a. *Situation*: menjelaskan kondisi pasien saat ini. yaitu penjelasan tentang uraian kejadian yang sasarannya pada pasien.

Contoh: "Pasien mengeluh sakit hebat disekitar pinggang sejak 3 hari lalu "

b. *Background*: menjelaskan riwayat atau informasi pendukung pasien.

Contoh: "Pasien memiliki riwayat diabet dan hipertensi."

c. *Assessment*: berisi hasil pengkajian perawat terhadap kondisi pasien.

Contoh: ".Tensi 160/90,, "Gula darah puasa 250

d. *Recommendation*: berisi rekomendasi atau tindakan lanjutan yang perlu dilakukan.

Contoh: "Perlu observasi ketat dan kolaborasi dengan dokter dan tim kes lain'

Metode SBAR terbukti meningkatkan kualitas komunikasi, memperjelas informasi klinis, dan mengurangi miskomunikasi antar tenaga kesehatan. Penelitian yang dilakukan Irawati pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan SBAR dalam handover rawat inap meningkatkan efektivitas komunikasi antar perawat dan memperkuat keselamatan pasien.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perawat mengenai SBAR sangat mempengaruhi kualitas handover dan keselamatan pasien.

Prinsip-Prinsip Handover yang Efektif

Agar handover mampu menjamin keselamatan pasien, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan:

1. Akurat

Informasi yang disampaikan saat handover harus benar, sesuai kondisi pasien terkini, dan berdasarkan data objektif. Ketidakakuratan informasi dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan klinis. Informasi penting yang harus akurat meliputi identitas pasien, diagnosis medis, hasil observasi, terapi yang diberikan, perubahan kondisi pasien, dan tindakan lanjutan. Komunikasi yang akurat membantu mencegah medication error dan kesalahan tindakan keperawatan. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi SBAR meningkatkan ketepatan penyampaian informasi dalam handover

2. Lengkap

Handover harus mencakup seluruh informasi penting terkait kondisi pasien. Informasi yang tidak lengkap dapat menghambat *continuity of care* dan meningkatkan risiko keselamatan pasien. Kelengkapan handover meliputi kondisi umum pasien, masalah keperawatan, hasil pemeriksaan, terapi medis, risiko pasien, serta rencana tindak lanjut. Metode SBAR membantu memastikan seluruh komponen informasi tersampaikan secara lengkap dan sistematis.

3. Tepat Waktu,

Handover harus dilakukan tepat waktu agar pelayanan pasien tidak terputus. Keterlambatan penyampaian informasi dapat memperburuk kondisi pasien, terutama pada pasien kritis. Ketepatan waktu penting untuk mempercepat respon tindakan, memastikan kontinuitas pelayanan, dan

mencegah keterlambatan intervensi medis. Pelaksanaan handover yang efektif mendukung respon cepat terhadap perubahan kondisi pasien.

4. Terstruktur

Handover harus dilakukan secara runtut dan terorganisir. Prinsip ini bertujuan agar informasi tidak terlewat dan mudah dipahami oleh penerima. Metode yang paling banyak digunakan adalah SBAR *Situation*: kondisi utama pasien *Background*: riwayat dan informasi pendukung, *Assessment*: hasil, *Recommendation*: rekomendasi tindakan lanjutan. Penggunaan SBAR terbukti meningkatkan efektivitas handover dan mengurangi risiko miskomunikasi. (Tatiwakeng, 2021)

5. Interaktif

Handover bukan hanya penyampaian informasi satu arah, tetapi juga melibatkan proses klarifikasi dan umpan balik. Perawat penerima perlu bertanya bila ada informasi yang kurang jelas, melakukan konfirmasi ulang, dan memastikan pemahaman yang sama terhadap kondisi pasien. Prinsip ini membantu mengurangi risiko kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan.

6. Terdokumentasi

Informasi handover dicatat untuk menghindari kehilangan data pasien. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan handover antara lain: kepatuhan terhadap prosedur handover, kemampuan komunikasi perawat, lingkungan yang kondusif. Dukungan manajemen rumah sakit juga penting dalam menyediakan, pelatihan komunikasi efektif, SOP handover, dan budaya keselamatan pasien. Informasi yang biasanya disampaikan meliputi: identitas pasien, diagnosis medis, kondisi terkini pasien, tanda vital, terapi dan obat yang diberikan. Hasil pemeriksaan penting, Risiko pasien (jatuh, alergi, infeksi), Rencana tindak lanjut. Komunikasi yang buruk saat handover merupakan salah satu penyebab utama: kesalahan pemberian obat, tindakan yang terlambat, salah identifikasi pasien, pengulangan tindakan, kejadian tidak diharapkan (*adverse event*). Karena itu, handover termasuk bagian penting dari sasaran keselamatan pasien, khususnya pada aspek komunikasi efektif.

Beberapa Klasifikasi handover yang perlu dipahami terdiri dari:

- a. *Verbal Handover*, disampaikan secara lisan.
- b. *Written Handover*, menggunakan dokumentasi tertulis atau elektronik.
- c. *Bedside Handover*, dilakukan disamping tempat tidur pasien sehingga pasien dapat ikut terlibat.

Metode *bedside handover* banyak dianjurkan karena dapat mengurangi kesalahan identifikasi pasien, meningkatkan partisipasi pasien, memungkinkan verifikasi langsung kondisi pasien, meningkatkan transparansi pelayanan.

Keuntungan *bedside handover*: meningkatkan partisipasi pasien, mengurangi kesalahan identifikasi, memungkinkan validasi langsung kondisi pasien, meningkatkan transparansi pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien dan perawat.

Penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa integrasi bedside handover berbasis SBAR dengan *Electronic Medical Record* (EMR) meningkatkan kepatuhan dokumentasi dan efektivitas komunikasi antarperawat. Hambatan yang sering ditemukan adalah: lingkungan bising, waktu terbatas, dokumentasi tidak lengkap, gangguan/interupsi, kurangnya standar komunikasi dan beban kerja tinggi.

Upaya meningkatkan standar komunikasi yang kurang, rumah sakit biasanya melakukan pelatihan komunikasi efektif yang diberikan kepada perawat secara rutin untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Selain menggunakan metode SBAR, perawat dilatih juga melakukan *handover* langsung disamping pasien dengan tujuan: verifikasi identitas pasien, melibatkan pasien dan keluarga, memastikan akurasi data klinis dan mengurangi miskomunikasi.

Aspek yang ditekankan meliputi menjaga privasi pasien, etika komunikasi terapeutik, validasi kondisi pasien secara langsung. Ketiga aspek ini dianggap penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien (*patient safety*), kontinuitas pelayanan, serta mutu komunikasi antar tenaga kesehatan.

1. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Pasien dalam Handover

Aspek privasi pasien menjadi fokus utama dalam pelatihan komunikasi handover. Pada praktik bedside handover, perawat melakukan serah terima di dekat pasien sehingga risiko kebocoran informasi menjadi lebih tinggi apabila komunikasi tidak dilakukan secara etis dan profesional.

Hal-hal yang ditekankan dalam pelatihan meliputi:

- a. Memastikan informasi pasien hanya disampaikan kepada tenaga kesehatan yang berwenang;
- b. Menghindari penyebutan diagnosis sensitif dengan suara keras;
- c. Menggunakan bahasa profesional dan tidak menghakimi;
- d. Meminta izin pasien sebelum bedside handover dilakukan;
- e. Menjaga keamanan dokumentasi elektronik (emr);
- f. Membatasi akses informasi klinis sesuai prinsip confidentiality.
- g. Pelatihan juga menekankan bahwa penggunaan dokumentasi elektronik dan emr dalam handover harus tetap mengikuti prinsip keamanan data pasien dan keselamatan pasien. Studi systematic review terbaru menunjukkan bahwa penggunaan EMR dapat meningkatkan efektivitas handover, tetapi harus disertai penguatan aspek privasi dan standar komunikasi profesional. Selain itu, komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

dinilai membantu membatasi informasi yang disampaikan agar tetap fokus, relevan, dan tidak membuka data pasien yang tidak diperlukan.

2. Etika Komunikasi Terapeutik saat Handover

Pelatihan komunikasi handover juga menekankan pentingnya komunikasi terapeutik yang berorientasi pada penghormatan terhadap pasien. Dalam bedside handover, pasien bukan hanya objek laporan, tetapi dilibatkan sebagai bagian dari proses pelayanan.

Aspek etika komunikasi terapeutik yang ditekankan meliputi:

- a. Penggunaan bahasa yang sopan, empatik, dan mudah dipahami pasien;
- b. Menjaga nada bicara profesional;
- c. Menghargai martabat dan kenyamanan pasien;
- d. Menghindari komunikasi yang menimbulkan kecemasan;
- e. Memberikan kesempatan pasien bertanya atau mengoreksi informasi;
- f. Menunjukkan sikap caring dan active listening.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi efektif berbasis SBAR meningkatkan kualitas handover sekaligus memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Pendekatan komunikasi interpersonal (IPE) juga mulai banyak diterapkan dalam pelatihan handover agar tenaga kesehatan mampu membangun kolaborasi yang saling menghargai antar profesi kesehatan. Dalam beberapa penelitian terbaru, komunikasi terapeutik dianggap penting karena meningkatkan kepercayaan pasien, menurunkan miskomunikasi, meningkatkan kepuasan pasien, mendukung patient-centered care dan memperkuat budaya keselamatan pasien.

3. Validasi Kondisi Pasien Secara Langsung (*Direct Patient Validation*)

Aspek ini menjadi salah satu komponen paling penting dalam bedside handover modern. Pelatihan handover saat ini tidak hanya mengajarkan penyampaian laporan verbal, tetapi juga validasi langsung terhadap kondisi pasien.

Validasi langsung dilakukan dengan:

- a. Mengecek identitas pasien;
- b. Memverifikasi terapi dan obat;
- c. Observasi kondisi klinis terkini;
- d. Memeriksa alat medis yang terpasang;
- e. Mengklarifikasi data yang belum sesuai;
- f. Memastikan rekomendasi tindakan dipahami perawat berikutnya.
- g. Konsep ini sangat penting karena berbagai penelitian menemukan bahwa kesalahan handover sering terjadi akibat informasi yang tidak diverifikasi langsung kepada pasien.

- h. Dalam metode sbar, tahap "*assessment*" dan "*recommendation*" menjadi bagian yang paling sering mengalami ketidaktepatan apabila tidak dilakukan validasi langsung di sisi pasien.
- i. Pelatihan komunikasi ini juga menekankan:
- j. Penggunaan *check-back communication*;
- k. *Read-back information*;
- l. Konfirmasi dua arah;
- m. Observasi bersama antar perawat saat pergantian shift.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi medical error, meningkatkan akurasi informasi, menjaga kontinuitas asuhan dan memperkuat clinical reasoning perawat.

D. Pengertian *Check-Back Communication*

Check-back communication adalah teknik komunikasi tertutup (*closed-loop communication*) yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah diterima, dipahami, dan dikonfirmasi dengan benar oleh penerima pesan. Dalam kegiatan *handover* perawat di ruang rawat inap, teknik ini sangat penting untuk mencegah kesalahan informasi yang dapat berdampak pada keselamatan pasien.

Prinsip dasar *check-back communication* terdiri dari tiga tahap:

1. Pengirim menyampaikan informasi
2. Penerima mengulang kembali informasi
3. Pengirim mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut

Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengurangi miskomunikasi antarperawat, memastikan informasi pasien diterima secara akurat, menghindari kesalahan tindakan klinis, memastikan kesinambungan asuhan keperawatan, meningkatkan keselamatan pasien, dan memperjelas instruksi atau kondisi pasien yang kritis.

Aspek Penggunaan *Check-Back Communication* dalam Handover

Konfirmasi Identitas pasien perawat penerima melakukan pengulangan identitas pasien untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan pasien.

Contoh:

Perawat A "Pasien atas nama Bapak Ahmad, usia 59 tahun, ruang Dahlia."

Perawat B "Baik, pasien Bapak Ahmad, ruang Dahlia."

Perawat A "Benar."

Tujuan menghindari salah pasien dan memastikan data pasien sesuai pengulangan Informasi Klinis Penting Informasi penting terkait kondisi pasien harus

diulang kembali oleh penerima. Informasi yang biasanya dikonfirmasi: diagnosis, tanda vital, hasil pemeriksaan, perubahan kondisi, risiko pasien, status alergi.

Contoh: "Tekanan darah 100/ 70 mm Hg dan pasien masih mengeluh nyeri."

Penerima:

"Baik, tekanan darah 100/70 dan pasien masih mengeluh nyeri." Manfaat: mengurangi kesalahan interpretasi, dan menjamin akurasi data klinis Instruksi yang harus dilakukan shift berikutnya perlu dikonfirmasi ulang.

Contoh: "Observasi saturasi tiap 1 jam dan laporkan bila di bawah 92%."

Penerima:

"Monitoring saturasi tiap 1 jam dan laporkan jika kurang dari 92%."

Tujuan mencegah kesalahan tindakan dan memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai instruksi

1. Klarifikasi Informasi yang Tidak Jelas

Jika terdapat informasi yang ambigu atau kurang lengkap, penerima wajib melakukan klarifikasi.

Contoh: "Pasien tampak memburuk."

Penerima:

"Memburuk dalam hal apa? Apakah kesadaran atau pernapasannya?" Tujuan menghindari asumsi dan memastikan informasi spesifik dan terukur

2. Penggunaan Bahasa yang Jelas dan Standar

Check-back communication harus menggunakan:

- a. Bahasa sederhana
- b. Terminologi medis standar
- c. Kalimat singkat
- d. Informasi spesifik
- e. Hindari:
 - 1) Istilah ambigu
 - 2) Singkatan yang tidak baku
 - 3) Informasi terlalu panjang

Contoh efektif: "Infus RL 20 tpm masih berjalan." Bukan: "Infusnya masih bagus."

3. Dokumentasi yang Sesuai dengan Komunikasi Lisan

Perawat memastikan bahwa informasi yang dikonfirmasi secara verbal sesuai dengan dokumentasi keperawatan. Aspek yang diperiksa: Obat, Dosis, Jadwal tindakan, Catatan observasi dan Instruksi dokter tujuan menyamakan data verbal dan tertulis, mengurangi kesalahan dokumentasi

4. Fokus dan Konsentrasi Selama Handover

Check-back communication hanya efektif jika kedua pihak fokus, tidak melakukan aktivitas lain, mendengarkan aktif dan tidak terinterupsi. Faktor pendukung didapat lingkungan tenang, tidak ada distraksi dan waktu handover cukup

5. Penerapan pada Kondisi Risiko Tinggi

Teknik ini sangat penting pada pasien Kritis, Risiko jatuh, Risiko perdarahan, Penggunaan obat *high alert*, Pasien pascaoperasi, Pasien dengan perubahan kondisi cepat

Contoh: "Heparin diberikan pukul 18.00 sebanyak 5000 unit."Penerima: "Baik, Heparin 5000 unit pukul 18.00 sudah diberikan."

Check-Back Communication dikatakan efektif apabila:

- a. Informasi diulang lengkap
- b. Tidak ada asumsi
- c. Ada konfirmasi akhir
- d. Dilakukan dua arah
- e. Menggunakan bahasa jelas
- f. Fokus pada keselamatan pasien

E. Pengertian *Readback Information*

Readback information adalah teknik komunikasi keselamatan pasien di mana penerima informasi membaca kembali atau mengulang secara verbal informasi yang diterima kepada pemberi informasi untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dengan tepat dan tidak terjadi kesalahan komunikasi. Dalam kegiatan *handover* perawat di ruang rawat inap, *readback* digunakan terutama pada informasi yang bersifat penting, kritis, atau berisiko tinggi seperti instruksi tindakan, pemberian obat, hasil pemeriksaan, dan perubahan kondisi pasien.

Teknik ini merupakan bagian dari *closed-loop communication* yang menekankan verifikasi ulang terhadap informasi klinis. Penggunaan *readback information* bertujuan untuk memastikan akurasi informasi pasien, mengurangi kesalahan komunikasi antar shift, mencegah kesalahan tindakan keperawatan, memastikan instruksi dipahami dengan benar, mendukung keselamatan pasien, meningkatkan koordinasi tim kesehatan dan menghindari salah dengar atau salah interpretasi

Aspek Penggunaan *Readback Information* dalam Handover

1. Pengulangan Informasi Secara Verbatim atau Tepat

Penerima informasi harus mengulang kembali isi pesan secara jelas dan sesuai dengan informasi asli.

Contoh:

Perawat A: "Pasien mendapat injeksi insulin 6 unit sebelum makan malam."

Perawat B: "Baik, insulin 6 unit diberikan sebelum makan malam."

Perawat A: "Benar."

Tujuan menghindari perubahan makna informasi, memastikan data diterima secara akurat

2. Digunakan pada Informasi Risiko Tinggi

Readback sangat penting untuk informasi yang dapat menimbulkan dampak serius bila terjadi kesalahan.

Informasi yang wajib dilakukan *readback*:

- a. Nama dan dosis obat
- b. Instruksi dokter
- c. Hasil laboratorium kritis
- d. Status alergi
- e. Tindakan invasif
- f. Perubahan kondisi pasien
- g. Pembatasan cairan
- h. Penggunaan alat medis

Contoh:

"Kalium pasien 2,8 mEq/L."

Penerima:

"Baik, hasil kalium 2,8 mEq/L."

3. Konfirmasi Instruksi Tindakan Lanjutan

Instruksi yang harus dilakukan oleh shift berikutnya harus dibaca kembali secara rinci.

Contoh: "Monitor urine output tiap 2 jam dan laporkan bila kurang dari 30 cc/jam."

Penerima: "Monitoring urine output tiap 2 jam dan laporkan jika kurang dari 30 cc per jam."

Tujuan: menjamin keberlanjutan asuhan dan menghindari kelalaian tindakan

4. Verifikasi Data Obat dan Terapi

Aspek ini sangat penting karena kesalahan obat merupakan salah satu insiden keselamatan pasien yang paling sering terjadi.

Hal yang perlu dibaca ulang:

- a. Nama obat
- b. Dosis
- c. Rute pemberian
- d. Waktu pemberian
- e. Kecepatan infus

Contoh: "Ceftriaxone 1 gram IV tiap 12 jam."

Penerima: "Baik, Ceftriaxone 1 gram intravena setiap 12 jam."

Tujuan: menghindari medication error dan memastikan ketepatan terapi

5. Penggunaan Bahasa yang Jelas dan Standar

Readback harus menggunakan:

- a. Bahasa profesional
- b. Istilah medis baku
- c. Kalimat singkat
- d. Angka yang disebut jelas

Contoh yang baik: "Dopamin 5 mikrogram per kilogram per menit."

Bukan: "Dopaminnya kecil saja."

Tujuan: mengurangi ambiguitas dan memastikan pemahaman seragam

6. Klarifikasi bila ada ketidaksesuaian

Jika hasil *readback* tidak sesuai dengan informasi awal, pemberi informasi wajib memperbaiki segera.

Contoh: Perawat A: "Heparin 500 unit per jam."

Perawat B: "Baik, Heparin 5000 unit per jam."

Perawat A: "Bukan, 500 unit per jam."

Tujuan: mengoreksi kesalahan sebelum tindakan dilakukan dan menghindari kejadian tidak diharapkan

7. Dilakukan dua arah dan aktif

Readback bukan hanya pengulangan pasif, tetapi proses komunikasi aktif antara pemberi dan penerima informasi.

Komponen:

- a. Penyampaian pesan
- b. Pengulangan pesan
- c. Konfirmasi akhir

8. Sinkronisasi dengan Dokumentasi

Informasi yang dibaca kembali harus sesuai dengan:

- a. Catatan keperawatan
- b. Rekam medis
- c. Instruksi dokter
- d. Lembar observasi

Tujuan: menjaga konsistensi data dan meminimalkan kesalahan administrasi

Pelatihan pencatatan dan pelaporan bagian dari upaya komunikasi efektif yang didukung dengan dokumentasi yang baik. Adapun materi meliputi Cara menulis catatan keperawatan, Penggunaan format standar, Dokumentasi perubahan kondisi pasien, sinkronisasi komunikasi lisan dan tertulis.

Bentuk pelatihan komunikasi lainnya dilaksanakan melalui Simulasi dan Role Play, Metode praktik ini digunakan agar perawat mampu: Menghadapi situasi klinis nyata, mengelola komunikasi saat kondisi darurat, menyampaikan prioritas pasien secara cepat.

Biasanya dilakukan melalui: Simulasi pergantian shift, studi kasus pasien kritis dan evaluasi video komunikasi.

Pelatihan Team komunikasi, Perawat juga dilatih bekerja sama dengan Dokter, Ahli gizi, Farmasi, dan Tenaga kesehatan lain. Fokus pelatihan pada Kolaborasi interprofesional, Mutual respect, *Closed-loop communication* dan Pencegahan konflik komunikasi

Setelah pelatihan dilakukan evaluasi berupa observasi praktik *handover*, checklist kepatuhan SBAR, audit dokumentasi dan feedback dari kepala ruangan atau supervisor, audit dan refleksi praktik. Tujuannya untuk memastikan keterampilan komunikasi diterapkan secara konsisten.

Pelatihan memberikan dampak seperti menurunkan kesalahan komunikasi, meningkatkan keselamatan pasien, mempercepat pengambilan keputusan klinis, mempercepat pengambilan keputusan klinis, meningkatkan kerja sama tim, mempercepat pengambilan keputusan klinis, meningkatkan kepuasan pasien serta membantu kontinuitas asuhan keperawatan

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas handover dipengaruhi oleh: pengetahuan perawat, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya keselamatan pasien, dukungan rekan kerja, pelatihan komunikasi, serta sistem dokumentasi rumah sakit. Studi tahun 2025 menemukan bahwa faktor kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi handover SBAR di rumah sakit.

F. KESIMPULAN

Komunikasi efektif melalui handover merupakan bagian penting dalam pelayanan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Handover berfungsi sebagai sarana transfer informasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelayanan pasien antar tenaga kesehatan agar kontinuitas asuhan tetap terjaga.

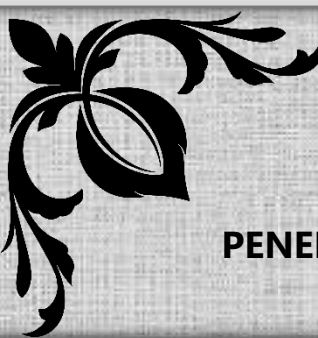
Metode komunikasi SBAR menjadi pendekatan yang paling efektif dalam handover karena mampu menyusun informasi secara sistematis, jelas, singkat, dan mudah dipahami. Penggunaan SBAR terbukti dapat meningkatkan kualitas komunikasi antar perawat, mengurangi risiko kesalahan tindakan, serta meningkatkan patient safety.

Keberhasilan handover dipengaruhi oleh kompetensi perawat, kepatuhan terhadap standar komunikasi, lingkungan kerja, serta dukungan manajemen rumah sakit. Kompetensi perawat dicapai oleh karena itu, diperlukan pelatihan komunikasi efektif, penerapan SOP handover, penggunaan bedside handover, serta pemanfaatan teknologi dokumentasi elektronik untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Dengan penerapan komunikasi efektif melalui handover yang optimal, keselamatan pasien dapat terjamin dan kualitas pelayanan keperawatan akan semakin meningkat.

Referensi

- Anwar, S., Suryani, L., & Rosmaitaliza. (2024). Hubungan komunikasi efektif dengan pelaksanaan handover. *Jurnal Health Society*, 14(2), 136–142. <https://doi.org/10.62094/jhs.v14i2.239>
- Erianti, S., Lastari, R. F., & Ennimay. (2023). Sosialisasi evaluasi penerapan komunikasi efektif SBAR dalam pelaksanaan handover oleh perawat. *Jurnal Abdimas Kesehatan*, 5(2). <https://doi.org/10.36565/jak.v5i2.502>
- Harapan, C. P., & Siswadi, Y. (2024). Efektifitas pendokumentasian keperawatan berbasis EMR terhadap efektifitas bedside handover metode SBAR: Systematic review. *Jurnal Penelitian Keperawatan Kontemporer*, 5(4). <https://doi.org/10.59894/jpkk.v5i4.1042>
- Irawati, R., Widodo, A., & Yulian, V. (2025). The effective communication using SBAR of patient handover in inpatient installation. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 18(1), 47–55. <https://doi.org/10.23917/bik.v18i1.6967>
- Krisnawati, K. M. S., & Yanti, N. P. E. D. (2023). Gambaran pengetahuan mengenai teknik komunikasi SBAR pada perawat dalam handover. *Jurnal Keperawatan*, 15(1), 221–226. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v15i1.590>
- Listi, R. R., Variza, C. R., Juia, R., Nuraeni, R. S., & Ridwan, H. (2025). Komunikasi efektif melalui peran SBAR dalam peningkatan kualitas pelayanan keperawatan: Literature review. *Jurnal Keperawatan Galuh*.
- Linda, Silvana . (2024). Factors Relating to Patient Safety Competencies in D3 Nursing Students. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*. <https://doi.org/10.33755/jkk.v10i1.6622>
- Linda,Silvana. Tukimin. (2024). Usability and Acceptibility of patient safety mobile apication in enhancing patient safety competence among nursing student in Indonesia. *Journal of Health Care Technology*. [Vol. 1 No. 1 \(2024\): Journal of Healthcare Technology](https://doi.org/10.33755/jkk.v10i1.6622)
- Pane, J., Tampubolon, L., & Nadeak, M. L. (2023). Penerapan komunikasi SBAR oleh perawat saat handover. *Jurnal Sahabat Keperawatan*, 5(2). <https://doi.org/10.32938/jsk.v5i02.50955>
- Sugiyarto, E., Anggorowati, A., Dwidiyanti, M., & Dwiantoro, L. (2023). Optimalisasi pelaksanaan komunikasi SBAR dalam handover perawat: Literatur review. *Jurnal Keperawatan*, 15(3), 1363–1370. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v15i3.11255>
- Tatiwakeng, R. V., Mayulu, N., & Larira, D. M. (2021). Hubungan penggunaan metode komunikasi efektif SBAR dengan pelaksanaan timbang terima (handover): Systematic review. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 77–88. <https://doi.org/10.35790/jkp.v9i2.367844>



CHAPTER 4



PENERAPAN METODE SBAR DALAM HANDOVER KEPERAWATAN

Ns. Fitriana Dewi, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berperan secara langsung dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, serta menjamin kesinambungan asuhan keperawatan pada setiap tahap perawatan pasien. Praktik keperawatan modern menempatkan komunikasi klinis sebagai inti dari proses kolaborasi profesional, karena hampir seluruh keputusan keperawatan, implementasi intervensi, evaluasi respons pasien, hingga koordinasi antarprofesi kesehatan sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang dilakukan oleh tenaga keperawatan. Komunikasi yang akurat, jelas, tepat waktu, dan terstruktur terbukti menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya kesalahan pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja klinis, dan mendukung terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit (1).

Salah satu bentuk komunikasi klinis yang memiliki tingkat urgensi tinggi dalam praktik keperawatan adalah hand over atau serah terima pasien antarperawat pada saat pergantian shift pelayanan. Hand over merupakan proses transfer informasi, transfer tanggung jawab profesional, serta transfer akuntabilitas pelayanan dari perawat yang selesai bertugas kepada perawat yang melanjutkan asuhan keperawatan pada shift berikutnya dan wewenang perawat yang dilakukan antar shift rutin maupun antar unit internal Rumah sakit (2). Dalam konteks pelayanan rumah sakit, hand over bukan sekadar aktivitas administratif untuk menyampaikan laporan pasien, melainkan sebuah proses klinis yang menentukan kesinambungan pelayanan, akurasi tindakan, ketepatan pengambilan keputusan, serta keselamatan pasien selama masa transisi pelayanan. Informasi yang disampaikan dalam hand over menjadi dasar bagi perawat penerima shift dalam menentukan prioritas tindakan, melanjutkan intervensi keperawatan, melakukan observasi lanjutan, serta mengantisipasi potensi komplikasi klinis yang mungkin terjadi pada pasien (3).

Meskipun hand over memiliki peran yang sangat strategis, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses serah terima pasien masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya kegagalan komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Kegagalan komunikasi saat hand over dapat berupa informasi yang tidak lengkap,

penyampaian laporan yang tidak sistematis, hilangnya data klinis penting, miskomunikasi antarpetugas, penggunaan istilah yang ambigu, hingga kegagalan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut terhadap kondisi pasien. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan intervensi, kesalahan pengobatan, duplikasi tindakan, ketidaktepatan prioritas perawatan, serta meningkatnya risiko adverse event yang berdampak langsung terhadap keselamatan pasien. Berbagai insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit secara konsisten menempatkan miskomunikasi klinis sebagai salah satu penyebab dominan terjadinya clinical error (4). Kesalahpahaman dalam berkomunikasi antar petugas kesehatan khususnya perawat merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadinya medical error terutama saat kegiatan serah terima.

Permasalahan komunikasi saat hand over semakin kompleks seiring meningkatnya beban kerja perawat, tingginya kompleksitas kasus pasien, serta kebutuhan koordinasi pelayanan yang semakin multidisiplin. Pada unit pelayanan dengan intensitas tinggi seperti ICU, IGD, NICU, ruang bedah, maupun ruang rawat inap dengan angka ketergantungan pasien yang tinggi, perawat dituntut untuk menyampaikan informasi secara cepat namun tetap akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh penerima informasi. Dalam kondisi kerja yang penuh tekanan, hand over yang dilakukan tanpa struktur komunikasi yang jelas berpotensi menyebabkan informasi penting terlewat, laporan menjadi terlalu panjang namun tidak fokus, atau sebaliknya terlalu singkat sehingga konteks klinis pasien tidak tergambarkan secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa hand over memerlukan pendekatan komunikasi yang terstruktur, terstandar, dan berbasis bukti agar mutu transfer informasi klinis dapat ditingkatkan secara konsisten (5).

Salah satu model komunikasi yang saat ini banyak direkomendasikan secara global untuk meningkatkan kualitas hand over adalah metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). SBAR merupakan alat komunikasi terstruktur yang awalnya dikembangkan dalam industri berisiko tinggi sebelum kemudian diadopsi secara luas dalam pelayanan kesehatan karena terbukti mampu meningkatkan kejelasan komunikasi, mempercepat transfer informasi, menstandarkan isi laporan klinis, dan memperkuat pengambilan keputusan profesional berbasis kondisi pasien. Dalam konteks keperawatan, SBAR membantu perawat menyampaikan laporan pasien secara sistematis dimulai dari kondisi utama pasien (Situation), latar belakang klinis yang relevan (Background), hasil pengkajian profesional (Assessment), hingga rekomendasi tindak lanjut (Recommendation). Kerangka komunikasi ini menjadikan handover lebih terarah, fokus pada masalah klinis utama, dan meminimalkan kemungkinan hilangnya informasi penting selama proses transfer tanggung jawab pelayanan (6).

Implementasi SBAR dalam hand over keperawatan telah menunjukkan berbagai manfaat yang signifikan. Sejumlah studi melaporkan bahwa penggunaan SBAR mampu meningkatkan efektivitas komunikasi antarperawat, memperjelas isi laporan pasien, meningkatkan efisiensi waktu serah terima, memperkuat koordinasi antarprofesi, meningkatkan kepercayaan diri perawat saat menyampaikan laporan klinis, serta secara bermakna menurunkan kejadian clinical error yang berkaitan dengan kegagalan komunikasi. SBAR memiliki dampak positif dalam meningkatkan komunikasi antar perawat dan meningkatkan kepuasan kerja mereka (7). Selain itu, penggunaan SBAR juga dikaitkan dengan peningkatan budaya keselamatan pasien, peningkatan kepuasan staf, dan meningkatnya konsistensi pelaksanaan handover sesuai standar pelayanan keperawatan profesional. Dengan demikian, SBAR tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai strategi mutu pelayanan yang mendukung praktik keperawatan berbasis keselamatan pasien (patient safety-based nursing practice). Pelaksanaan komunikasi SBAR dinilai memiliki hubungan yang positif dengan pelaksanaan hand over sebagai upaya dalam memaksimalkan keselamatan pasien serta komunikasi SBAR saat timbangan terima memiliki hubungan yang signifikan terhadap keselamatan pasien (8).

Dalam praktik klinis, efektivitas penerapan SBAR tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman perawat terhadap konsep komunikasi terstruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi, dukungan manajerial, ketersediaan standar operasional prosedur, pelatihan berkelanjutan, audit kepatuhan implementasi, serta integrasi SBAR dalam sistem dokumentasi klinis rumah sakit. Rumah sakit yang berhasil mengintegrasikan SBAR dalam proses hand over umumnya menunjukkan kualitas transfer informasi yang lebih baik, tingkat miskomunikasi yang lebih rendah, dan koordinasi pelayanan yang lebih efektif antar tenaga kesehatan. Sebaliknya, implementasi yang tidak konsisten dapat menyebabkan SBAR hanya menjadi formalitas dokumentasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap mutu komunikasi klinis. Oleh karena itu, penerapan SBAR harus dipahami sebagai transformasi budaya komunikasi profesional, bukan sekadar perubahan format laporan pasien (9).

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai penerapan metode SBAR dalam hand over keperawatan, dimulai dari konsep dasar hand over, urgensi komunikasi efektif dalam serah terima pasien, landasan teoritis metode SBAR, implementasi SBAR dalam praktik keperawatan di berbagai unit pelayanan, efektivitas SBAR berdasarkan temuan empiris terkini, hingga tantangan dan strategi penguatan implementasinya dalam sistem pelayanan rumah sakit modern. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun

praktis bagi pengembangan komunikasi klinis keperawatan yang lebih efektif, aman, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

B. Konsep Hand Over

Hand over dalam keperawatan adalah proses transfer informasi klinis, tanggung jawab profesional, akuntabilitas, serta kontinuitas asuhan pasien dari satu perawat kepada perawat lain atau dari satu tim pelayanan kepada tim berikutnya dalam suatu periode transisi pelayanan. Hand over merupakan bentuk komunikasi profesional yang terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh informasi penting mengenai kondisi pasien, intervensi yang telah dilakukan, respons pasien terhadap terapi, risiko klinis, serta rencana tindak lanjut dapat dipahami secara akurat oleh penerima handover sehingga kesinambungan pelayanan tetap terjaga (10).

Hand over tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menyampaikan laporan pasien pada pergantian shift, melainkan sebagai mekanisme transfer accountability. Dalam konteks ini, perawat yang menyerahkan pelayanan mentransfer tanggung jawab profesional kepada perawat penerima untuk melanjutkan pemantauan, pengambilan keputusan klinik, implementasi intervensi, serta evaluasi respons pasien secara aman dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kualitas hand over sangat menentukan mutu continuity of care dalam pelayanan keperawatan (11).

C. Klasifikasi Hand over

1. Verbal Hand Over (Hand over Lisan)

Verbal hand over adalah bentuk serah terima informasi pasien yang dilakukan secara lisan antara perawat penyerah dan perawat penerima pada saat transisi shift atau perpindahan tanggung jawab klinis. Model ini merupakan bentuk hand over yang paling lama digunakan dan masih menjadi metode dominan di banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam verbal hand over, informasi pasien disampaikan melalui komunikasi langsung, diskusi interpersonal, atau briefing singkat mengenai kondisi pasien, perubahan status kesehatan, tindakan yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut (12).

Karakteristik verbal hand over:

- a. Komunikasi tatap muka
- b. Interaktif
- c. Memungkinkan klarifikasi langsung
- d. Fleksibel
- e. Cepat dilaksanakan

Kelebihan:

- a. Memudahkan tanya jawab
- b. Meningkatkan mutual understanding
- c. Dapat menekankan prioritas klinis
- d. Membangun teamwork

Kekurangan:

- a. Berisiko kehilangan informasi
- b. Bergantung pada kemampuan komunikasi
- c. Tidak terdokumentasi secara lengkap
- d. Dapat dipengaruhi distraksi lingkungan

2. Written Hand Over (Hand Over Tertulis)

Written hand over merupakan proses serah terima pasien menggunakan catatan tertulis, formulir hand over, nursing note, checklist, atau lembar laporan terstruktur sebagai media utama transfer informasi klinis. Model ini bertujuan meningkatkan akurasi dokumentasi, kelengkapan informasi, dan legal accountability dalam praktik keperawatan (13).

Karakteristik Written hand over:

- a. Berbasis dokumen
- b. Terstruktur
- c. Dapat disimpan sebagai rekam jejak
- d. Memudahkan audit mutu

Kelebihan:

- a. Informasi lebih konsisten
- b. Mengurangi ketergantungan pada ingatan
- c. Meningkatkan akuntabilitas
- d. Mempermudah continuity of care

Keterbatasan:

- a. Cenderung kurang interaktif
- b. Dapat terjadi overload informasi
- c. Membutuhkan waktu dokumentasi lebih lama

3. Bedside Hand Over

Bedside hand over adalah proses serah terima yang dilakukan di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien secara langsung dalam komunikasi klinis (14). Model ini berkembang sebagai pendekatan patient-centered communication, karena pasien diberi kesempatan untuk:

- a. Mendengar kondisi kesehatannya
- b. Memverifikasi informasi
- c. Menyampaikan keluhan
- d. Ikut terlibat dalam rencana perawatan

Karakteristik Bedside Hand Over:

- a. Dilakukan di ruang pasien
- b. Observasi klinis langsung
- c. Melibatkan pasien/ keluarga
- d. Transparan

Kelebihan:

- a. Meningkatkan patient engagement
- b. Memvalidasi kondisi pasien secara real time
- c. Meningkatkan kepuasan pasien
- d. Memperkuat therapeutic communication
- e. Menurunkan omission of care

Kelemahan:

- a. Isu privasi
- b. Tidak semua informasi sensitif dapat dibahas
- c. Memerlukan keterampilan komunikasi tinggi
- d. Lebih memakan waktu

4. Tape-Recorded Hand Over

Tape-recorded hand over adalah hand over menggunakan rekaman suara yang dibuat oleh perawat shift sebelumnya untuk didengarkan oleh perawat shift berikutnya. Metode ini pernah banyak digunakan untuk efisiensi waktu, terutama pada unit dengan beban kerja tinggi.

Kelebihan:

- a. Hemat waktu
- b. Penyampaian konsisten
- c. Dapat diputar ulang

Kekurangan:

- a. Komunikasi satu arah
- b. Tidak ada klarifikasi langsung
- c. Informasi bisa menjadi using
- d. Kurang sesuai dengan model komunikasi modern

Karena keterbatasan interaksi, metode ini kini relatif jarang digunakan.

5. Electronic Hand Over

Electronic hand over merupakan serah terima pasien menggunakan sistem digital seperti:

- a. Electronic Health Record (EHR)
- b. Nursing dashboard
- c. Digital shift report
- d. Aplikasi handover berbasis web/ mobile

Model ini berkembang pesat dalam sistem rumah sakit modern berbasis teknologi informasi.

Karakteristik Electronic Hand Over:

- a. Real-time data
- b. Terintegrasi dengan rekam medis
- c. Akurat
- d. Mudah diakses

Keunggulan:

- a. Meningkatkan kelengkapan data
- b. Menurunkan transcription error
- c. Memudahkan tracking
- d. Mempercepat akses informasi
- e. Mendukung audit mutu

Tantangan:

- a. Ketergantungan sistem IT
- b. Keamanan data
- c. Kebutuhan pelatihan staf
- d. Biaya implementasi tinggi

6. Structured Hand Over

Structured hand over adalah hand over menggunakan format baku/ standar komunikasi klinis (13).

Contoh:

- a. SBAR
- b. ISBAR
- c. I-PASS
- d. SOAP-based handoff

Model ini saat ini paling direkomendasikan dalam patient safety practice karena:

- a. Sistematis
- b. Ringkas
- c. Lengkap
- d. Fokus pada prioritas klinis

Keunggulan:

- a. Mengurangi variasi komunikasi
- b. Meningkatkan kejelasan
- c. Mengurangi missed information
- d. Meningkatkan keselamatan pasien

7. Inter-Unit Hand Over

Merupakan hand over saat pasien berpindah unit, misalnya:

- a. IGD → ICU
- b. ICU → ruang rawat inap
- c. Ruang operasi → recovery room
- d. Rawat inap → rehabilitasi

Jenis ini bersifat high-risk transition karena kompleksitas informasi sangat tinggi.

8. Interprofessional Hand Over

Merupakan transfer informasi lintas profesi, misalnya:

- a. Perawat → dokter
- b. Perawat → fisioterapis
- c. ICU team → palliative team

Model ini menekankan collaborative communication.

D. Konsep Metode SBAR

Metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) merupakan suatu kerangka komunikasi klinis terstruktur yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi pasien secara sistematis, singkat, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan klinis yang paling penting (15). SBAR dikembangkan sebagai model komunikasi yang mampu menstandarkan pertukaran informasi dalam situasi klinis yang membutuhkan ketepatan, kecepatan, dan akurasi dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan, SBAR digunakan sebagai pendekatan komunikasi profesional untuk memfasilitasi penyampaian kondisi pasien secara logis, mulai dari identifikasi masalah utama hingga rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya. Pendekatan komunikasi ini dinilai efektif karena membantu perawat mengorganisasi pikiran klinis sebelum menyampaikan laporan pasien, sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih logis, terstruktur, dan mudah dipahami (16).

E. Komponen SBAR

1. Situation

Komponen pertama dalam SBAR adalah Situation, yaitu penyampaian kondisi utama pasien secara singkat, langsung, dan fokus pada masalah klinis yang sedang dihadapi pasien. Bagian ini berfungsi sebagai pembuka komunikasi yang membantu penerima informasi segera memahami konteks utama laporan tanpa harus memilah informasi yang tidak relevan terlebih dahulu. Pada tahap ini, perawat biasanya menyampaikan identitas pasien, diagnosis utama, perubahan

kondisi terkini, atau kejadian klinis akut yang memerlukan perhatian segera. Kejelasan pada tahap Situation sangat penting karena tahap awal komunikasi menentukan arah fokus klinis pada keseluruhan proses pertukaran informasi selanjutnya. Studi implementasi SBAR menunjukkan bahwa komponen Situation meningkatkan kecepatan pemahaman kondisi pasien oleh perawat penerima shift sehingga respons klinis dapat diberikan lebih cepat. Dengan penyampaian situasi yang terarah, risiko komunikasi bertele-tele atau kehilangan inti masalah dapat diminimalkan secara signifikan (9).

2. Background

Komponen kedua adalah Background, yaitu informasi latar belakang klinis yang mendukung pemahaman terhadap kondisi pasien saat ini. Bagian ini mencakup diagnosis medis, riwayat penyakit, terapi yang sedang berjalan, alergi, hasil pemeriksaan penting, tindakan yang telah dilakukan, dan respons pasien terhadap intervensi sebelumnya. Penyampaian latar belakang klinis yang adekuat membantu penerima informasi memahami hubungan antara kondisi saat ini dengan perjalanan klinis pasien sebelumnya. Informasi Background juga penting untuk mencegah terjadinya clinical gap, yaitu kondisi ketika pengambil keputusan klinis tidak memiliki konteks yang cukup untuk menentukan tindakan yang tepat (17). Tanpa informasi latar belakang yang jelas, keputusan keperawatan dapat menjadi tidak optimal karena penilaian dilakukan tanpa memahami akar masalah klinis pasien. Oleh karena itu, komponen Background memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kesinambungan pelayanan keperawatan dan akurasi tindak lanjut klinis pada shift berikutnya.

3. Assessment

Komponen Assessment merupakan bagian inti yang menunjukkan hasil pengkajian klinis perawat terhadap kondisi pasien berdasarkan data objektif maupun subjektif yang ditemukan selama observasi. Pada tahap ini, perawat diharapkan mampu menyampaikan interpretasi profesional terhadap kondisi pasien, bukan hanya menyebutkan data mentah hasil pengukuran atau observasi. Komponen ini memperlihatkan bahwa SBAR bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat yang memperkuat critical thinking dan clinical judgment dalam praktik keperawatan.

Perawat perlu menyampaikan hasil penilaian mengenai stabilitas kondisi pasien, adanya tanda perburukan klinis, respons terhadap terapi, atau potensi komplikasi yang perlu diantisipasi. Assessment yang akurat memungkinkan tenaga kesehatan lain memahami urgensi kondisi pasien secara lebih objektif dan mempersiapkan tindakan yang sesuai. Kemampuan menyampaikan Assessment

secara tepat terbukti berkaitan dengan menurunnya risiko keterlambatan intervensi klinis pada pasien yang mengalami perubahan kondisi akut (18).

4. Recommendation

Komponen terakhir yaitu Recommendation, yang berisi saran tindakan, tindak lanjut, atau keputusan klinis yang direkomendasikan berdasarkan kondisi pasien saat itu. Bagian ini merupakan karakteristik utama SBAR yang membedakannya dari model komunikasi tradisional karena komunikasi diarahkan pada solusi, bukan berhenti pada pelaporan masalah. Perawat dapat memberikan rekomendasi berupa observasi lanjutan, kebutuhan monitoring khusus, kolaborasi dengan profesi lain, penyesuaian intervensi keperawatan, atau kebutuhan eskalasi pelayanan medis. Kejelasan rekomendasi membantu penerima informasi memahami langkah berikutnya secara konkret sehingga kesinambungan pelayanan dapat berlangsung lebih efektif. Komponen Recommendation juga meningkatkan akuntabilitas profesional perawat karena mendorong perawat untuk berpikir antisipatif terhadap kebutuhan pasien. Dalam implementasi klinis, bagian rekomendasi yang jelas terbukti meningkatkan koordinasi tim, mempercepat respons klinis, dan mengurangi miskomunikasi terkait tindak lanjut pelayanan pasien (19).

Tabel 4. 1 Contoh Kegiatan Hand Over di ruangan dengan menggunakan Metode SBAR

Komponen SBAR	Perawat Shift Sebelumnya	Perawat Shift Berikutnya
Situation	"Selamat pagi. Saya akan melaporkan pasien atas nama Bapak Ahmad, usia 58 tahun, dirawat di ruang Aqsa bed 03 dengan diagnosis medis Gagal Jantung Kongestif. Saat ini pasien mengalami sesak napas ringan dan saturasi oksigen menurun menjadi 92% dengan nasal kanul 3 liter/ menit."	"Baik, pasien atas nama Bapak Ahmad dengan CHF dan saat ini masih sesak ringan dengan saturasi 92% serta menggunakan oksigen 3 liter/ menit."
Background	"Pasien masuk dua hari yang lalu dengan keluhan sesak memberat dan edema tungkai. Riwayat Hipertensi dan	"Baik, pasien memiliki riwayat hipertensi dan DM serta sedang

Komponen SBAR	Perawat Shift Sebelumnya	Perawat Shift Berikutnya
	Diabetes Melitus sejak 10 tahun lalu. Terapi yang sedang diberikan antara lain furosemid injeksi, candesartan, dan insulin sliding scale. Hasil foto toraks menunjukkan edema paru ringan."	mendapatkan terapi diuretik dan insulin."
Assessment	"Hasil pengkajian terakhir menunjukkan tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 104 kali/menit, respirasi 26 kali/menit, suhu 36,8°C. Bunyi napas ronki basah di kedua basal paru masih terdengar. Produksi urine dalam 8 jam terakhir sekitar 900 cc. Pasien tampak cemas tetapi compos mentis."	"Baik, kondisi hemodinamik relatif stabil tetapi pasien masih mengalami takipnea dan ronki paru."
Recommendation	"Mohon observasi ketat status respirasi dan saturasi oksigen setiap 2 jam. Kolaborasi bila saturasi turun di bawah 90% atau sesak memberat. Monitoring balance cairan tetap dilanjutkan dan edukasi pembatasan cairan dipertahankan."	"Baik, saya lanjutkan monitoring respirasi, balance cairan, dan observasi tanda perburukan pasien."

F. Manfaat Metode SBAR dalam Handover Keperawatan

Metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) merupakan model komunikasi terstruktur yang banyak digunakan dalam proses hand over keperawatan untuk meningkatkan efektivitas transfer informasi klinis antar tenaga kesehatan. Penggunaan SBAR dalam hand over memberikan berbagai manfaat baik bagi perawat, pasien, maupun organisasi pelayanan kesehatan karena

membantu menciptakan komunikasi yang sistematis, akurat, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SBAR mampu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan serta menurunkan risiko kesalahan komunikasi yang dapat membahayakan pasien.

1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Perawat

Kelebihan utama metode SBAR adalah kemampuannya meningkatkan efektivitas komunikasi antar tenaga kesehatan selama proses hand over. SBAR membantu perawat menyusun informasi berdasarkan urutan yang logis sehingga isi laporan menjadi lebih mudah dipahami oleh penerima informasi. Komunikasi yang sebelumnya sering tidak terarah, berulang, atau terlalu panjang menjadi lebih fokus pada masalah klinis utama pasien. Dengan adanya struktur komunikasi yang jelas, perawat dapat menyampaikan informasi penting tanpa melewatkan data klinis yang relevan (20). Penggunaan SBAR juga membantu mengurangi penggunaan bahasa ambigu atau istilah yang tidak spesifik selama proses pelaporan pasien. Kondisi ini meningkatkan kejelasan komunikasi dan meminimalkan risiko salah interpretasi terhadap kondisi pasien. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan SBAR secara konsisten meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal dan profesional antarperawat di ruang rawat inap maupun unit intensif (21).

2. Menurunkan Risiko Clinical Error dan Medication Error

SBAR terbukti efektif dalam menurunkan kejadian clinical error yang disebabkan oleh kegagalan komunikasi saat pergantian shift pelayanan. Kesalahan komunikasi selama hand over sering menjadi penyebab keterlambatan tindakan, kesalahan terapi, duplikasi intervensi, maupun ketidaktepatan pengambilan keputusan klinis. Melalui komunikasi yang terstruktur, SBAR membantu memastikan bahwa seluruh informasi penting pasien tersampaikan secara lengkap kepada perawat penerima shift. Informasi mengenai alergi obat, perubahan kondisi pasien, terapi yang sedang berjalan, hingga tindakan prioritas menjadi lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti secara tepat. Kejelasan rekomendasi dalam SBAR juga membantu mencegah kesalahan tindak lanjut akibat kurangnya instruksi klinis yang jelas. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi SBAR berhubungan dengan penurunan angka medication error, peningkatan ketepatan pemberian obat, dan peningkatan keselamatan pasien di rumah sakit. Dengan demikian, SBAR menjadi salah satu strategi komunikasi yang mendukung budaya patient safety dalam pelayanan kesehatan modern (22).

3. Meningkatkan Kesenambungan Asuhan Keperawatan

Penggunaan SBAR membantu menjaga kesinambungan pelayanan pasien dari satu shift ke shift berikutnya. Informasi yang disampaikan secara sistematis membuat perawat penerima shift lebih mudah memahami kondisi pasien secara menyeluruh dan melanjutkan intervensi yang telah direncanakan sebelumnya. Kesenambungan asuhan sangat penting dalam mencegah terjadinya kesalahan akibat putusnya informasi klinis selama transisi pelayanan. Dengan adanya SBAR, proses transfer tanggung jawab pelayanan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Perawat penerima shift juga lebih siap menghadapi kemungkinan perubahan kondisi pasien karena telah memperoleh informasi yang lengkap mengenai status klinis pasien sebelumnya. Hal ini menjadikan proses pelayanan lebih aman, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kemampuan Critical Thinking Perawat

Metode SBAR tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis (critical thinking) perawat dalam praktik klinis. Saat menggunakan SBAR, perawat dituntut mampu mengidentifikasi masalah utama pasien, menentukan informasi yang relevan, melakukan analisis kondisi pasien, dan memberikan rekomendasi tindakan yang sesuai. Proses tersebut secara tidak langsung melatih kemampuan clinical reasoning dan clinical judgment dalam pengambilan keputusan keperawatan. Perawat menjadi lebih terbiasa berpikir sistematis dan berbasis data ketika menyampaikan laporan pasien (15). Kemampuan berpikir kritis yang baik sangat penting dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan SBAR secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan analisis klinis perawat saat melakukan hand over maupun konsultasi klinis.

5. Meningkatkan Efisiensi Waktu Handover

Kelebihan lain dari penggunaan SBAR adalah meningkatkan efisiensi waktu selama pelaksanaan hand over. Komunikasi yang terstruktur membuat laporan pasien menjadi lebih singkat namun tetap mencakup seluruh informasi penting yang dibutuhkan. Tidak perlu mengulang informasi yang tidak relevan atau memberikan penjelasan yang terlalu panjang di luar konteks klinis utama pasien. Efisiensi waktu sangat penting terutama pada unit pelayanan dengan tingkat kesibukan tinggi seperti ICU, IGD, dan ruang rawat inap dengan jumlah pasien yang banyak. Pelaksanaan hand over yang efisien memungkinkan perawat memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan observasi pasien dan intervensi keperawatan secara langsung. Dengan demikian, produktivitas pelayanan

keperawatan dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas komunikasi klinis yang dilakukan (23).

6. Meningkatkan Kerja Sama Tim dan Kolaborasi Antarprofesi

SBAR juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas kerja sama tim (teamwork) antar tenaga kesehatan. Komunikasi yang sistematis memudahkan dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya memahami kondisi pasien dengan cara yang seragam. Keceragaman pola komunikasi membantu mengurangi kesalahpahaman dalam proses koordinasi pelayanan pasien. Selain itu, SBAR menciptakan budaya komunikasi profesional yang lebih terbuka dan terarah dalam lingkungan kerja klinis. Perawat menjadi lebih percaya diri ketika menyampaikan kondisi pasien kepada dokter karena memiliki kerangka komunikasi yang jelas dan profesional. Hubungan kolaboratif yang baik antar tenaga kesehatan terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat budaya keselamatan pasien di rumah sakit (16).

7. Meningkatkan Kepuasan Pasien dan Mutu Pelayanan

Implementasi SBAR dalam hand over juga berdampak positif terhadap kepuasan pasien dan mutu pelayanan keperawatan. Komunikasi yang jelas dan terstruktur membuat pelayanan menjadi lebih terorganisasi dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Pasien merasa lebih aman karena informasi mengenai kondisi dan rencana perawatan mereka tersampaikan secara konsisten antar shift pelayanan. Pada pelaksanaan bedside hand over, pasien bahkan dapat ikut berpartisipasi dalam proses klarifikasi informasi sehingga meningkatkan keterlibatan pasien dalam pelayanan (patient engagement). Peningkatan partisipasi pasien terbukti memperkuat hubungan terapeutik antara pasien dan perawat serta meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan rumah sakit. Dengan demikian, penerapan SBAR tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi internal tenaga kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (21).

G. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Metode SBAR dalam Handover Keperawatan

Meskipun metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) telah terbukti efektif meningkatkan kualitas komunikasi klinis, implementasinya dalam praktik hand over keperawatan di rumah sakit tidak selalu berjalan optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SBAR sangat dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, budaya kerja, serta dukungan sistem pelayanan kesehatan. Hambatan implementasi ini dapat

menyebabkan penggunaan SBAR menjadi tidak konsisten, tidak lengkap, atau hanya dilakukan sebagai formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap kualitas komunikasi klinis.

1. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Perawat tentang SBAR

Salah satu hambatan utama implementasi SBAR adalah keterbatasan pengetahuan perawat mengenai konsep, tujuan, dan cara penggunaan SBAR secara tepat dalam komunikasi klinis. Sebagian perawat memahami SBAR hanya sebagai format dokumentasi, bukan sebagai kerangka berpikir klinis dalam menyampaikan informasi pasien. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan laporan pasien masih sering dilakukan secara naratif, tidak sistematis, dan belum mengikuti urutan komunikasi yang terstruktur. Perawat juga kerap mengalami kesulitan membedakan informasi mana yang seharusnya masuk ke komponen Situation, Background, Assessment, atau Recommendation (24). Ketidakjelasan ini membuat isi hand over menjadi tidak fokus dan informasi klinis penting berpotensi terlewat. Studi pendidikan keperawatan terbaru menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi berbasis SBAR sangat dipengaruhi oleh pelatihan formal dan pembelajaran berulang melalui simulasi klinis.

2. Beban Kerja Perawat yang Tinggi

Beban kerja yang tinggi merupakan hambatan signifikan dalam penerapan SBAR secara konsisten. Pada unit pelayanan dengan rasio pasien-perawat yang tidak seimbang, perawat sering mengalami keterbatasan waktu untuk mempersiapkan hand over secara komprehensif. Akibatnya, komunikasi selama serah terima cenderung dilakukan secara singkat, terburu-buru, dan berorientasi pada penyelesaian tugas, bukan kualitas transfer informasi. Kondisi kelelahan fisik dan mental akibat beban kerja tinggi juga dapat menurunkan konsentrasi perawat saat melakukan pelaporan pasien. Hal ini meningkatkan risiko lupa menyampaikan data penting seperti perubahan kondisi pasien, hasil pemeriksaan terbaru, maupun tindak lanjut klinis yang harus dilakukan. Dalam situasi kerja yang sangat padat, penerapan SBAR sering dianggap menambah beban administratif, padahal esensinya justru meningkatkan efisiensi komunikasi (25).

3. Keterbatasan Waktu saat Pergantian Shift

Waktu pergantian shift sering menjadi periode yang sibuk di unit pelayanan rumah sakit. Pada waktu yang sama, perawat harus menyelesaikan dokumentasi, mempersiapkan laporan pasien, menanggapi kebutuhan pasien, serta melakukan koordinasi dengan profesi lain (26). Tekanan waktu tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan hand over tidak dilakukan secara mendalam. Perawat cenderung hanya menyampaikan informasi inti secara singkat tanpa elaborasi klinis yang cukup. Komponen Assessment dan Recommendation sering kali menjadi bagian

yang paling banyak terabaikan karena dianggap membutuhkan analisis lebih lanjut. Padahal kedua komponen tersebut justru merupakan inti dari komunikasi klinis yang aman dalam model SBAR.

4. Budaya Komunikasi yang Belum Terstruktur

Budaya komunikasi organisasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi SBAR. Di beberapa rumah sakit, praktik komunikasi antar tenaga kesehatan masih bersifat informal, kebiasaan verbal, dan bergantung pada gaya komunikasi masing-masing individu. Budaya kerja seperti ini membuat standar komunikasi terstruktur sulit diterapkan secara konsisten. Perawat yang terbiasa dengan pola komunikasi bebas kadang merasa SBAR terlalu kaku atau membatasi cara mereka menyampaikan informasi. Selain itu, jika pimpinan unit tidak memberi contoh penggunaan komunikasi terstruktur, staf cenderung kembali menggunakan pola komunikasi lama. Perubahan budaya komunikasi membutuhkan waktu, pembiasaan, dan komitmen organisasi secara menyeluruh (24).

5. Resistensi terhadap Perubahan

Penerapan SBAR sering menghadapi resistensi dari tenaga kesehatan yang telah lama bekerja dengan sistem komunikasi tradisional. Sebagian staf merasa metode lama sudah cukup efektif sehingga tidak melihat urgensi perubahan ke model komunikasi baru. Ada pula persepsi bahwa penggunaan SBAR memperpanjang proses hand over atau menambah beban kerja. Resistensi ini umumnya muncul ketika implementasi SBAR dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa pelatihan, atau tanpa menjelaskan manfaat klinisnya secara nyata. Kurangnya keterlibatan staf dalam proses perubahan organisasi juga dapat meningkatkan penolakan terhadap inovasi komunikasi seperti SBAR (27). Akibatnya, kepatuhan implementasi menjadi rendah dan penggunaan SBAR tidak berkelanjutan.

6. Kurangnya Dukungan Manajemen dan Supervisi

Keberhasilan implementasi SBAR sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen rumah sakit. Jika rumah sakit tidak memiliki SOP hand over yang jelas, format dokumentasi yang mendukung, maupun kebijakan komunikasi klinis yang baku, maka implementasi SBAR akan sulit dipertahankan. Kepala ruangan, manajer keperawatan, dan supervisor klinik berfungsi sebagai role model, fasilitator pelatihan, serta pengawas mutu pelaksanaan hand over berbasis SBAR (24). Kurangnya supervisi dari kepala ruangan atau manajer keperawatan juga menyebabkan pelaksanaan SBAR tidak terpantau secara konsisten. Tanpa audit dan umpan balik, staf tidak mengetahui apakah komunikasi yang mereka lakukan sudah sesuai standar atau belum. Dukungan manajemen juga penting dalam

penyediaan pelatihan, workshop, simulasi, dan penguatan budaya keselamatan pasien berbasis komunikasi efektif.

7. Keterbatasan Sarana Dokumentasi dan Teknologi

Hambatan lain adalah belum terintegrasinya format SBAR dalam sistem dokumentasi rumah sakit. Di banyak fasilitas kesehatan, dokumentasi hand over masih dilakukan secara manual, tidak standar, atau berbeda antar unit pelayanan. Hal ini membuat konsistensi isi komunikasi menjadi sulit dijaga. Ketidadaan checklist atau template SBAR menyebabkan perawat harus mengingat sendiri komponen komunikasi yang harus disampaikan. Pada era digital, integrasi SBAR ke dalam rekam medis elektronik (electronic medical record) menjadi kebutuhan penting untuk mendukung implementasi yang lebih sistematis dan efisien (27).

8. Variasi Kompetensi Klinis Perawat

Tidak semua perawat memiliki tingkat pengalaman dan kemampuan analisis klinis yang sama. Perawat baru sering mengalami kesulitan menyusun Assessment dan Recommendation yang tepat karena keterbatasan pengalaman klinis. Sebaliknya, perawat senior kadang menyampaikan informasi berdasarkan asumsi pengalaman tanpa mengikuti struktur komunikasi yang baku (25). Perbedaan kompetensi ini dapat menyebabkan kualitas hand over tidak seragam antar staf. Pelatihan berjenjang dan mentoring klinis menjadi strategi penting untuk mengatasi hambatan ini.

H. Kesimpulan

Hambatan implementasi SBAR dalam hand over keperawatan bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, organisasi, budaya kerja, sumber daya, dan sistem pelayanan. Kurangnya pengetahuan, tingginya beban kerja, keterbatasan waktu, budaya komunikasi yang belum terstruktur, resistensi perubahan, lemahnya dukungan manajemen, keterbatasan teknologi, serta variasi kompetensi klinis merupakan faktor-faktor yang paling sering menghambat implementasi SBAR di rumah sakit. Oleh karena itu, strategi implementasi SBAR tidak cukup hanya melalui penyusunan SOP, tetapi juga harus disertai pelatihan berkelanjutan, supervisi, audit mutu, serta penguatan budaya komunikasi profesional di lingkungan pelayanan kesehatan.

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu komponen utama dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Dalam praktik keperawatan, proses hand over menjadi titik kritis dalam kesinambungan pelayanan karena pada tahap ini terjadi transfer informasi klinis, tanggung jawab profesional, dan akuntabilitas pelayanan antar perawat pada setiap pergantian shift. Kegagalan

komunikasi selama hand over dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi, keterlambatan tindakan, kesalahan terapi, hingga peningkatan risiko clinical error yang berdampak langsung terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode komunikasi yang terstruktur, sistematis, dan berbasis keselamatan pasien untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hand over keperawatan. Metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) hadir sebagai salah satu pendekatan komunikasi klinis yang efektif dalam mendukung pelaksanaan hand over di rumah sakit. SBAR membantu perawat menyampaikan informasi pasien secara ringkas, jelas, terarah, dan relevan sehingga mempermudah penerima informasi memahami kondisi pasien secara cepat dan akurat. Melalui struktur komunikasi yang sistematis, SBAR mampu meningkatkan efektivitas komunikasi antar tenaga kesehatan, memperkuat koordinasi pelayanan, serta menjaga kesinambungan asuhan keperawatan antar shift pelayanan. Selain itu, penggunaan SBAR juga terbukti mampu meningkatkan kemampuan critical thinking, clinical reasoning, dan rasa percaya diri perawat dalam menyampaikan laporan klinis secara profesional.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SBAR memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penggunaan SBAR terbukti menurunkan risiko miskomunikasi, mengurangi kejadian medication error, mempercepat respons klinis terhadap perubahan kondisi pasien, serta memperkuat budaya patient safety di lingkungan rumah sakit. Penerapan SBAR juga meningkatkan efisiensi waktu hand over, memperbaiki kualitas dokumentasi klinis, dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Dengan demikian, SBAR tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan modern. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi SBAR sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan manajemen rumah sakit, ketersediaan standar operasional prosedur, budaya komunikasi organisasi, pelatihan berkelanjutan, serta kepatuhan perawat dalam menerapkan komunikasi terstruktur pada setiap proses hand over. Tanpa dukungan sistem yang baik, penggunaan SBAR dapat menjadi sekadar formalitas dokumentasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas komunikasi klinis.

Upaya penerapan metode ini dalam kegiatan hand over memerlukan komitmen bersama dari seluruh tenaga kesehatan dan pihak manajemen rumah sakit untuk menjadikan SBAR sebagai budaya komunikasi profesional dalam praktik pelayanan sehari-hari. Melalui penerapan SBAR yang konsisten dan berkesinambungan, diharapkan kualitas komunikasi klinis dalam pelayanan keperawatan dapat terus meningkat sehingga tercipta pelayanan yang lebih aman,

efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien (28). Pengembangan pelatihan komunikasi berbasis SBAR, evaluasi kepatuhan pelaksanaan hand over, serta integrasi SBAR dalam sistem dokumentasi elektronik rumah sakit dapat menjadi strategi penting untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan di masa mendatang. Dengan demikian, metode SBAR layak dipertahankan dan dikembangkan sebagai standar komunikasi profesional dalam pelaksanaan hand over keperawatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit.

Referensi

- Exploring the Impact of the SBAR on Nursing Handover: A Scoping Review.* Nurfairry Soed, Salizar Mohamed Ludin, Syed Nurulakla Syed Abdullah, and Rasha Al-Zahrawi. Malaysia : The Malayasia Journal of Nursing, 2025, Vol. 17. 1.
- Overview of the Implementation of Handover in Hospital: Literature Review.* Sudrajat, D., Islamiati, M., & Lindayani, L. Jawa Barat : Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing), 2021, Vol. 7. 1.
- Impact of the Communication and Patient Hand-off Tool SBAR on Patient Safety: A Systematic Review.* Martin Müller, Jonas Jürgens, Marcus Redaelli, Karsten Klingberg, Wolf E Hautz, and Stephanie Stock. Germany : BMJ Open, 2023.
- Investigating the Impact of Implementing Structured Patient Handover Through the SBAR Model on Clinical Errors of Nurses in the Emergency Department.* Narges Toghian Chaharsoughi, Mohammad Nasr Esfahani, Shahnaz Alikhah, Maryam Moghimian. Isfahan Iran : Journal of Education and Health Promotion, 2025, Vol. 14.
- Assessment of Clinical Handover among ICU Nurses Based on the Structured ISBAR Model.* Marzie Yari, Fatemeh Sadat Izadi-Avanji , Mahdieh Sabery. Kashan Iran : BMC Nursing, 2026.
- Indonesia, Persatuan Perawat Nasional. Metode SBAR Bagi Perawat : Format Komunikasi Terstruktur Bantu Sampaikan Infomasi. 2025.
- Evaluation of the Situation, Background, Assessment, and Recommendation Handover Tool in Improving Communication and Satisfaction Among Jordanian Nurses Working in Intensive Care Units.* Dalky, Heyam Fawaz PhD, RN, Al-Jaradeen, Rawan Salem MSc, RN and AbuAlRub, Raeda Fawzi PhD, RN. Jordan : Dimensions of Critical Care Nursing, 2020, Vol. 39. 6.
- Studi Literatur: Penerapan Komunikasi SBAR dalam Pelaksanaan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (Studi di Indonesia).* Risma Ainun Shafira, Inge Dhamanti. Surabaya : Media Gizi Kemas, 2023, Vol. 12. 1.
- Astuti, . *Komunikasi SBAR dalam Pelayanan Keperawatan.* Pekalongan Jawa Tengah : NEM, 2022.
- Nursing Shift Handover Methods and Their Impact on Patient Safety.* Kavitha N. K., M. Abi Rami, P. Vanaja, Manjula A. K., Justin Jaspher M., Israel Jeba Prabu D., Lakshimi K., Jyoti Katiyar, Mohammed Umar, N. Prabha. Karnataka India : International Journal of Research in Medical Sciences, 2026, Vol. 14. 4.
- Enhancing Nursing Care through Electronic-Based Handover in Hospital Settings: A Systematic Review.* Enniq Mazayudha, Daviq Ayatulloh, Diah Priyantini

- and Nursalam. Jawa Barat Indonesia : Fundamental and Management Nursing Journal, 2026, Vol. 9. 1.
- Nursing Communication and Continuity of Care in Clinical Handover: Global Standards update.* Geneva : International Council of Nurses , 2024.
- Impact of Structured Clinical Handover Protocol on Communication and Patient Satisfaction.* Sayani Ghosh, Lakshmi Ramamoorthy, Biju Pottakat. Puducherry India : Sage Journal, 2021.
- Bedside Nursing Handover and Patient-Centered Communication Outcomes: systematic review.* Georgia Tobiano, Tracey Bucknall, Ishtar Sladdi, Jennifer A. Whitty, Wendy Chaboyer. Australia : International Journal of Nursing Studies., 2018.
- Comparison of the SBAR Method and Modified Handover Model on Handover Quality and Nurse Perception in the Emergency Department: A quasi-Experimental Study.* Atefeh Alizadeh-risani, Fatemeh Mohammadkhah, Ali Pourhabib, Zahra Fotokian & Marziyeh Khatooni. Iran : BMC Nursing, 2024, Vol. 23.
- The Effective Communication Nursing SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) of Patient Handover in Inpatient Installation.* Roossy Irawati, Arif Widodo, Vinami Yulian. Jawa Tengah : Jurnal Berita Ilmu Keperawatan, 2025, Vol. 18. 1.
- Modul Praktikum Nursing Mangement.* Nopriyanty, . Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- The Relationship Between Nurses' Knowledge About CPPT And the Implementation of Handover Using the SBAR Method With the Quality of Nursing Care.* Rizki Yeni Wulandari, Yunina Elasari, Surmiasih, Jingga Jingga Marsanda. Banjarmasin : Journal of Nursing Invention, 2025, Vol. 6. 1.
- Use of Structured Handoff Protocols for Within-Hospital Unit Transitions: a Systematic Review from Making Healthcare Safer IV.* Sean McCarthy, Aneesa Motala, Emily Lawson, Paul G Shekelle. Los Angeles : The Health Foundation, 2025.
- Quantifying Acute Care Nurses' Experiences of Patient Handoffs During Shift Change: A Cross-Sectional Study.* Watson, Vivek Kaliraman and Joni L. Los Angeles : BMC Nursing, 2025.
- The Influence of Nurse Motivation on the Implementation of SBAR Communication during Handover.* Rosadatin Chandrawati, Puguh Widiyanto, Sri Hananto Ponco Nugroho. Semarang : Media Keperawatan Indonesia, 2025.
- Implementation and Evaluation of the SBAR Communication Model in Nursing Handover by Pediatric Surgery Nurses.* Berrin Pazar, RN, PhD, Oznur Kavakli, RN, PhD, Ecem Naz Ak, RN, Elif Emel Erten, MD. 5, Canada : Journal of Perianesthesia Nursing, 2024, Vol. 39.

- Comparison of the Effectiveness of Sbar and I-PASS Communication Methods in Nurse Handover: Literature Review.* Khotijah, Wastu Adi Mulyono. Kendal : Home / Archives / Vol 7 No 5 (2025): Indonesian Journal of Global Health Research, 2025, Vol. 7. 5.
- Faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Serah Terima menggunakan Teknik SBAR.* Ika Purwaningsih, Ratnasari, Arief Yanto. Sumba : Jurnal Keperawatan Sumba, 2025, Vol. 3. 2.
- Implementation of SBAR Communication among Nurses during Handover between Shifts before and after a Mini Seminar in the Mawar Inpatient Ward, West Kalimantan.* Ignasius Yogi Pratama, Lidya Maryani. Bengkulu : Indonesian Journal of Health Research and Development, 2026, Vol. 4. 1.
- Communication handover barriers among nurses and paramedics in emergency care settings.* AlShammari, Samer Al Haliq & Talal. Saudi Arabia : BMC Nursing, 2025, Vol. 24. 634.
- Optimalisasi Handover Perawat dengan Komunikasi SBAR Berbasis Elektronik.* Krisna Yetti, Tuti Afriani. Lubuk Linggau : JournalJournal of Telenursing (Joting), 2024, Vol. 6. 2.
- A Systematic Review on the Structured Handover Interventions Between Nurses in Improving Patient Safety Outcomes.* Ming Xuan Bukoh BHN, RN, Chiew-Jiat Rosalind Siah PhD, RN. s.l. : Journal of Nursing Management, 2019.



CHAPTER 5

FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS HANDOVER

Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan keperawatan berlangsung selama 24 jam secara terus-menerus sehingga membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan, khususnya pada saat pergantian shift perawat. Salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting dalam proses tersebut adalah handover atau timbang terima pasien. Handover merupakan proses pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan informasi pasien dari satu perawat kepada perawat lainnya untuk menjamin kontinuitas pelayanan dan keselamatan pasien selama masa perawatan di rumah sakit (Potter & Perry, 2021).

Handover yang berkualitas harus dilakukan secara sistematis, akurat, lengkap, jelas, dan tepat waktu agar seluruh informasi penting mengenai kondisi pasien agar dapat diterima dengan baik oleh perawat pada shift berikutnya. Informasi yang disampaikan dalam handover meliputi identitas pasien, diagnosis medis, kondisi terkini pasien, hasil pemeriksaan, terapi yang diberikan, respon pasien terhadap tindakan, serta rencana tindak lanjut pelayanan. Apabila proses handover dilakukan secara tidak efektif, maka dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi, kehilangan informasi penting pasien, kesalahan tindakan medis, keterlambatan pelayanan, hingga meningkatkan risiko kejadian tidak diharapkan di rumah sakit (WHO, 2021).

Organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa kegagalan komunikasi merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. World Health Organization menjelaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif selama handover menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya medication error, kesalahan identifikasi pasien, serta keterlambatan penanganan pasien kritis. Oleh karena itu, komunikasi saat handover menjadi salah satu fokus utama dalam program patient safety di berbagai negara (WHO, 2021).

Joint Commission International juga melaporkan bahwa lebih dari 60% kejadian sentinel di rumah sakit berkaitan dengan kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan, termasuk saat pelaksanaan handover pasien. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa kualitas handover memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien. Handover yang dilakukan secara tidak lengkap atau tidak terstruktur dapat menyebabkan perawat kehilangan informasi penting yang diperlukan dalam pengambilan keputusan klinis pasien (Joint Commission International, 2021).

Penelitian internasional menunjukkan bahwa kualitas handover yang baik dapat meningkatkan kontinuitas pelayanan, memperbaiki koordinasi antar tenaga kesehatan, serta menurunkan angka kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Sebaliknya, handover yang buruk dapat menyebabkan kesalahan klinis yang berdampak serius terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, berbagai negara terus mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas handover melalui pelatihan komunikasi efektif, penerapan metode SBAR, supervisi rutin, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan (Riesenberg et al., 2010).

Di Indonesia, pelaksanaan handover di rumah sakit masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas komunikasi antar perawat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa handover belum dilakukan secara optimal karena adanya faktor-faktor seperti rendahnya motivasi perawat, kurangnya supervisi kepala ruangan, ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fasilitas, tingginya beban kerja, serta kurang efektifnya komunikasi antar tenaga kesehatan (Kamil et al., 2020).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kualitas handover pasien dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor individu, organisasi, maupun lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut meliputi motivasi perawat, supervisi kepala ruangan, komunikasi efektif dan SBAR, standar operasional prosedur, pendidikan dan pengalaman kerja perawat, serta fasilitas dan lingkungan kerja. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas handover sangat penting sebagai dasar dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien di rumah sakit (Nursalam, 2020).

B. Konsep Handover Pasien

Handover merupakan proses komunikasi antar tenaga kesehatan yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelayanan pasien secara aman dan berkesinambungan. Dalam praktik keperawatan, handover dilakukan setiap pergantian shift untuk menyampaikan informasi terkait kondisi pasien, tindakan yang telah dilakukan, respon pasien terhadap terapi, dan rencana tindak lanjut pelayanan (Potter & Perry, 2021).

Handover memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas pelayanan pasien di rumah sakit. Tanpa handover yang baik, informasi penting mengenai kondisi pasien dapat terlewatkan sehingga meningkatkan risiko kesalahan tindakan medis. Oleh karena itu, handover menjadi salah satu indikator mutu pelayanan keperawatan dan bagian penting dalam implementasi patient safety di rumah sakit (Manser & Foster, 2011).

Dalam praktiknya, handover dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyampaian informasi, klarifikasi, dan verifikasi. Informasi yang disampaikan meliputi identitas pasien, diagnosis medis, kondisi terkini pasien, hasil pemeriksaan, tindakan yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut. Dokumentasi yang lengkap juga menjadi bagian penting dalam proses handover untuk memastikan keakuratan informasi pasien (Riesenberg et al., 2010).

C. Faktor faktor yang memengaruhi Kualitas Hand Over

1. Faktor Motivasi Perawat

Motivasi kerja merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan handover pasien di rumah sakit. Motivasi diartikan sebagai dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktik keperawatan, motivasi menjadi dasar bagi perawat untuk melaksanakan tugas secara profesional, termasuk dalam melakukan komunikasi saat handover pasien. Perawat yang memiliki motivasi tinggi akan lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi pasien secara lengkap, akurat, dan sistematis kepada perawat shift berikutnya sehingga kontinuitas pelayanan dapat terjaga dengan baik (Nursalam, 2020).

Handover yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif dari perawat dalam proses komunikasi. Motivasi yang tinggi akan meningkatkan kesadaran perawat terhadap pentingnya keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Sebaliknya, perawat yang memiliki motivasi rendah cenderung melakukan handover secara terburu-buru, kurang fokus, dan tidak lengkap sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya medication error, keterlambatan tindakan, maupun kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis pasien (Joint Commission International, 2021).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pelaksanaan handover perawat di ruang rawat inap. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Kurniawati (2022)

menemukan bahwa perawat dengan motivasi kerja tinggi lebih mampu melaksanakan handover sesuai standar dibandingkan perawat yang memiliki motivasi rendah. Perawat yang termotivasi cenderung lebih disiplin dalam menyampaikan kondisi pasien, hasil observasi, tindakan keperawatan, serta rencana tindak lanjut pasien pada shift berikutnya (Astuti & Kurniawati, 2022).

Selain itu, penelitian oleh Kamil, Rachmah, dan Wardani (2020) menyatakan bahwa motivasi intrinsik seperti rasa tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap keselamatan pasien berkontribusi besar dalam keberhasilan handover pasien. Perawat yang memiliki komitmen kerja tinggi akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi penting terkait kondisi pasien. Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis perawat memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas komunikasi klinis di rumah sakit (Kamil et al., 2020).

Dari perspektif internasional, penelitian yang dilakukan oleh Johnson, Jefferies, dan Nicholls (2015) di Australia menjelaskan bahwa motivasi perawat berhubungan dengan kualitas transfer informasi selama handover. Perawat yang memiliki kepuasan kerja dan motivasi tinggi cenderung lebih percaya diri dalam berkomunikasi, mampu bekerja sama dengan tim kesehatan, dan lebih fokus dalam proses timbang terima pasien. Sebaliknya, kelelahan kerja dan rendahnya motivasi menyebabkan penurunan kualitas komunikasi serta meningkatnya risiko kehilangan informasi penting pasien (Johnson et al., 2015).

Penelitian lain oleh Manser dan Foster (2011) juga menyebutkan bahwa motivasi tenaga kesehatan mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam handover klinis. Dalam pelayanan kesehatan modern, komunikasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan komitmen individu terhadap pekerjaannya. Perawat yang merasa dihargai oleh organisasi dan memiliki lingkungan kerja yang suportif akan menunjukkan motivasi kerja yang lebih baik sehingga proses handover dapat berlangsung lebih efektif dan aman bagi pasien (Manser & Foster, 2011).

Faktor motivasi perawat juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja di rumah sakit. Lingkungan kerja yang nyaman, hubungan interpersonal yang baik, dukungan kepala ruangan, penghargaan dari manajemen, serta beban kerja yang sesuai dapat meningkatkan semangat kerja perawat dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak kondusif, konflik antar staf, dan tingginya beban kerja dapat menurunkan motivasi perawat sehingga berdampak pada kualitas handover pasien (Marquis & Huston, 2020).

Kepemimpinan kepala ruangan memiliki pengaruh besar dalam membangun motivasi kerja perawat. Kepala ruangan yang mampu memberikan supervisi, dukungan, penghargaan, dan komunikasi yang baik akan meningkatkan

semangat kerja staf keperawatan. Penelitian oleh Stanley (2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan klinis yang efektif dapat meningkatkan motivasi kerja perawat dan menciptakan budaya komunikasi yang positif dalam pelaksanaan handover pasien. Dukungan pimpinan yang baik akan membuat perawat merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keselamatan pasien (Stanley, 2016).

Selain faktor organisasi, motivasi perawat juga dipengaruhi oleh faktor individu seperti usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan pengembangan karier. Perawat yang memiliki pengalaman kerja lebih lama umumnya lebih percaya diri dalam melaksanakan handover karena telah memiliki keterampilan komunikasi dan pemahaman klinis yang lebih baik. Namun demikian, motivasi tetap diperlukan agar pengalaman tersebut dapat diterapkan secara optimal dalam praktik pelayanan keperawatan sehari-hari (Potter & Perry, 2021).

Penerapan sistem penghargaan atau reward juga dapat meningkatkan motivasi perawat dalam melaksanakan handover yang berkualitas. Penghargaan tidak selalu berbentuk finansial, tetapi juga dapat berupa pengakuan profesional, kesempatan pelatihan, promosi jabatan, dan apresiasi dari pimpinan. Perawat yang merasa diapresiasi akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk dalam melakukan komunikasi handover secara lengkap dan tepat waktu (Nursalam, 2020).

Motivasi kerja yang baik akan mendorong perawat untuk mematuhi standar operasional prosedur (SOP) handover. Kepatuhan terhadap SOP sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi penting pasien telah disampaikan secara lengkap kepada perawat penerima. Penelitian oleh Putri dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa perawat dengan motivasi tinggi memiliki tingkat kepatuhan SOP handover yang lebih baik dibandingkan perawat dengan motivasi rendah. Hal ini membuktikan bahwa motivasi kerja berhubungan langsung dengan kualitas implementasi prosedur keselamatan pasien di rumah sakit (Putri & Handayani, 2022).

Dengan demikian, motivasi perawat merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Motivasi yang tinggi akan meningkatkan kualitas komunikasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta tanggung jawab profesional perawat dalam menjaga keselamatan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi kerja perawat melalui supervisi yang baik, lingkungan kerja yang kondusif, pelatihan berkelanjutan, serta sistem penghargaan yang mendukung profesionalisme tenaga keperawatan.

2. Faktor Supervisi Kepala Ruangan

Supervisi kepala ruangan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Supervisi adalah proses pembinaan, pengawasan, pengarahan, dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada staf untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam pelayanan keperawatan, kepala ruangan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan handover agar berlangsung efektif, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Marquis & Huston, 2020).

Handover yang berkualitas membutuhkan pengawasan yang konsisten agar informasi pasien dapat disampaikan secara lengkap dan akurat. Kepala ruangan berperan sebagai supervisor yang memastikan bahwa seluruh perawat melaksanakan timbang terima pasien sesuai standar operasional prosedur (SOP). Melalui supervisi yang baik, kepala ruangan dapat mengidentifikasi hambatan dalam proses handover, memberikan arahan, serta melakukan evaluasi terhadap kualitas komunikasi antar perawat (Nursalam, 2020).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa supervisi kepala ruangan memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas handover pasien. Penelitian oleh Fitriani dan Sari (2021) menemukan bahwa perawat yang mendapatkan supervisi rutin dari kepala ruangan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan handover sesuai standar dibandingkan dengan perawat yang jarang mendapatkan pengawasan. Supervisi yang dilakukan secara berkala membantu meningkatkan kedisiplinan perawat dalam menyampaikan informasi klinis pasien secara lengkap dan tepat waktu (Fitriani & Sari, 2021).

Selain itu, penelitian oleh Kamil, Rachmah, dan Wardani (2020) menjelaskan bahwa kepala ruangan memiliki peran penting dalam membangun budaya keselamatan pasien melalui supervisi komunikasi klinis. Kepala ruangan yang aktif melakukan monitoring handover mampu meningkatkan kesadaran perawat terhadap pentingnya komunikasi efektif dalam menjaga kontinuitas pelayanan pasien. Supervisi yang efektif juga dapat meminimalkan risiko kesalahan komunikasi selama proses pergantian shift (Kamil et al., 2020).

Dalam praktik keperawatan, supervisi kepala ruangan tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan kompetensi staf. Kepala ruangan bertugas memberikan umpan balik, koreksi, dan motivasi kepada perawat agar pelaksanaan handover berjalan lebih optimal. Dukungan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi perawat dalam menyampaikan informasi pasien (Simamora, 2018).

Penelitian internasional yang dilakukan oleh Stanley (2016) menjelaskan bahwa kepemimpinan klinis kepala ruangan sangat mempengaruhi kualitas komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Kepala ruangan yang memiliki kemampuan supervisi dan komunikasi yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan kepatuhan staf terhadap prosedur handover. Kepemimpinan yang efektif akan membentuk budaya kerja profesional yang mendukung keselamatan pasien (Stanley, 2016).

Penelitian lain oleh Manser dan Foster (2011) di Eropa menyatakan bahwa supervisi yang efektif dapat meningkatkan kualitas transfer informasi antar tenaga kesehatan. Kepala ruangan yang terlibat langsung dalam evaluasi handover mampu memastikan bahwa komunikasi berlangsung secara sistematis dan tidak ada informasi penting pasien yang terlewatkan. Supervisi juga membantu mengurangi kesalahan klinis akibat miskomunikasi saat pergantian shift (Manser & Foster, 2011).

Di Australia, Johnson, Jefferies, dan Nicholls (2015) menemukan bahwa keterlibatan kepala ruangan dalam handover dapat meningkatkan kualitas dokumentasi dan komunikasi klinis antar perawat. Kepala ruangan yang melakukan supervisi secara aktif akan mendorong staf untuk lebih disiplin dalam menggunakan format handover yang terstandar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Hal ini berdampak positif terhadap keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan di ruang rawat inap (Johnson et al., 2015).

Supervisi kepala ruangan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) handover. SOP diperlukan agar proses timbang terima pasien dilakukan secara sistematis dan seragam oleh seluruh perawat. Kepala ruangan bertugas memastikan bahwa setiap tahapan handover dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Penelitian oleh Putri dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa adanya supervisi rutin dari kepala ruangan berhubungan dengan meningkatnya kepatuhan perawat terhadap SOP handover di rumah sakit (Putri & Handayani, 2022).

Selain pengawasan langsung, kepala ruangan juga memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan kemampuan staf keperawatan. Kepala ruangan dapat memberikan pelatihan, simulasi, dan diskusi terkait teknik komunikasi efektif dalam handover. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi perawat dan meminimalkan kesalahan penyampaian informasi pasien. Pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kualitas handover dan keselamatan pasien (WHO, 2021).

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan supervisi adalah gaya kepemimpinan kepala ruangan. Kepala ruangan yang menerapkan gaya kepemimpinan suportif dan partisipatif cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan kualitas handover dibandingkan gaya kepemimpinan otoriter. Perawat akan merasa lebih nyaman untuk berdiskusi, bertanya, dan melaporkan kondisi pasien apabila mendapatkan dukungan dari pimpinan ruangan (Marquis & Huston, 2020).

Supervisi yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan handover, seperti ketidaklengkapan informasi pasien, rendahnya kepatuhan terhadap SOP, kurangnya komunikasi antar perawat, dan meningkatnya risiko insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, kepala ruangan perlu melakukan supervisi secara konsisten dan terencana agar kualitas handover tetap terjaga (Joint Commission International, 2021).

Disimpulkan supervisi kepala ruangan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Supervisi yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan terhadap SOP, kualitas komunikasi antar perawat, serta keselamatan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperkuat fungsi supervisi kepala ruangan melalui pelatihan kepemimpinan, monitoring rutin, evaluasi pelaksanaan handover, dan pengembangan budaya keselamatan pasien secara berkelanjutan.

3. Faktor Komunikasi Efektif dan SBAR

Komunikasi efektif merupakan komponen utama dalam pelaksanaan handover pasien di rumah sakit. Handover adalah proses transfer informasi, tanggung jawab, dan kewenangan pelayanan pasien dari satu tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan lainnya pada saat pergantian shift. Dalam proses tersebut, komunikasi yang jelas, tepat, lengkap, dan sistematis sangat diperlukan agar informasi penting mengenai kondisi pasien tidak hilang atau salah dipahami. Komunikasi yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab utama terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit (WHO, 2021).

Menurut Joint Commission International (2021), sebagian besar kejadian sentinel di rumah sakit disebabkan oleh kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan, terutama saat proses handover pasien. Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan pemberian terapi yang tidak tepat, keterlambatan tindakan medis, kesalahan identifikasi pasien, hingga meningkatnya angka kejadian tidak diharapkan. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menerapkan sistem komunikasi yang efektif dan terstandar untuk mendukung keselamatan pasien (Joint Commission International, 2021).

Komunikasi efektif dalam handover harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu akurat, lengkap, jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh penerima informasi. Perawat harus mampu menyampaikan kondisi pasien secara sistematis sehingga informasi penting tidak terlewatkan. Selain itu, komunikasi dua arah juga diperlukan agar penerima informasi dapat melakukan klarifikasi apabila terdapat hal yang belum dipahami. Proses ini penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan pasien selama 24 jam (Potter & Perry, 2021).

Salah satu metode komunikasi yang direkomendasikan secara internasional dalam handover adalah metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Metode SBAR pertama kali dikembangkan oleh dunia militer Amerika Serikat dan kemudian diadaptasi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi klinis antar tenaga kesehatan. SBAR membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi pasien secara sistematis dan terstruktur sehingga mengurangi risiko miskomunikasi (Haig et al., 2006).

Komponen pertama dalam metode SBAR adalah Situation, yaitu penyampaian kondisi terkini pasien secara singkat dan jelas. Pada tahap ini, perawat menjelaskan identitas pasien, kondisi utama pasien, serta masalah yang sedang terjadi. Tahap kedua adalah Background, yaitu informasi latar belakang pasien seperti diagnosis medis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan terapi yang sedang diberikan. Tahap ketiga adalah Assessment, yaitu hasil pengkajian atau penilaian klinis terhadap kondisi pasien saat ini. Sedangkan tahap terakhir adalah Recommendation, yaitu rekomendasi atau tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan berikutnya (Simamora, 2018).

Penggunaan metode SBAR terbukti mampu meningkatkan kualitas handover pasien. Penelitian oleh Haig, Sutton, dan Whittington (2006) menunjukkan bahwa implementasi SBAR dapat memperbaiki komunikasi antar tenaga kesehatan, meningkatkan ketepatan penyampaian informasi, serta menurunkan angka kesalahan komunikasi klinis di rumah sakit. Metode SBAR membantu tenaga kesehatan lebih fokus pada informasi penting sehingga proses handover menjadi lebih efektif dan efisien (Haig et al., 2006).

Di Indonesia, penelitian oleh Mardiana dan Sulastri (2023) menunjukkan bahwa penerapan komunikasi SBAR dalam handover meningkatkan kepatuhan perawat terhadap standar komunikasi efektif dan meningkatkan keselamatan pasien. Perawat yang menggunakan metode SBAR lebih mudah menyampaikan kondisi pasien secara runtut dan sistematis dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Hal ini berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan keperawatan di ruang rawat inap (Mardiana & Sulastri, 2023).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Simamora (2018) menjelaskan bahwa penerapan komunikasi efektif berbasis SBAR mampu meningkatkan kemampuan perawat dalam melakukan timbang terima pasien. Metode SBAR membantu perawat mengurangi kesalahan informasi dan meningkatkan koordinasi antar shift kerja. Selain itu, penggunaan format komunikasi yang terstandar mempermudah proses dokumentasi dan evaluasi pelayanan pasien (Simamora, 2018).

Dari perspektif internasional, penelitian Johnson, Jefferies, dan Nicholls (2015) di Australia menemukan bahwa komunikasi efektif selama handover berhubungan langsung dengan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan rumah sakit. Perawat yang menggunakan komunikasi terstruktur seperti SBAR cenderung lebih mampu menyampaikan informasi penting pasien secara lengkap dan akurat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak terstruktur menyebabkan meningkatnya risiko kehilangan informasi klinis penting (Johnson et al., 2015).

Penelitian oleh Manser dan Foster (2011) juga menyebutkan bahwa komunikasi efektif menjadi inti dalam menjaga kontinuitas pelayanan pasien di rumah sakit. Handover yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur mampu meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan serta menurunkan risiko kesalahan medis. Dalam pelayanan kesehatan modern yang kompleks, komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari budaya patient safety (Manser & Foster, 2011).

Selain meningkatkan keselamatan pasien, komunikasi efektif berbasis SBAR juga berdampak pada peningkatan kerja sama tim kesehatan. Metode SBAR mempermudah komunikasi antar profesi seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya karena menggunakan format yang sama dan mudah dipahami. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi pelayanan serta mempercepat pengambilan keputusan klinis terhadap pasien (WHO, 2021).

Faktor keberhasilan implementasi komunikasi efektif dan SBAR dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengetahuan perawat, pelatihan, supervisi kepala ruangan, lingkungan kerja, dan dukungan rumah sakit. Perawat yang mendapatkan pelatihan komunikasi SBAR cenderung lebih percaya diri dan lebih terampil dalam melakukan handover pasien. Sebaliknya, kurangnya pelatihan dan supervisi dapat menyebabkan komunikasi SBAR tidak berjalan optimal (Nursalam, 2020).

Kepala ruangan memiliki peran penting dalam memastikan penerapan komunikasi efektif dan SBAR di ruang rawat inap. Supervisi yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kepatuhan perawat terhadap penggunaan metode SBAR selama handover. Kepala ruangan juga bertanggung jawab memberikan

evaluasi dan umpan balik terhadap kualitas komunikasi staf keperawatan (Fitriani & Sari, 2021).

Lingkungan kerja juga mempengaruhi efektivitas komunikasi saat handover. Gangguan seperti kebisingan, interupsi, keterbatasan waktu, dan tingginya beban kerja dapat menghambat proses komunikasi antar perawat. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menyediakan lingkungan yang kondusif agar handover dapat dilakukan dengan fokus dan optimal (Marquis & Huston, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif dan metode SBAR merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Penerapan komunikasi yang sistematis, jelas, dan terstandar mampu meningkatkan keselamatan pasien, memperbaiki koordinasi antar tenaga kesehatan, serta mengurangi risiko kesalahan komunikasi klinis. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mendukung implementasi komunikasi efektif melalui pelatihan SBAR, supervisi rutin, penyediaan SOP, dan penguatan budaya patient safety secara berkelanjutan.

4. Faktor Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah kerja yang harus dilakukan secara sistematis dan terstandar dalam suatu kegiatan pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan, SOP handover digunakan sebagai acuan bagi perawat dalam melaksanakan proses timbang terima pasien agar komunikasi berjalan efektif, lengkap, dan aman. Keberadaan SOP sangat penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan pasien serta meminimalkan risiko kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan (Nursalam, 2020).

Handover pasien merupakan salah satu proses komunikasi klinis yang memiliki risiko tinggi apabila dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Ketidakteraturan dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan kehilangan data penting pasien, kesalahan pemberian terapi, keterlambatan tindakan medis, hingga terjadinya insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memiliki SOP handover yang jelas dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh tenaga keperawatan (WHO, 2021).

Menurut Joint Commission International (2021), komunikasi yang terstandar merupakan salah satu elemen penting dalam patient safety. SOP handover diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh informasi penting pasien disampaikan secara lengkap, sistematis, dan tepat waktu kepada tenaga kesehatan penerima. Standarisasi komunikasi melalui SOP juga membantu mengurangi variasi pelaksanaan handover antar perawat sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih konsisten (Joint Commission International, 2021).

SOP handover biasanya mencakup tahapan pelaksanaan timbang terima pasien, waktu pelaksanaan, format komunikasi, dokumentasi, dan tanggung jawab masing-masing petugas. Dalam banyak rumah sakit, SOP handover dikombinasikan dengan metode komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) agar proses penyampaian informasi pasien menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami (Simamora, 2018).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SOP handover berhubungan signifikan dengan kualitas pelaksanaan timbang terima pasien. Penelitian oleh Putri dan Handayani (2022) menemukan bahwa perawat yang mematuhi SOP handover cenderung lebih lengkap dalam menyampaikan informasi pasien dibandingkan perawat yang tidak mematuhi SOP. Kepatuhan tersebut berdampak pada meningkatnya keselamatan pasien dan berkurangnya risiko kesalahan komunikasi antar shift kerja (Putri & Handayani, 2022).

Penelitian lain oleh Kamil, Rachmah, dan Wardani (2020) menyebutkan bahwa SOP handover membantu meningkatkan kedisiplinan perawat dalam melakukan komunikasi klinis. Dengan adanya SOP yang jelas, perawat memiliki pedoman yang seragam mengenai informasi apa saja yang harus disampaikan selama handover. Hal ini membantu mengurangi kebiasaan penyampaian informasi secara tidak lengkap atau berdasarkan ingatan semata (Kamil et al., 2020).

Dari perspektif internasional, penelitian oleh Smeulers, Lucas, dan Vermeulen (2014) menunjukkan bahwa penggunaan handover yang terstandar melalui SOP dapat meningkatkan kontinuitas pelayanan pasien dan menurunkan risiko kehilangan informasi klinis penting. SOP membantu tenaga kesehatan lebih fokus terhadap data utama pasien sehingga proses handover menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa rumah sakit yang memiliki SOP handover yang baik cenderung memiliki kualitas pelayanan yang lebih tinggi (Smeulers et al., 2014).

Penelitian Johnson, Jefferies, dan Nicholls (2015) di Australia juga menemukan bahwa penerapan SOP handover meningkatkan kualitas dokumentasi dan komunikasi antar perawat. SOP membantu perawat memahami struktur komunikasi yang harus digunakan saat timbang terima pasien sehingga informasi menjadi lebih akurat dan mudah dipahami oleh penerima. Dengan demikian, SOP berkontribusi dalam menjaga keselamatan pasien selama proses pergantian shift (Johnson et al., 2015).

Selain sebagai pedoman kerja, SOP juga berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi pelayanan keperawatan. Kepala ruangan dapat menggunakan SOP sebagai dasar untuk melakukan supervisi dan penilaian terhadap kualitas

handover yang dilakukan oleh perawat. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui tingkat kepatuhan staf dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi handover di ruang rawat inap (Marquis & Huston, 2020).

Implementasi SOP handover yang efektif memerlukan dukungan dari manajemen rumah sakit. Rumah sakit perlu menyediakan kebijakan yang jelas, format dokumentasi standar, serta pelatihan kepada perawat mengenai pelaksanaan SOP handover. Pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perawat dalam menerapkan prosedur handover secara benar dan konsisten (Potter & Perry, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan SOP handover di rumah sakit. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap SOP antara lain tingginya beban kerja, keterbatasan waktu, kurangnya supervisi, dan rendahnya motivasi perawat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perawat melakukan handover secara singkat dan tidak sesuai prosedur sehingga kualitas komunikasi menjadi kurang optimal (Fitriani & Sari, 2021).

Lingkungan kerja juga mempengaruhi efektivitas implementasi SOP handover. Gangguan seperti kebisingan, interupsi dari tenaga kesehatan lain, dan kurangnya ruang khusus handover dapat menghambat proses komunikasi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar pelaksanaan SOP handover dapat berjalan secara maksimal (Manser & Foster, 2011).

Selain itu, kemajuan teknologi kesehatan juga mendukung implementasi SOP handover melalui penggunaan sistem dokumentasi elektronik. Dokumentasi elektronik membantu perawat mencatat informasi pasien secara lebih lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan lain. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi handover dan meminimalkan risiko kehilangan data pasien (WHO, 2021).

Kepatuhan terhadap SOP handover juga berkaitan erat dengan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah sakit yang memiliki budaya patient safety yang kuat biasanya lebih konsisten dalam menerapkan prosedur komunikasi klinis yang terstandar. Budaya tersebut mendorong seluruh tenaga kesehatan untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan fokus pada keselamatan pasien dalam setiap proses pelayanan (Joint Commission International, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. SOP membantu menciptakan komunikasi yang sistematis, lengkap, dan terstandar sehingga dapat meningkatkan keselamatan

pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memastikan bahwa SOP handover diterapkan secara konsisten melalui pelatihan, supervisi, evaluasi rutin, dan dukungan manajemen yang berkelanjutan.

5. Faktor Pendidikan dan Lama Kerja Perawat

Pendidikan dan lama kerja perawat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Handover merupakan proses komunikasi penting yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, serta pemahaman klinis yang baik agar informasi pasien dapat disampaikan secara lengkap dan akurat. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perawat berperan dalam membentuk kompetensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi efektivitas handover pasien (Potter & Perry, 2021).

Pendidikan perawat berkaitan dengan kemampuan intelektual, pengetahuan klinis, dan keterampilan profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan. Perawat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dalam mengidentifikasi kondisi pasien dan menentukan informasi penting yang harus disampaikan saat handover. Pendidikan juga membantu perawat memahami prinsip patient safety dan komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan (Nursalam, 2020).

Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, handover tidak hanya sekadar menyampaikan kondisi pasien, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis dalam menginterpretasikan data klinis pasien. Oleh karena itu, perawat dengan pendidikan yang baik cenderung lebih sistematis dan terstruktur dalam melakukan timbang terima pasien. Mereka lebih mampu menjelaskan kondisi pasien, respon terapi, hasil pemeriksaan, dan rencana tindak lanjut secara tepat kepada perawat penerima shift berikutnya (Johnson et al., 2015).

Penelitian di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan perawat dengan kualitas handover pasien. Penelitian oleh Kamil, Rachmah, dan Wardani (2020) menyatakan bahwa perawat dengan pendidikan profesi atau pendidikan tinggi memiliki kualitas komunikasi handover yang lebih baik dibandingkan dengan perawat yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan pemahaman terhadap standar komunikasi klinis dan keselamatan pasien (Kamil et al., 2020).

Penelitian lain oleh Putri dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa perawat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih patuh terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) handover dan penggunaan metode komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment,

Recommendation). Pendidikan yang memadai membantu perawat memahami pentingnya penyampaian informasi secara lengkap dan sistematis untuk mencegah terjadinya kesalahan pelayanan pasien (Putri & Handayani, 2022).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjamin kualitas handover yang baik apabila tidak didukung oleh pelatihan dan pengalaman praktik klinik yang memadai. Perawat tetap memerlukan pelatihan komunikasi efektif, supervisi, dan pembinaan secara berkelanjutan agar kemampuan handover dapat berkembang secara optimal (Simamora, 2018).

Selain pendidikan, lama kerja atau pengalaman kerja perawat juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas handover pasien. Lama kerja berkaitan dengan pengalaman klinis yang dimiliki perawat selama menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Perawat yang memiliki pengalaman kerja lebih lama biasanya lebih memahami kondisi klinis pasien, alur pelayanan rumah sakit, dan teknik komunikasi yang efektif dalam proses timbang terima pasien (Marquis & Huston, 2020).

Pengalaman kerja membantu perawat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan klinis dan keterampilan interpersonal saat melakukan handover. Perawat yang telah lama bekerja umumnya lebih percaya diri dalam menyampaikan informasi pasien, lebih mampu mengidentifikasi prioritas masalah pasien, serta lebih cepat dalam memahami kondisi klinis yang memerlukan perhatian khusus (Potter & Perry, 2021).

Penelitian oleh Astuti dan Kurniawati (2022) menunjukkan bahwa perawat dengan masa kerja lebih lama memiliki kualitas handover yang lebih baik dibandingkan perawat baru. Perawat senior lebih terampil dalam menyampaikan informasi pasien secara sistematis dan mampu melakukan klarifikasi terhadap kondisi pasien apabila terdapat informasi yang kurang jelas. Pengalaman kerja juga meningkatkan kemampuan perawat dalam menghadapi situasi klinis yang kompleks saat handover berlangsung (Astuti & Kurniawati, 2022).

Dari perspektif internasional, penelitian Johnson, Jefferies, dan Nicholls (2015) di Australia menemukan bahwa pengalaman kerja perawat berhubungan dengan efektivitas komunikasi klinis selama handover. Perawat yang lebih berpengalaman memiliki kemampuan lebih baik dalam mengorganisasi informasi pasien dan menentukan informasi prioritas yang perlu disampaikan kepada perawat penerima. Sebaliknya, perawat dengan pengalaman kerja yang masih terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan informasi penting selama handover (Johnson et al., 2015).

Penelitian oleh Manser dan Foster (2011) juga menjelaskan bahwa pengalaman kerja berperan penting dalam meningkatkan kemampuan komunikasi antar tenaga kesehatan. Perawat yang memiliki pengalaman klinis yang cukup cenderung lebih tenang, fokus, dan efektif dalam melakukan handover sehingga risiko miskomunikasi dapat diminimalkan. Pengalaman membantu perawat memahami pola komunikasi yang efektif dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang kompleks (Manser & Foster, 2011).

Meskipun demikian, lama kerja yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas handover yang baik apabila tidak didukung oleh motivasi dan kepatuhan terhadap prosedur. Beberapa perawat yang telah lama bekerja terkadang melakukan handover secara singkat dan kurang sistematis karena merasa terlalu terbiasa dengan rutinitas kerja. Oleh karena itu, supervisi dan evaluasi tetap diperlukan agar seluruh perawat, baik senior maupun junior, tetap melaksanakan handover sesuai standar yang berlaku (Fitriani & Sari, 2021).

Selain itu, kombinasi antara pendidikan yang baik dan pengalaman kerja yang cukup akan menghasilkan kompetensi perawat yang lebih optimal dalam pelaksanaan handover. Perawat dengan pendidikan tinggi dan pengalaman klinis yang memadai cenderung memiliki kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan perawat yang hanya memiliki salah satu faktor tersebut. Kompetensi ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien dan kontinuitas pelayanan keperawatan (Nursalam, 2020).

Rumah sakit perlu mendukung peningkatan kompetensi perawat melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan komunikasi efektif, dan pengembangan profesional. Pelatihan mengenai handover, patient safety, dan metode SBAR perlu dilakukan secara rutin agar kemampuan perawat terus berkembang sesuai tuntutan pelayanan kesehatan modern. Program orientasi bagi perawat baru juga penting untuk membantu mereka memahami prosedur handover yang benar sejak awal bekerja (WHO, 2021).

Kepala ruangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas handover melalui pembinaan terhadap perawat junior maupun senior. Supervisi yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengevaluasi kemampuan komunikasi perawat dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan handover. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, kualitas handover di ruang rawat inap dapat terus ditingkatkan (Stanley, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan lama kerja perawat merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas handover pasien di rumah sakit. Pendidikan yang baik meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis perawat, sedangkan pengalaman kerja meningkatkan

keterampilan komunikasi dan pemahaman klinis dalam pelaksanaan handover. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi perawat melalui pendidikan, pelatihan, supervisi, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan agar kualitas handover dan keselamatan pasien dapat terjaga secara optimal.

6. Faktor Fasilitas dan Lingkungan Kerja

Fasilitas dan lingkungan kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Handover adalah proses komunikasi yang membutuhkan konsentrasi, ketelitian, dan suasana yang kondusif agar informasi pasien dapat disampaikan secara lengkap dan akurat. Kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menghambat proses komunikasi antar tenaga kesehatan sehingga meningkatkan risiko kesalahan informasi dan menurunkan keselamatan pasien (WHO, 2021).

Lingkungan kerja dalam pelayanan keperawatan mencakup kondisi fisik, psikologis, dan sosial di tempat kerja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas perawat. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif dapat membantu perawat lebih fokus dalam melakukan handover. Sebaliknya, lingkungan kerja yang bising, penuh interupsi, dan memiliki beban kerja tinggi dapat mengganggu konsentrasi perawat saat menyampaikan informasi pasien (Nursalam, 2020).

Salah satu faktor lingkungan yang sering mempengaruhi kualitas handover adalah kebisingan di ruang perawatan. Suara alarm alat medis, percakapan staf, aktivitas keluarga pasien, dan lalu lalang tenaga kesehatan dapat mengganggu proses komunikasi selama handover berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan perawat sulit berkonsentrasi sehingga informasi penting pasien berpotensi tidak tersampaikan secara lengkap (Manser & Foster, 2011).

Penelitian internasional oleh Johnson, Jefferies, dan Nicholls (2015) di Australia menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang tidak kondusif menjadi salah satu penyebab utama terjadinya miskomunikasi saat handover. Gangguan lingkungan seperti interupsi dan kebisingan dapat menyebabkan perawat lupa menyampaikan informasi penting terkait kondisi pasien. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa ruang khusus handover dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi antar perawat (Johnson et al., 2015).

Selain faktor kebisingan, keterbatasan fasilitas juga dapat mempengaruhi efektivitas handover pasien. Fasilitas yang dimaksud meliputi ruang handover, dokumentasi pasien, media komunikasi, format handover standar, dan sistem teknologi informasi rumah sakit. Rumah sakit yang memiliki fasilitas pendukung

yang memadai cenderung memiliki kualitas handover yang lebih baik dibandingkan rumah sakit dengan fasilitas terbatas (Potter & Perry, 2021).

Penelitian oleh Smeulers, Lucas, dan Vermeulen (2014) menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas dokumentasi yang terstandar dapat meningkatkan kualitas transfer informasi pasien selama handover. Dokumentasi yang lengkap dan mudah diakses membantu perawat menyampaikan kondisi pasien secara lebih sistematis dan akurat. Sebaliknya, dokumentasi yang tidak lengkap atau sulit dipahami dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi penting pasien (Smeulers et al., 2014).

Di Indonesia, penelitian oleh Kamil, Rachmah, dan Wardani (2020) menunjukkan bahwa fasilitas kerja yang tidak memadai menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan handover di ruang rawat inap. Perawat mengeluhkan keterbatasan format handover, kurangnya ruang khusus timbang terima pasien, serta tingginya aktivitas di ruang perawatan yang menyebabkan proses handover sering terganggu. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas komunikasi antar perawat dan keselamatan pasien (Kamil et al., 2020).

Fasilitas teknologi informasi juga memiliki peranan penting dalam mendukung kualitas handover pasien. Penggunaan rekam medis elektronik dapat membantu perawat mengakses data pasien secara cepat dan akurat sehingga mempermudah proses timbang terima pasien. Sistem dokumentasi elektronik juga membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan kehilangan data pasien selama pergantian shift (WHO, 2021).

Penelitian internasional oleh Riesenber, Leitzsch, dan Cunningham (2010) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi elektronik dalam handover dapat meningkatkan efisiensi komunikasi klinis dan mengurangi kesalahan informasi. Sistem elektronik memungkinkan tenaga kesehatan memperoleh data pasien secara real time sehingga informasi yang disampaikan lebih lengkap dan akurat dibandingkan dokumentasi manual (Riesenber et al., 2010).

Selain fasilitas fisik, beban kerja perawat juga merupakan bagian dari lingkungan kerja yang mempengaruhi kualitas handover. Beban kerja yang tinggi menyebabkan perawat mengalami kelelahan fisik dan mental sehingga konsentrasi saat handover menjadi menurun. Perawat yang kelelahan cenderung melakukan handover secara singkat dan kurang detail karena terburu-buru menyelesaikan tugasnya (Marquis & Huston, 2020).

Penelitian oleh Astuti dan Kurniawati (2022) menunjukkan bahwa tingginya beban kerja perawat berhubungan dengan menurunnya kualitas handover pasien di ruang rawat inap. Perawat yang menangani terlalu banyak pasien mengalami kesulitan dalam menyampaikan seluruh informasi pasien secara lengkap. Hal ini

meningkatkan risiko terjadinya miskomunikasi dan kesalahan tindakan medis (Astuti & Kurniawati, 2022).

Lingkungan kerja psikologis juga berpengaruh terhadap kualitas handover. Hubungan interpersonal yang baik antar staf keperawatan dapat menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan efektif selama timbangan terima pasien. Sebaliknya, konflik antar staf atau kurangnya kerja sama tim dapat menghambat proses komunikasi dan menyebabkan informasi pasien tidak tersampaikan dengan optimal (Stanley, 2016).

Kepala ruangan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan handover. Kepala ruangan bertanggung jawab mengatur jadwal kerja, menyediakan fasilitas yang memadai, serta memastikan bahwa proses handover berlangsung tanpa gangguan. Supervisi yang baik dari kepala ruangan dapat membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan disiplin perawat dalam melakukan handover sesuai prosedur (Fitriani & Sari, 2021).

Selain itu, rumah sakit perlu menyediakan ruang khusus handover yang nyaman dan bebas gangguan agar proses komunikasi dapat berlangsung lebih efektif. Ruang tersebut sebaiknya memiliki pencahayaan yang baik, ventilasi yang memadai, serta fasilitas dokumentasi yang lengkap. Penyediaan ruang handover khusus dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi perawat selama timbangan terima pasien (Manser & Foster, 2011).

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) handover juga perlu didukung oleh fasilitas yang memadai. SOP yang baik tidak akan berjalan optimal apabila rumah sakit tidak menyediakan sarana pendukung yang sesuai. Oleh karena itu, fasilitas dan lingkungan kerja harus menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit (Joint Commission International, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan lingkungan kerja memiliki pengaruh besar terhadap kualitas handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif serta fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antar perawat dan mendukung keselamatan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperhatikan penyediaan fasilitas pendukung, pengelolaan lingkungan kerja, pengaturan beban kerja, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas handover secara berkelanjutan.

D. Dampak Kualitas Handover terhadap Keselamatan Pasien

Handover pasien merupakan salah satu proses penting dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Handover adalah proses transfer informasi, tanggung jawab, dan kewenangan pelayanan pasien dari satu tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan lainnya pada saat pergantian shift maupun perpindahan unit pelayanan. Proses ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas pelayanan dan memastikan bahwa seluruh informasi penting pasien tersampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Kualitas handover yang baik menjadi salah satu indikator utama dalam penerapan patient safety di rumah sakit (WHO, 2021).

Keselamatan pasien atau patient safety merupakan suatu sistem yang bertujuan mencegah terjadinya cedera atau kerugian pada pasien akibat kesalahan pelayanan kesehatan. Dalam praktik pelayanan rumah sakit, komunikasi yang efektif saat handover menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pasien karena sebagian besar tindakan klinis dilakukan berdasarkan informasi yang diterima selama proses timbang terima pasien. Kesalahan komunikasi saat handover dapat menyebabkan terjadinya medication error, kesalahan tindakan medis, keterlambatan terapi, hingga peningkatan angka kejadian tidak diharapkan di rumah sakit (Joint Commission International, 2021).

Menurut World Health Organization (WHO), komunikasi yang buruk saat handover menjadi salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien di berbagai negara. WHO menjelaskan bahwa ketidaklengkapan informasi pasien selama handover dapat menyebabkan tenaga kesehatan kehilangan data penting terkait kondisi pasien, riwayat penyakit, terapi yang sedang dijalankan, maupun perubahan kondisi klinis pasien. Kondisi tersebut dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien apabila tidak segera ditangani dengan baik (WHO, 2021).

Penelitian internasional oleh Riesenbergs, Leitzsch, dan Cunningham (2010) menunjukkan bahwa handover yang tidak efektif meningkatkan risiko terjadinya kesalahan medis dan kegagalan pelayanan pasien. Kesalahan tersebut sering terjadi akibat informasi yang tidak lengkap, komunikasi yang tidak jelas, serta kurangnya dokumentasi saat pergantian shift perawat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas handover memiliki hubungan langsung dengan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit (Riesenbergs et al., 2010).

Di Amerika Serikat, Joint Commission International melaporkan bahwa lebih dari 60% kejadian sentinel di rumah sakit disebabkan oleh kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan, termasuk saat proses handover pasien. Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan kesalahan identifikasi pasien, pemberian obat yang

tidak sesuai, tindakan medis yang terlambat, serta ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, komunikasi efektif selama handover menjadi prioritas utama dalam program patient safety rumah sakit (Joint Commission International, 2021).

Kualitas handover yang baik dapat meningkatkan kontinuitas pelayanan pasien. Informasi pasien yang disampaikan secara lengkap dan sistematis membantu tenaga kesehatan penerima shift memahami kondisi pasien secara menyeluruh sehingga dapat melanjutkan pelayanan tanpa hambatan. Kontinuitas pelayanan sangat penting terutama bagi pasien dengan kondisi kritis atau pasien yang membutuhkan pengawasan intensif selama perawatan di rumah sakit (Potter & Perry, 2021).

Selain menjaga kontinuitas pelayanan, handover yang berkualitas juga dapat meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan klinis. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya dapat menentukan prioritas tindakan berdasarkan informasi yang diterima saat handover. Informasi mengenai perubahan kondisi pasien, hasil pemeriksaan, dan respon terhadap terapi menjadi dasar penting dalam menentukan tindakan selanjutnya. Apabila informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik, maka risiko kesalahan klinis akan meningkat (Johnson et al., 2015).

Penelitian oleh Manser dan Foster (2011) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif selama handover mampu mengurangi risiko adverse event atau kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Handover yang dilakukan secara sistematis membantu tenaga kesehatan lebih mudah memahami kondisi pasien dan mengantisipasi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Dengan demikian, kualitas handover berkontribusi besar dalam meningkatkan keselamatan pasien selama proses perawatan (Manser & Foster, 2011).

Di Indonesia, penelitian oleh Kamil, Rachmah, dan Wardani (2020) menunjukkan bahwa kualitas handover yang baik berhubungan dengan meningkatnya keselamatan pasien di ruang rawat inap rumah sakit. Perawat yang melaksanakan handover sesuai standar mampu mengurangi kesalahan komunikasi antar shift dan meningkatkan koordinasi pelayanan pasien. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa handover yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit karena pasien merasa mendapatkan pelayanan yang lebih terkoordinasi dan berkesinambungan (Kamil et al., 2020).

Selain itu, penelitian oleh Simamora (2018) menyatakan bahwa penerapan komunikasi efektif berbasis metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dapat meningkatkan keselamatan pasien selama proses handover. Metode SBAR membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi pasien secara sistematis dan terstruktur sehingga meminimalkan risiko kehilangan

informasi penting pasien. Penggunaan SBAR juga terbukti mampu meningkatkan kerja sama tim kesehatan dan mengurangi miskomunikasi antar tenaga kesehatan (Simamora, 2018).

Kualitas handover yang buruk dapat memberikan dampak negatif yang serius terhadap pasien maupun rumah sakit. Handover yang tidak lengkap dapat menyebabkan keterlambatan tindakan medis, pemberian terapi yang salah, pengulangan pemeriksaan yang tidak diperlukan, hingga perburukan kondisi pasien. Selain berdampak pada keselamatan pasien, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan biaya pelayanan kesehatan dan menurunkan mutu pelayanan rumah sakit (Marquis & Huston, 2020).

Kesalahan komunikasi saat handover juga dapat mempengaruhi hubungan kerja antar tenaga kesehatan. Informasi yang tidak jelas sering menimbulkan kesalahpahaman antar perawat maupun antar profesi kesehatan lainnya. Kondisi tersebut dapat menghambat kerja sama tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, komunikasi yang baik selama handover sangat penting untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dalam pelayanan kesehatan (Stanley, 2016).

Selain berdampak pada pasien, kualitas handover juga mempengaruhi citra dan akreditasi rumah sakit. Rumah sakit yang mampu menerapkan handover secara efektif cenderung memiliki mutu pelayanan yang lebih baik dan tingkat keselamatan pasien yang lebih tinggi. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian mutu rumah sakit oleh lembaga akreditasi nasional maupun internasional (Joint Commission International, 2021).

Untuk meningkatkan kualitas handover, rumah sakit perlu menerapkan berbagai strategi seperti penggunaan SOP handover, pelatihan komunikasi efektif, penerapan metode SBAR, supervisi kepala ruangan, serta penggunaan dokumentasi elektronik. Lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan manajemen rumah sakit juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan handover yang berkualitas (WHO, 2021).

Pelatihan komunikasi efektif perlu dilakukan secara rutin agar tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan informasi pasien. Selain itu, evaluasi dan monitoring pelaksanaan handover juga diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur telah dijalankan sesuai standar yang berlaku. Dengan adanya upaya tersebut, kualitas handover dapat terus ditingkatkan sehingga keselamatan pasien dapat terjaga secara optimal (Nursalam, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas handover memiliki dampak yang sangat besar terhadap keselamatan pasien di rumah sakit. Handover yang efektif mampu meningkatkan kontinuitas pelayanan, ketepatan pengambilan

keputusan klinis, koordinasi antar tenaga kesehatan, serta mencegah terjadinya kesalahan medis. Sebaliknya, handover yang buruk dapat meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien dan menurunkan mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, peningkatan kualitas handover harus menjadi prioritas dalam upaya pengembangan budaya patient safety di rumah sakit.

E. Simpulan

Kualitas handover pasien di ruang rawat inap rumah sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu, komunikasi, maupun organisasi pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut meliputi pengetahuan perawat, motivasi kerja, kemampuan komunikasi efektif, pengalaman kerja, supervisi kepala ruangan, kepemimpinan, lingkungan kerja, fasilitas rumah sakit, serta penerapan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).

Komunikasi efektif menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan handover karena proses transfer informasi yang jelas, lengkap, dan sistematis dapat menjaga kesinambungan pelayanan pasien serta meminimalkan risiko kesalahan medis maupun keperawatan. Selain itu, penerapan metode SBAR terbukti mampu meningkatkan kualitas handover dengan membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi pasien secara lebih terarah dan mudah dipahami.

Faktor organisasi seperti supervisi kepala ruangan, ketersediaan standar prosedur operasional (SPO), dukungan fasilitas, dan budaya keselamatan pasien juga memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan handover yang optimal. Lingkungan kerja yang kondusif dan beban kerja yang terkendali akan membantu tenaga kesehatan melakukan handover secara lebih fokus dan efektif.

Dengan demikian, peningkatan kualitas handover perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan komunikasi efektif, pelatihan metode SBAR, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta dukungan manajemen rumah sakit dalam menciptakan sistem pelayanan yang mendukung patient safety. Handover yang berkualitas akan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, memperkuat koordinasi antar tenaga kesehatan, dan menjaga keselamatan pasien di rumah sakit.

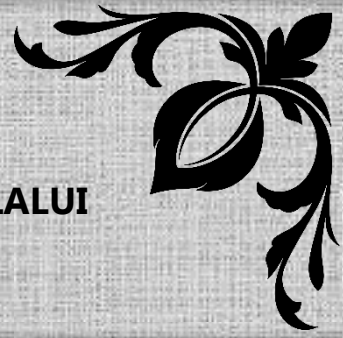
Referensi

- Astuti, R., & Kurniawati, D. (2022). Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Handover di Ruang Rawat Inap. *Nursing Sciences Journal*, 6(2), 115–123.
- Fitriani, N., & Sari, M. (2021). Pengaruh Supervisi Kepala Ruangan terhadap Kualitas Handover Perawat di Rumah Sakit. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(3), 145–153.
- Haig, K. M., Sutton, S., & Whittington, J. (2006). SBAR: A Shared Mental Model for Improving Communication Between Clinicians. *Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 32(3), 167–175.
- Joint Commission International. (2021). *International Patient Safety Goals*. Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals.
- Johnson, M., Jefferies, D., & Nicholls, D. (2015). Exploring the Structure and Organization of Information Within Nursing Clinical Handovers. *International Journal of Nursing Practice*, 21(2), 197–205.
- Kamil, H., Rachmah, R., & Wardani, E. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Handover di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(1), 45–53.
- Mardiana, Y., & Sulastri, T. (2023). Implementasi Metode SBAR dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ners Indonesia*, 13(1), 67–75.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2020). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application* (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Manser, T., & Foster, S. (2011). Effective Handover Communication: An Overview of Research and Improvement Efforts. *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, 25(2), 181–191.
- Nursalam. (2020). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing* (11th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Putri, A. N., & Handayani, S. (2022). Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan SOP dengan Kualitas Handover Perawat. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 18(2), 98–106.
- Riesenberg, L. A., Leitzsch, J., & Cunningham, J. M. (2010). Nursing Handoffs: A Systematic Review of the Literature. *American Journal of Nursing*, 110(4), 24–34.
- Simamora, R. H. (2018). *Keselamatan Pasien melalui Timbang Terima Pasien Berbasis Komunikasi Efektif: SBAR*. Jakarta: EGC.

- Smeulers, M., Lucas, C., & Vermeulen, H. (2014). Effectiveness of Different Nursing Handover Styles for Ensuring Continuity of Information in Hospitalised Patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6(6), 1–36.
- Stanley, D. (2016). Clinical Leadership Characteristics Confirmed. *Journal of Research in Nursing*, 21(1), 23–34.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Patient Safety: Communication During Patient Hand-Over*. Geneva: WHO Press.



CHAPTER 6



PERAN PERAWAT DALAM MENCEGAH KESALAHAN MELALUI HANDOVER

Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Handover merupakan salah satu proses paling penting dalam menjamin kesinambungan asuhan keperawatan karena di dalamnya terjadi perpindahan tanggung jawab, kewenangan, dan informasi klinis dari satu perawat kepada perawat berikutnya. Proses ini berlangsung di hampir seluruh area pelayanan kesehatan, terutama pada saat pergantian shift, transfer pasien antar unit, perawatan intensif, ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, dan kamar operasi. Pada tahap ini, kualitas komunikasi sangat menentukan apakah informasi penting mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, perubahan status klinis, serta potensi risiko dapat diteruskan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, atau justru mengalami kehilangan informasi yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. World Health Organization menegaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu strategi utama dalam mencegah insiden keselamatan pasien, termasuk kesalahan pengobatan, keterlambatan tindakan, dan kegagalan koordinasi antarprofesi (World Health Organization [WHO], 2021).

Menurut Eggins, Suzanne dan Slade, Diana (2015), clinical handover merupakan bentuk komunikasi profesional yang bertujuan memastikan transfer informasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas secara efektif untuk menjamin kontinuitas pelayanan dan meningkatkan keselamatan pasien. Mereka menekankan bahwa handover yang terstruktur dan berbasis komunikasi yang jelas dapat memperbaiki kualitas pengalaman pasien sekaligus mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

Kesalahan pada handover dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien, misalnya keterlambatan pemberian obat, salah interpretasi kondisi pasien, tidak terpantau perubahan status klinis, dan terjadinya duplikasi tindakan. World Health Organization menempatkan komunikasi saat handover sebagai salah satu isu prioritas dalam keselamatan pasien karena banyak insiden keselamatan pasien berakar dari miskomunikasi antar tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perawat

memegang peran sentral dalam memastikan bahwa handover berlangsung secara aman, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Martin Müller, Jonas Jürgens, Marcus Redaelli, Karsten Klingberg, Wolf E. Hautz, dan Stephanie Stock (2018) menyatakan bahwa penerapan alat komunikasi terstruktur seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) terbukti meningkatkan kualitas komunikasi dan berkontribusi terhadap penurunan risiko kesalahan serta peningkatan keselamatan pasien.

Dari perspektif *patient safety*, handover yang efektif merupakan bentuk pencegahan primer terhadap kesalahan pelayanan. World Health Organization menekankan pentingnya standar komunikasi yang jelas, alokasi waktu yang memadai, serta pelatihan berkelanjutan agar tenaga kesehatan mampu melaksanakan serah terima secara aman dan konsisten. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran perawat dalam mencegah kesalahan melalui handover sangat relevan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.

B. Konsep Hand Over dalam Keperawatan

Handover adalah proses transfer informasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas mengenai kondisi pasien dari satu tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan lainnya. Dalam praktik keperawatan, handover tidak hanya berarti menyampaikan laporan secara lisan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh informasi penting telah terdokumentasi dengan baik dan dipahami secara tepat oleh penerima. Dengan demikian, handover merupakan bagian integral dari komunikasi klinis yang memiliki dampak langsung terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Menurut Nadine Tacchini-Jacquier, Hélène Hertzog, Kilian Ambord, Peter Urben, Pierre Turini, dan Henk Verloo (2021), handover keperawatan yang berbasis bukti harus dilakukan secara terstandar untuk menjamin konsistensi, kelengkapan, dan akurasi informasi yang disampaikan. Standar ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan asuhan dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan pelayanan.

Tujuan utama handover adalah menjaga kesinambungan asuhan, mencegah kehilangan data penting, dan memastikan bahwa perawatan pasien tetap berlanjut secara aman. Informasi yang disampaikan seharusnya mencakup identitas pasien, diagnosis medis dan keperawatan, kondisi klinis terkini, terapi yang sedang dijalankan, hasil pemeriksaan penunjang, riwayat alergi, risiko jatuh, penggunaan alat invasif, serta rencana tindakan selanjutnya. Apabila salah satu unsur tersebut terlewat, risiko terjadinya kesalahan klinis dapat meningkat secara signifikan.

Penelitian Jung Hee Kim, Jung Lim Lee, dan Eun Man Kim (2021) menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien memiliki hubungan erat dengan kualitas handover. Semakin baik budaya keselamatan yang diterapkan di rumah sakit, semakin tinggi pula kualitas komunikasi antarperawat dalam proses serah terima.

Handover yang efektif harus bersifat ringkas, jelas, tepat waktu, dan terstruktur. Struktur komunikasi membantu perawat mengurutkan informasi berdasarkan prioritas pasien sehingga penerima lebih mudah memahami makna klinis dari setiap informasi yang diberikan. Sebaliknya, handover yang tidak terstruktur dapat menyebabkan informasi penting tenggelam di antara detail yang kurang relevan.

Studi oleh Mohd Hanif Mohd Nawawi dan Mohd Ismail Ibrahim (2024) menunjukkan bahwa persepsi perawat terhadap kualitas handover dipengaruhi oleh budaya keselamatan, dukungan organisasi, dan penggunaan format komunikasi yang konsisten.

World Health Organization dan Agency for Healthcare Research and Quality merekomendasikan agar handover mencakup kondisi pasien saat ini, perubahan signifikan, terapi yang sedang berlangsung, rencana tindakan, serta kemungkinan komplikasi. Informasi mengenai obat-obatan, hasil pemeriksaan, status alergi, arahan perawatan, dan kebutuhan pemantauan khusus juga harus disampaikan secara sistematis. Salah satu alat komunikasi yang banyak direkomendasikan adalah SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).

Di ruang rawat, informasi seperti risiko jatuh, penggunaan infus, drain, kateter, ventilator, serta luka yang memerlukan perawatan khusus harus menjadi perhatian utama. Informasi yang lengkap, relevan, dan tepat sasaran akan memudahkan perawat pada shift berikutnya dalam menentukan prioritas tindakan dan menjaga kesinambungan pelayanan.

Menurut Alyssa Wong (2023), bedside shift report atau handover di samping tempat tidur pasien terbukti meningkatkan keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan akurasi informasi karena pasien diberi kesempatan untuk mengonfirmasi data dan berpartisipasi dalam proses komunikasi.

C. Faktor Penghambat Handover Efektif

Banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaan handover yang aman dan efektif, di antaranya beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, gangguan lingkungan, serta dokumentasi yang tidak lengkap. Dalam situasi pelayanan yang sibuk, perawat sering kali terdorong untuk menyampaikan handover secara singkat tanpa menggunakan struktur komunikasi yang memadai. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terlewatnya informasi penting, seperti perubahan kondisi pasien, hasil

pemeriksaan kritis, atau rencana tindak lanjut yang harus segera dilakukan. Menurut Jung Hee Kim, Jung Lim Lee, dan Eun Man Kim (2021), beban kerja yang tinggi dan budaya keselamatan yang kurang mendukung berhubungan dengan rendahnya kualitas evaluasi handover di rumah sakit.

Faktor penghambat lainnya adalah tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta ketidakkonsistenan dalam penerapan format komunikasi. Apabila setiap perawat menggunakan gaya pelaporan yang berbeda, kualitas handover menjadi sulit diprediksi dan informasi penting dapat terabaikan. Selain itu, budaya organisasi yang hierarkis dapat menghambat perawat untuk mengajukan pertanyaan, memberikan klarifikasi, atau menyampaikan kekhawatiran terhadap informasi yang kurang lengkap. Mohd Hanif Mohd Nawawi dan Mohd Ismail Ibrahim (2024) melaporkan bahwa persepsi perawat terhadap kualitas handover sangat dipengaruhi oleh dukungan organisasi, budaya keselamatan, dan keterbukaan komunikasi antar anggota tim.

Keterbatasan teknologi informasi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, sistem dokumentasi masih dilakukan secara manual sehingga akses terhadap informasi pasien menjadi kurang cepat dan kurang efisien. Dokumentasi yang tidak terintegrasi meningkatkan risiko kehilangan data dan ketidaksesuaian informasi antara laporan lisan dan catatan tertulis. Oleh karena itu, pengembangan sistem handover digital dan dokumentasi elektronik semakin direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan standarisasi proses serah terima pasien. Nadine Tacchini-Jacquier dan kolega (2021) menekankan bahwa standarisasi berbasis bukti serta dukungan teknologi merupakan komponen penting dalam membangun sistem handover yang aman dan konsisten.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat handover efektif dapat berasal dari aspek individu, organisasi, maupun sistem. Upaya perbaikan harus dilakukan melalui penyusunan SOP yang jelas, pelatihan komunikasi terstruktur seperti SBAR, penciptaan budaya kerja yang terbuka, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kesinambungan asuhan keperawatan.

D. Faktor Pendukung Handover Berkualitas

Handover yang efektif didukung oleh berbagai faktor, antara lain adanya standar komunikasi yang jelas, pelatihan rutin, supervisi yang berkesinambungan, serta budaya kerja yang terbuka dan saling menghargai. Ketika perawat memahami format handover yang harus digunakan, proses komunikasi menjadi lebih konsisten, sistematis, dan mudah dipahami oleh penerima. Dukungan dari pimpinan

keperawatan, seperti kepala ruangan dan manajer keperawatan, juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi handover yang aman dan efektif.

Menurut Nadine Tacchini-Jacquier dan kolega (2021), pengembangan standar handover berbasis bukti merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi, memastikan kelengkapan informasi, dan mengurangi variasi praktik antar perawat. Standarisasi tersebut membantu menjamin bahwa seluruh informasi kritis pasien tersampaikan secara konsisten pada setiap pergantian shift.

Penggunaan checklist, template handover, serta dokumentasi elektronik juga terbukti membantu memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat. Teknologi informasi memungkinkan data pasien diakses secara cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga memperkuat kesesuaian antara laporan lisan dan dokumentasi tertulis. Selain itu, keterlibatan pasien dalam *bedside handover* memberikan nilai tambah karena meningkatkan akurasi informasi, transparansi, dan partisipasi pasien dalam proses perawatan.

Alyssa Wong (2023) melaporkan bahwa *bedside shift report* dapat meningkatkan keselamatan pasien, memperkuat komunikasi antara perawat dan pasien, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Dengan dukungan sistem yang baik, handover tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga alat strategis untuk mencegah kesalahan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

E. Peran Perawat dalam Mencegah Kesalahan Hand Over

1. Peran Perawat sebagai Pengirim Informasi

Perawat yang bertugas menyerahkan pasien memiliki tanggung jawab untuk memilih dan menyampaikan informasi yang paling penting bagi kelanjutan asuhan. Tugas ini menuntut kemampuan pengkajian yang baik, ketelitian terhadap perubahan kondisi pasien, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Pengirim informasi harus mampu membedakan data utama yang bersifat kritis dengan informasi tambahan yang tidak perlu mendominasi proses serah terima.

Menurut Alyssa Wong (2023), kualitas laporan yang diberikan pada saat handover sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien dan kepuasan pelayanan. Informasi yang disampaikan harus mencakup kondisi klinis terbaru, tindakan yang telah dilakukan, respons pasien, serta rencana tindak lanjut yang harus diteruskan oleh perawat berikutnya.

Dalam praktik, perawat pengirim bertanggung jawab menyampaikan perkembangan pasien secara objektif dan faktual, tanpa asumsi atau interpretasi yang ambigu. Misalnya, jika terjadi penurunan saturasi oksigen, peningkatan

nyeri, atau tanda-tanda infeksi, informasi tersebut harus dijelaskan secara jelas agar perawat penerima dapat segera melanjutkan pemantauan dan intervensi yang diperlukan. Jung Hee Kim, Jung Lim Lee, dan Eun Man Kim (2021) menegaskan bahwa kualitas handover yang baik berhubungan erat dengan budaya keselamatan pasien dan kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi yang efektif.

Perawat juga harus memastikan bahwa laporan tidak hanya menjelaskan apa yang telah dilakukan, tetapi juga apa yang masih harus dikerjakan. Rencana tindak lanjut merupakan komponen penting dalam handover karena menentukan prioritas kerja pada shift berikutnya. Dengan demikian, perawat pengirim berperan sebagai penjaga kesinambungan klinis sekaligus pelindung keselamatan pasien.

2. Peran Perawat sebagai Penerima Informasi

Perawat penerima handover tidak boleh hanya mendengarkan secara pasif, tetapi harus aktif mengonfirmasi dan mengklarifikasi setiap informasi yang disampaikan. Sikap proaktif ini sangat penting untuk mencegah salah tafsir, mengingat pesan verbal dapat terganggu oleh kebisingan, keterbatasan waktu, atau penggunaan istilah yang kurang jelas.

Agency for Healthcare Research and Quality merekomendasikan penggunaan teknik *read-back* dan *repeat-back*, yaitu mengulangi kembali informasi penting untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami secara tepat. Teknik ini terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan komunikasi, terutama pada situasi yang kompleks atau berisiko tinggi.

Perawat penerima yang baik akan mengajukan pertanyaan, memverifikasi data yang kurang jelas, dan memastikan bahwa instruksi yang diterima sesuai dengan kondisi pasien. Jika terdapat informasi yang janggal atau tidak lengkap, klarifikasi harus dilakukan segera sebelum tindakan keperawatan dilanjutkan.

Peran ini menjadi sangat penting pada pasien dengan kondisi kompleks, seperti pasien pascaoperasi, pasien di unit perawatan intensif, pasien dengan risiko sepsis, atau pasien yang menggunakan banyak obat. Pada kelompok pasien tersebut, kesalahan kecil dalam komunikasi dapat menimbulkan konsekuensi klinis yang serius. Oleh karena itu, perawat penerima juga memikul tanggung jawab etik dan profesional untuk memastikan bahwa tidak ada informasi kritis yang terlewat.

3. Peran Perawat sebagai Penjamin Keselamatan Pasien

Dalam kerangka *patient safety*, perawat merupakan lini terdepan sekaligus pengaman terakhir yang berperan mencegah kesalahan mencapai pasien. Pada saat handover, perawat harus mampu mengenali informasi yang berisiko tinggi,

seperti riwayat alergi obat, penggunaan obat *high alert*, hasil laboratorium kritis, perdarahan aktif, risiko jatuh, serta perubahan status neurologis. Apabila informasi-informasi tersebut tidak disampaikan secara lengkap dan akurat, peluang terjadinya *adverse event* akan meningkat secara signifikan. Menurut Suzanne Eggins dan Diana Slade (2015), komunikasi handover yang efektif merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah kesalahan klinis yang dapat membahayakan pasien.

World Health Organization menegaskan bahwa komunikasi efektif selama handover merupakan salah satu solusi keselamatan pasien yang paling penting. Banyak kejadian tidak diinginkan terjadi bukan karena kurangnya kompetensi klinis, melainkan karena informasi penting tidak berpindah secara aman antartugas (World Health Organization [WHO], 2021). Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko sejak dini dan mengantisipasi kemungkinan perburukan kondisi pasien pada shift berikutnya.

Peran sebagai penjamin keselamatan pasien juga mengharuskan perawat siap melakukan eskalasi apabila terdapat informasi yang memerlukan perhatian segera. Sebagai contoh, jika hasil laboratorium belum tersedia namun pasien menunjukkan tanda-tanda perburukan, perawat harus menyampaikan kondisi tersebut secara eksplisit dalam handover agar tindakan lanjutan dapat segera dilakukan. Alyssa Wong (2023) menegaskan bahwa handover yang terstruktur dan melibatkan pasien secara aktif dapat meningkatkan akurasi informasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mencegah keterlambatan intervensi yang berpotensi membahayakan pasien.

4. Peran Perawat sebagai Koordinator Asuhan

Perawat tidak hanya melaksanakan tindakan keperawatan, tetapi juga mengoordinasikan kesinambungan asuhan dari satu shift ke shift berikutnya. Dalam fungsi koordinatif ini, handover berperan sebagai jembatan antara tindakan yang telah dilakukan dengan tindakan yang harus dilanjutkan. Koordinasi yang efektif membantu meminimalkan pengulangan tindakan, konflik prioritas, serta ketidaksinkronan antaranggota tim kesehatan.

Menurut Nadine Tacchini-Jacquier dan kolega (2021), standar handover berbasis bukti dirancang untuk memastikan bahwa informasi penting disampaikan secara sistematis dan konsisten sehingga kontinuitas asuhan tetap terjaga. Handover yang terstruktur membantu seluruh tim memahami kondisi pasien, prioritas klinis, dan rencana perawatan secara menyeluruh.

Dalam situasi rawat inap, perawat harus memastikan bahwa rencana keperawatan berjalan sesuai target, termasuk kegiatan monitoring, edukasi pasien, kolaborasi dengan dokter, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tanpa

koordinasi yang baik, pasien dapat mengalami jeda pelayanan yang tidak perlu. Mohd Hanif Mohd Nawawi dan Mohd Ismail Ibrahim (2024) menunjukkan bahwa kualitas handover sangat dipengaruhi oleh budaya keselamatan, dukungan organisasi, dan keterbukaan komunikasi antarstaf.

Koordinasi menjadi semakin penting ketika pasien berpindah antar unit, misalnya dari instalasi gawat darurat ke ruang rawat inap atau dari ruang rawat ke unit perawatan intensif. Pada situasi ini, risiko kehilangan informasi sangat tinggi karena adanya perbedaan ritme kerja dan prioritas pelayanan. Agency for Healthcare Research and Quality merekomendasikan penggunaan format komunikasi terstruktur seperti SBAR untuk memastikan bahwa seluruh data penting tersampaikan secara lengkap dan dapat diverifikasi oleh tim penerima.

5. Peran Perawat sebagai Edukator dan Advokat

Perawat memiliki peran edukatif dalam proses handover, baik terhadap pasien maupun keluarga. Pendekatan *bedside handover* memberikan kesempatan kepada pasien untuk ikut memverifikasi informasi, mengajukan pertanyaan, dan memahami rencana perawatan yang akan dijalankan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat rasa aman, kepercayaan, dan partisipasi aktif pasien dalam proses perawatan. Alyssa Wong (2023) melaporkan bahwa *bedside shift report* terbukti meningkatkan keselamatan pasien, kualitas komunikasi, dan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan.

Sebagai edukator, perawat menjelaskan alasan dilakukannya tindakan, jadwal pemberian obat, tanda-tanda bahaya yang perlu segera dilaporkan, serta target perawatan berikutnya. Dengan demikian, pasien dan keluarga memahami kondisi yang sedang dihadapi dan dapat berpartisipasi dalam mendukung proses penyembuhan. Martin Müller dan kolega (2018) menunjukkan bahwa penggunaan alat komunikasi terstruktur seperti SBAR meningkatkan kualitas pertukaran informasi dan memperkuat keselamatan pasien melalui koordinasi yang lebih efektif.

Sebagai advokat, perawat berkewajiban membela kepentingan pasien ketika menemukan informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau berpotensi membahayakan. Advokasi merupakan bagian penting dari budaya keselamatan karena tidak semua kesalahan dapat langsung dikenali oleh seluruh anggota tim kesehatan. Jika perawat menemukan ketidaksesuaian, ia harus menyampaikan klarifikasi secara profesional, tegas, dan berdasarkan data yang objektif. Jung Hee Kim, Jung Lim Lee, dan Eun Man Kim (2021) menegaskan bahwa budaya keselamatan pasien yang kuat mendukung keberanian perawat untuk

berkomunikasi secara terbuka dan mencegah kesalahan sebelum mencapai pasien.

F. Strategi Hand Over yang Aman

Salah satu strategi paling penting dalam pelaksanaan handover adalah penggunaan komunikasi yang terstruktur. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi penting mengenai kondisi pasien dapat disampaikan secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh penerima. Dengan menerapkan metode komunikasi yang sistematis, risiko terjadinya miskomunikasi, kehilangan data, dan keterlambatan tindakan dapat diminimalkan secara signifikan.

1. SBAR sebagai Alat Utama

SBAR merupakan singkatan dari *Situation, Background, Assessment, Recommendation*. Metode ini dikembangkan untuk menyeragamkan komunikasi klinis agar informasi disampaikan secara ringkas, sistematis, dan fokus pada hal-hal yang paling penting. World Health Organization merekomendasikan penggunaan komunikasi terstruktur sebagai salah satu solusi keselamatan pasien, sedangkan Agency for Healthcare Research and Quality menempatkan SBAR sebagai alat praktis untuk komunikasi kritis yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera.

Menurut Shaneela Shahid dan Sumesh Thomas (2018), SBAR terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi, memperjelas prioritas klinis, dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses handoff maupun komunikasi antarprofesi. Oleh karena itu, SBAR sangat sesuai digunakan dalam handover antarshift maupun dalam komunikasi antara perawat dan dokter.

2. Read-Back dan Repeat-Back

Strategi lain yang sangat penting adalah penerapan teknik *read-back* dan *repeat-back*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengulangi kembali informasi penting yang telah disampaikan untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami dengan benar. Agency for Healthcare Research and Quality merekomendasikan langkah ini sebagai bagian dari komunikasi efektif untuk mengurangi salah dengar, salah tafsir, dan kelupaan, terutama pada situasi yang kompleks atau berisiko tinggi.

Dalam praktik handover, teknik ini memungkinkan penerima untuk mengonfirmasi data kritis seperti dosis obat, hasil laboratorium abnormal, perubahan kondisi pasien, dan rencana tindak lanjut. Pada situasi kegawatan, *read-back* berfungsi sebagai lapisan pengaman tambahan yang sangat efektif dalam mencegah kesalahan komunikasi.

3. Lingkungan yang Mendukung

Handover yang efektif membutuhkan lingkungan yang kondusif, minim gangguan, dan didukung dengan alokasi waktu yang memadai. Gangguan dari telepon, interupsi staf lain, keluarga pasien, maupun tingginya beban kerja dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi. Jung Hee Kim, Jung Lim Lee, dan Eun Man Kim (2021) menunjukkan bahwa kualitas handover berkaitan erat dengan budaya keselamatan pasien dan dukungan lingkungan kerja.

Oleh karena itu, institusi pelayanan kesehatan perlu menyediakan tempat dan waktu khusus untuk pelaksanaan handover. Budaya kerja yang menghargai fokus, keterbukaan, dan konsentrasi selama proses serah terima akan sangat membantu dalam menjaga mutu komunikasi dan mencegah kesalahan yang dapat membahayakan pasien.

4. Dokumentasi yang Jelas

Dokumentasi tertulis maupun elektronik merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung informasi lisan selama proses handover. Handover yang hanya mengandalkan ingatan perawat memiliki risiko tinggi terhadap kehilangan data, ketidakkonsistenan informasi, dan kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan secara verbal perlu didukung oleh dokumentasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses. Menurut Nadine Tacchini-Jacquier dan kolega (2021), standar handover berbasis bukti menekankan pentingnya integrasi antara komunikasi lisan dan dokumentasi tertulis untuk menjamin kontinuitas asuhan dan keselamatan pasien.

Dokumentasi yang baik harus memuat data penting secara ringkas dan sistematis, meliputi identitas pasien, diagnosis, kondisi klinis terkini, terapi yang sedang dijalankan, hasil pemeriksaan, risiko khusus, serta rencana tindak lanjut. Catatan ini berfungsi sebagai bukti kesinambungan asuhan dan sebagai acuan bagi perawat pada shift berikutnya. Saat ini, penggunaan sistem dokumentasi elektronik dan digital handover semakin luas diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan standardisasi proses serah terima pasien.

5. *Bedside Handover*

Bedside handover adalah proses serah terima yang dilakukan di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien secara langsung. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk memverifikasi informasi, mengajukan pertanyaan, serta memahami rencana perawatan yang akan dilakukan. Keterlibatan pasien dalam proses handover terbukti memperkuat *patient-centered care*, meningkatkan tanggung jawab profesional perawat, serta memperbaiki akurasi informasi yang disampaikan.

Menurut Alyssa Wong (2023), *bedside shift report* dapat meningkatkan keselamatan pasien, kepuasan pasien, serta kualitas komunikasi antarperawat. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan privasi, kenyamanan pasien, serta kesesuaian dengan kondisi klinis pasien. Jika diterapkan secara tepat, *bedside handover* menjadi strategi yang efektif dalam mencegah kesalahan dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan.

6. Keterlibatan Pasien

World Health Organization menganjurkan keterlibatan pasien dan keluarga dalam komunikasi handover apabila memungkinkan. Pasien dapat membantu mengonfirmasi identitas, riwayat alergi, keluhan utama, serta rencana perawatan, sehingga akurasi informasi meningkat. Selain itu, keterlibatan pasien memperkuat pendekatan pelayanan yang berpusat pada pasien (*care-centered rather than task-centered*).

Suzanne Eggins dan Diana Slade (2015) menekankan bahwa partisipasi pasien dalam handover meningkatkan transparansi, kualitas komunikasi, serta pengalaman pasien selama menerima pelayanan kesehatan.

7. Pelatihan dan Supervisi

Pelatihan komunikasi efektif sangat diperlukan agar perawat memiliki keterampilan handover yang konsisten dan berbasis standar. Supervisi, audit, serta pemberian umpan balik oleh kepala ruangan atau manajer keperawatan merupakan strategi penting untuk memperbaiki mutu handover secara berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang memadai, format komunikasi cenderung digunakan secara mekanis tanpa pemahaman yang mendalam mengenai tujuan keselamatan pasien.

Menurut Nurfairry Soed, Salizar Mohamed Ludin, Syed Nurulakla Syed Abdullah, dan Rasha Al-Zahrawi (2024), pelatihan komunikasi dan supervisi yang efektif meningkatkan kompetensi perawat dalam menyampaikan informasi klinis secara sistematis, percaya diri, dan aman.

G. Implikasi Praktik Keperawatan

1. Dampak terhadap Kesalahan Medis

Handover yang tidak efektif dapat menyebabkan berbagai kesalahan medis, seperti kesalahan pemberian obat, keterlambatan tindakan, hilangnya informasi klinis penting, dan kegagalan tindak lanjut terhadap kondisi pasien. Dalam situasi tertentu, kesalahan tersebut dapat berkembang menjadi kejadian sentinel yang berdampak serius terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, kualitas

handover memiliki hubungan langsung dengan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. World Health Organization menegaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu strategi paling penting untuk mencegah *avoidable harm* dalam pelayanan kesehatan (World Health Organization [WHO], 2021).

2. Dampak terhadap Mutu Pelayanan

Handover yang berkualitas meningkatkan kontinuitas asuhan, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan mempercepat proses pengambilan keputusan klinis. Dengan komunikasi yang jelas dan sistematis, tenaga kesehatan pada shift berikutnya dapat melanjutkan pelayanan tanpa kehilangan informasi penting. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan efisiensi pelayanan, menurunkan duplikasi tindakan, serta memperbaiki pengalaman pasien. Suzanne Eggins dan Diana Slade (2015) menyatakan bahwa handover yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengalaman pasien dan keamanan pelayanan.

3. Peran Manajerial Keperawatan

Kepala ruangan dan manajer keperawatan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan tersedianya standar operasional prosedur (SOP) handover yang jelas dan terimplementasi secara konsisten. Mereka juga perlu memantau kepatuhan staf, menyediakan pelatihan komunikasi efektif, melakukan audit, dan mengevaluasi hambatan yang muncul di lapangan. Kepemimpinan yang kuat akan membentuk budaya komunikasi yang aman, terbuka, dan saling menghargai. Nadine Tacchini-Jacquier dan kolega (2021) menegaskan bahwa standardisasi dan dukungan organisasi merupakan komponen kunci dalam keberhasilan implementasi handover berbasis bukti.

4. Implementasi di Berbagai Ruang

Penerapan handover dapat memiliki karakteristik yang berbeda antara ruang rawat inap, instalasi gawat darurat (IGD), unit perawatan intensif (ICU), dan ruang operasi. Meskipun demikian, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu komunikasi yang terstruktur, akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi. Semakin kompleks kondisi pasien, semakin tinggi kebutuhan akan handover yang disiplin dan rinci. Mohd Hanif Mohd Nawawi dan Mohd Ismail Ibrahim (2024) menunjukkan bahwa persepsi terhadap kualitas handover sangat dipengaruhi oleh budaya keselamatan dan dukungan organisasi di lingkungan kerja.

H. Kesimpulan

Handover merupakan komponen esensial dalam keselamatan pasien dan kesinambungan asuhan keperawatan. Proses ini tidak sekadar menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga mekanisme utama untuk memastikan bahwa

tanggung jawab, prioritas klinis, dan rencana perawatan diteruskan secara aman dari satu perawat kepada perawat lainnya. Dalam pelaksanaannya, perawat memegang peran sentral sebagai pengirim informasi, penerima informasi, penjamin keselamatan pasien, koordinator asuhan, edukator, dan advokat pasien.

Pencegahan kesalahan melalui handover dapat dicapai melalui penerapan komunikasi terstruktur seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), penggunaan dokumentasi yang akurat, penerapan teknik *read-back* dan *repeat-back*, penyediaan lingkungan yang kondusif, serta pelatihan dan supervisi yang berkelanjutan. Dengan dukungan budaya keselamatan pasien dan kepemimpinan keperawatan yang kuat, handover yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga melindungi pasien dari risiko cedera yang sebenarnya dapat dicegah.

Referensi

- Agency for Healthcare Research and Quality. (2019). *SBAR tool: Situation-Background-Assessment-Recommendation*. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. [AHRQ SBAR Tool](#)
- Eggins, S., & Slade, D. (2015). Communication in clinical handover: Improving the safety and quality of the patient experience. *Journal of Public Health Research*, 4(3), 666. <https://doi.org/10.4081/jphr.2015.666>
- Kim, J. H., Lee, J. L., & Kim, E. M. (2021). Patient safety culture and handoff evaluation of nurses in small and medium-sized hospitals. *Journal of Korean Academy of Nursing Administration*, 27(4), 308–317.
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: A systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022202>
- Nawawi, M. H. M., & Ibrahim, M. I. (2024). Nurses' perceptions of patient handoffs and predictors of patient handoff perceptions in tertiary care hospitals in Kelantan, Malaysia: A cross-sectional study. *BMJ Open*, 14, e082421.
- Shahid, S., & Thomas, S. (2018). Situation, Background, Assessment, Recommendation (SBAR) communication tool for handoff in health care: A narrative review. *Safety in Health*, 4(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s40886-018-0073-1>
- Soed, N., Ludin, S. M., Abdullah, S. N. S., & Al-Zahrawi, R. (2024). Effective communication and supervision in nursing handover: Strategies to enhance patient safety and continuity of care. *International Journal of Care Scholars*, 7(1), 1–10.
- Tacchini-Jacquier, N., Hertzog, H., Ambord, K., Urben, P., Turini, P., & Verloo, H. (2021). An evidence-based nursing handover standard for a multisite public hospital in Switzerland: Web-based modified Delphi study. *JMIR Nursing*, 4(2), e26123. <https://doi.org/10.2196/26123>
- Wong, A. (2023). *The effects of nursing bedside shift report on patient safety and satisfaction: A systematic review of the literature* (Master's project, San José State University). <https://doi.org/10.31979/etd.xyhe-8d5n>
- World Health Organization. (2007). *Communication during patient hand-overs*. In *Patient safety solutions* (Vol. 1, Solution 3). World Health Organization Collaborating Centre for Patient Safety. [WHO Patient Safety Solutions 2007](#)
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. Geneva: World Health Organization. [WHO Global Patient Safety Action Plan 2021–2030](#)

Glosarium

AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality, lembaga di Amerika Serikat yang mengembangkan berbagai panduan dan alat untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Adverse Event = Kejadian yang tidak diharapkan yang menyebabkan cedera atau dampak negatif pada pasien akibat proses pelayanan kesehatan.

Advokat Pasien = Peran perawat dalam membela hak, keselamatan, dan kepentingan pasien ketika terdapat potensi risiko atau kesalahan dalam pelayanan.

Akuntabilitas = Tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.

Assessment = Komponen ketiga dalam SBAR yang berisi hasil penilaian klinis terhadap kondisi pasien.

Audit Handover = Proses evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan handover untuk menilai kepatuhan, kualitas, dan efektivitas komunikasi.

Background = Komponen kedua dalam SBAR yang berisi riwayat atau informasi pendukung yang relevan dengan kondisi pasien saat ini.

Bedside Handover = Proses serah terima pasien yang dilakukan di samping tempat tidur pasien dengan melibatkan pasien dan/atau keluarga secara langsung.

Care-Centered = Pendekatan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan, keselamatan, dan pengalaman pasien.

Checklist Handover = Daftar poin penting yang digunakan untuk memastikan seluruh informasi kritis telah disampaikan selama handover.

Clinical Handover = Proses transfer informasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas terkait perawatan pasien dari satu tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan lainnya.

Continuity of Care = Kesenambungan pelayanan yang memastikan pasien menerima perawatan secara konsisten tanpa terputus.

Critical Information = Informasi klinis penting yang berpotensi memengaruhi keputusan dan keselamatan pasien.

Digital Handover = Sistem handover yang menggunakan teknologi informasi atau dokumentasi elektronik untuk mendukung pertukaran informasi pasien.

Dokumentasi Elektronik = Sistem pencatatan data pasien secara digital yang memudahkan akses, integrasi, dan standardisasi informasi.

Evidence-Based Practice = Praktik profesional yang didasarkan pada hasil penelitian terbaik, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien.

High Alert Medication = Obat-obatan yang memiliki risiko tinggi menyebabkan cedera serius apabila terjadi kesalahan penggunaan.

Handover = Proses serah terima informasi, tanggung jawab, dan rencana asuhan pasien dari satu perawat kepada perawat lainnya.

IGD = Instalasi Gawat Darurat, unit pelayanan rumah sakit untuk menangani pasien dengan kondisi akut atau emergensi.

ICU = Intensive Care Unit, unit perawatan intensif bagi pasien dengan kondisi kritis yang memerlukan pemantauan ketat.

Interprofessional Communication = Komunikasi antarprofesi kesehatan untuk memastikan koordinasi dan kesinambungan pelayanan.

Kejadian Sentinel = Insiden keselamatan pasien yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau dampak serius lainnya.

Koordinator Asuhan = Peran perawat dalam mengatur dan menyinergikan seluruh proses pelayanan pasien agar berjalan berkesinambungan.

Miskomunikasi = Kesalahan atau kegagalan dalam penyampaian informasi yang menyebabkan salah tafsir atau tindakan yang tidak tepat.

Monitoring = Kegiatan pemantauan kondisi pasien secara berkala untuk mendeteksi perubahan status klinis.

Patient Safety = Upaya sistematis untuk mencegah cedera yang dapat dihindari selama pelayanan kesehatan.

Patient Safety Culture = Nilai, sikap, dan perilaku organisasi yang mendukung keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Read-Back = Teknik komunikasi dengan mengulang kembali informasi yang diterima untuk memastikan kebenaran pesan.

Recommendation = Komponen keempat dalam SBAR yang berisi saran atau tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya.

Repeat-Back = Proses mengulangi informasi penting sebagai konfirmasi pemahaman bersama.

Risk Assessment = Proses identifikasi dan penilaian terhadap potensi risiko yang dapat membahayakan pasien.

SBAR = Situation, Background, Assessment, Recommendation; metode komunikasi terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan informasi klinis secara sistematis.

Sentinel Event = Istilah lain untuk kejadian sentinel, yaitu insiden serius yang menimbulkan dampak besar pada pasien.

Shift = Periode waktu kerja perawat, seperti shift pagi, sore, atau malam.

Situation = Komponen pertama dalam SBAR yang menjelaskan kondisi atau masalah utama pasien saat ini.

SOP = Standard Operating Procedure atau Standar Operasional Prosedur, yaitu pedoman tertulis untuk melaksanakan suatu proses kerja secara konsisten.

Supervisi = Kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Template Handover = Format baku yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun dan menyampaikan handover.

Transfer Pasien Antarunit = Pemindahan pasien dari satu unit pelayanan ke unit lain dengan disertai proses serah terima informasi yang lengkap.

WHO = World Health Organization, badan kesehatan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengembangkan kebijakan dan pedoman kesehatan global.



CHAPTER 7



EVALUASI EFEKTIVITAS *HANDOVER* TERHADAP KESELAMATAN PASIEN

Ns. Vera Sesrianty, M.Kep.

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien merupakan indikator utama mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Salah satu faktor penting dalam mendukung keselamatan pasien adalah komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, terutama pada saat *handover* atau timbang terima pasien. *Handover* merupakan proses penyampaian informasi penting mengenai kondisi pasien, tindakan yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut kepada tenaga kesehatan berikutnya agar kesinambungan pelayanan tetap terjaga.

Organisasi World Health Organization menyatakan bahwa komunikasi yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab utama terjadinya insiden keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Kesalahan komunikasi saat *handover* dapat menyebabkan medication error, keterlambatan tindakan, salah identifikasi pasien, hingga kejadian tidak diharapkan (KTD).

Dalam praktik keperawatan modern, metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) mulai banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas *handover*. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SBAR mampu meningkatkan kelengkapan informasi, efisiensi komunikasi, dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas *handover* menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan (Dewi Mulfiyanti & Andi Satriana, 2022).

B. Pengertian Handover

Handover atau serah terima pasien adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi klinis penting mengenai pasien kepada petugas berikutnya guna menjamin kesinambungan pelayanan. Menurut World Health Organization, *handover* merupakan transfer profesional terkait tanggung jawab dan akuntabilitas pelayanan pasien antar petugas kesehatan. Kegiatan *handover* merupakan salah satu metode penyampaian informasi terkait kondisi pasien yang relevan melalui proses timbang terima tugas dan wewenang

perawat yang dilakukan antar shift rutin maupun antar unit internal Rumah sakit(Priantoro, 2018)

Dalam praktik keperawatan, *handover* dilakukan setiap pergantian shift, perpindahan ruangan, maupun transfer pasien antar unit pelayanan. Informasi yang disampaikan meliputi identitas pasien, diagnosis, kondisi terkini, terapi, tindakan keperawatan, serta rencana tindak lanjut. Komunikasi informasi sering terjadi di dunia pelayanan kesehatan yang berbentuk kegiatan serah terima atau laporan dinas atau *handover*. Serah terima tugas keperawatan bertujuan untuk mengkoordinasikan perawatan, mendorong keberlanjutan perawatan, mentransfer akuntabilitas dan wewenang kepada tim keperawatan berikutnya, dan berbagi data (Bressan et al., 2020).

Kegiatan *handover* adalah kegiatan yang sudah turun temurun di dunia keperawatan, namun standar, efektifitas dan ketrampilan komunikasi *handover* tidak pernah diberikan secara formal di jenjang pendidikan keperawatan. Transfer informasi pada saat pergantian shift yang disebut dengan *handover* bertujuan untuk menyampaikan informasi dari setiap pergantian shift serta memastikan efektifitas dan keamanan dalam perawatan pasien. Informasi terkait dengan keadaan klinis pasien, kebutuhan pasien, keadaan personal pasien, sampai pada faktor sosial pasien. Perawat harus datang minimal 15 menit lebih awal untuk mengikuti *handover* sehingga proses *handover* dapat berjalan lancar.

Serah terima tugas keperawatan merupakan komponen penting dalam perawatan kesehatan, yang melibatkan transfer informasi pasien dan tanggung jawab antar perawat selama pergantian shift. Proses ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas dan memastikan kualitas perawatan pasien dengan memberikan informasi terbaru kepada perawat yang masuk mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, dan perkembangan penting dari shift sebelumnya. Bila dilakukan secara efektif, serah terima tugas keperawatan meningkatkan keselamatan pasien, mendukung pemberian perawatan berkualitas tinggi (Daicampi & Cesaro, 2025).

C. Hubungan *Handover* dengan Keselamatan Pasien

Handover sangat penting untuk keselamatan pasien karena proses ini adalah cara utama untuk mentransfer informasi klinis, tanggung jawab, dan menjaga kelanjutan pelayanan antara para tenaga kesehatan. Penyerahan informasi yang dilakukan dengan baik memungkinkan semua informasi penting tentang keadaan pasien, pengobatan, hasil pemeriksaan, dan rencana tindakan selanjutnya disampaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Sebaliknya, jika *handover*

tidak dilakukan dengan baik, bisa terjadi miskomunikasi, kesalahan dalam memberikan obat, tindakan yang tidak dilakukan, keterlambatan dalam penanganan, dan bahkan kejadian yang tidak diharapkan (KTD). Karena itu, komunikasi yang teratur saat *handover*, seperti menggunakan metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*), sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *handover* yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan, menurunkan insiden keselamatan pasien, dan membantu menjaga serta mendukung kesinambungan asuhan keperawatan.

Serah terima tugas keperawatan merupakan komponen penting dalam perawatan kesehatan, yang memastikan kesinambungan perawatan dan keselamatan pasien. Serah terima tugas di samping tempat tidur, yang dilakukan di samping tempat tidur pasien selama pergantian shift, telah diusulkan sebagai strategi untuk meningkatkan komunikasi antar profesional kesehatan, meningkatkan keterlibatan pasien, dan mengoptimalkan efisiensi rumah sakit. Namun, kekhawatiran tetap ada mengenai privasi, keterbatasan waktu, dan kualitas informasi yang dipertukarkan.

Komunikasi yang baik sangat penting dalam pelayanan kesehatan, terutama saat bekerja sama antara profesi seperti perawat dan bidan. Metode komunikasi SBAR (*Situation, Background, Assesment, dan Rekomendation*) adalah metode yang disarankan secara internasional dan telah terbukti efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien serta mengurangi kesalahan dalam komunikasi.

D. Efektifitas Handover Terhadap Keselamatan Pasien

Efektivitas proses serah terima dalam keselamatan pasien dapat dilihat dari seberapa baik proses ini menjamin komunikasi yang tepat, lengkap, jelas, dan terus-menerus antara para tenaga kesehatan. *Handover* yang baik membantu memastikan bahwa semua informasi penting tentang keadaan pasien, tindakan yang sudah dilakukan, terapi yang diberikan, dan rencana tindak lanjut dapat diterima dengan baik oleh petugas yang berikutnya. Dengan cara ini, risiko terjadinya kesalahan medis seperti kesalahan pengobatan, salah mengenali pasien, keterlambatan dalam tindakan, dan tindakan yang terlewat dapat dikurangi.

Penggunaan *handover* yang teratur, seperti metode SBAR (*Situation, Background, Assesment, Rekomendation*), terbukti dapat meningkatkan komunikasi dan mendukung keselamatan pasien. *Handover* yang baik juga membantu menjaga kelangsungan pelayanan, mempercepat keputusan klinis, meningkatkan kerja sama

antara tenaga kesehatan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Sebaliknya, *handover* yang tidak berjalan dengan baik bisa menyebabkan miskomunikasi yang berpotensi menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan (KTD) di rumah sakit.

Beberapa tanda keberhasilan *handover* yang berhubungan dengan keselamatan pasien meliputi penurunan angka insiden keselamatan pasien, berkurangnya kesalahan dalam pemberian obat, meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP) komunikasi, serta meningkatnya kualitas dokumentasi dan kerja sama tim kesehatan. Karena itu, menilai dan memperbaiki kualitas serah terima menjadi hal yang sangat penting dalam usaha meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien di tempat-tempat kesehatan.

E. Evaluasi Efektifitas Handover

Evaluasi efektifitas *handover* merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan serah terima pasien berdasarkan standar komunikasi, kepatuhan prosedur, kualitas informasi dan dampaknya terhadap keselamatan pasien.

Dimensi Evaluasi Efektifitas Handover

1. Ketepatan informasi

Informasi yang disampaikan saat pelaksanaan *handover* harus akurat, lengkap, aktual, relevan dan mudah dipahami. Informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan klinik. Contoh : seorang perawat menyampaikan bahwa pasien alergi salah satu antibiotik sehingga pasien menerima obat yang salah akibat informasi yang disampaikan kurang lengkap. Informasi yang tidak memadai atau tidak lengkap dalam proses serah terima tentu dapat menyebabkan kesalahan seperti lupa memberikan terapi, tindakan keperawatan yang tidak dilakukan sesuai rencana sehingga masalah pasien tidak dapat diselesaikan, kelalaian dan kesalahan dapat mengakibatkan kesinambungan perawatan pasien yang tidak berjalan sesuai prosedur. Hal ini tentu dapat menyebabkan insiden keselamatan pasien (Dewi Mulfiyanti & Andi Satriana, 2022).

2. Kejelasan komunikasi

Pada pelaksanaan *handover* sebaiknya komunikasi harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, jelas dan tidak ambigu. Metode komunikasi efektif yang digunakan dalam *handover* adalah SBAR, sangat membantu meningkatkan kejelasan komunikasi.

3. Ketepatan waktu

Kegiatan handover harus dilakukan tepat waktu saat pergantian shift, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu lama. Keterlambatan handover dapat menghambat pelayanan keperawatan kepada pasien.

4. Partisipasi aktif perawat

Pada pelaksanaan handover akan terjadi komunikasi dua arah, hal ini sangat penting dalam mencegah miskomunikasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan perawat dalam menerima handover harus mendengarkan dengan aktif, melakukan klarifikasi, mengajukan pertanyaan dan melakukan verifikasi informasi.

5. Kepatuhan terhadap SOP

Saat handover dilaksanakan, setiap tim yang terlibat harus melakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit. Indikator kepatuhan dalam pelaksanaan SOP handover meliputi kehadiran perawat, penggunaan format standar sesuai ketentuan rumah sakit, dokumentasi harus lengkap, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal. Segala fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung terlaksannnya handover sangat membantu tahapan keberhasilan seperti tersedianya SOP sehingga dengan kepatuhan terhadap SOP, maka handover menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesinambungan, kualitas, keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan kepada pasien (Istiningtyas, 2016).

F. Indikator Efektifitas Handover

Indikator efektivitas handover digunakan untuk menilai keberhasilan proses serah terima pasien dalam mendukung komunikasi efektif dan keselamatan pasien. Secara umum, indikator efektivitas handover dapat dibagi menjadi indikator proses, indikator outcome, dan indikator dokumentasi

1. Indikator proses

Indikator proses berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan handover dilakukan oleh tenaga kesehatan. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan waktu pelaksanaan handover, penggunaan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), kejelasan penyampaian informasi, keterlibatan dan partisipasi aktif perawat, serta ketepatan identifikasi dan kelengkapan informasi pasien yang disampaikan (Xuan et al., n.d.).

Handover yang berjalan sesuai prosedur menunjukkan bahwa proses komunikasi antar tenaga kesehatan berlangsung efektif dan mampu mendukung kesinambungan asuhan keperawatan. Namun efektivitas komunikasi SBAR tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, tetapi juga pada aspek psikologis individu, seperti *self efficacy* (keyakinan diri dalam melakukan tugas komunikasi

secara efektif) dan *self disclosure* (kemampuan membuka informasi relevan secara tepat dan profesional). Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian yang secara komprehensif mengeksplorasi kontribusi kedua variabel psikologis tersebut terhadap keberhasilan komunikasi SBAR antarprofesi di rumah sakit (Yun et al., 2023).

2. Indikator *outcome* berkaitan dengan hasil atau dampak dari pelaksanaan handover terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Handover yang efektif dapat dilihat dari menurunnya angka kejadian tidak diharapkan (KTD), berkurangnya *medication error*, menurunnya kesalahan identifikasi pasien, serta berkurangnya tindakan keperawatan yang terlewat (*missed care*). Selain itu, peningkatan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan juga menjadi indikator outcome yang menunjukkan bahwa komunikasi selama handover berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan yang aman.

3. Indikator Dokumentasi

Indikator dokumentasi menilai kelengkapan dan keakuratan pencatatan selama proses *handover*. Dokumentasi yang baik mencakup identitas pasien, kondisi terkini, tindakan yang telah dilakukan, terapi yang diberikan, serta rencana tindak lanjut pasien. Dokumentasi *handover* yang lengkap dan sesuai standar membantu mencegah kehilangan informasi penting, meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan, dan menjadi bukti pelaksanaan pelayanan keperawatan yang berkualitas.

Dengan adanya indikator proses, outcome, dan dokumentasi, evaluasi efektivitas handover dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga rumah sakit dapat mengetahui kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan sekaligus dampaknya terhadap keselamatan pasien. Timbang terima yang efektif akan berdampak terhadap asuhan keperawatan yang aman, komprehensif, dan berkesinambungan. Komunikasi efektif dalam pelaksanaan timbang terima dengan memperhatikan ketepatan

G. Metode Evaluasi handover

1. Observasi langsung

Dilakukan dengan mengamati pelaksanaan handover menggunakan ceklis, aspek yang diamati:

- a. Penggunaan SBAR
- b. Kelengkapan informasi
- c. Komunikasi verbal
- d. Dokumentasi

Keuntungan :

- a. Data objektif
- b. Menilai proses secara langsung

Kelemahan :

- a. Membutuhkan waktu
- b. Potensi bias observer

2. Audit Dokumentasi

Dilakukan dengan menilai kelengkapan catatan handover, kesinambungan dokumentasi dan kepatuhan terhadap format

3. Wawancara dan Kuisisioner

Digunakan dalam mengukur kepuasan perawat, hambatan handover dan persepsi efektivitas komunikasi.

4. Analisis incident report

Menganalisis hubungan antara kualitas handover dengan keselamatan pasien

H. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Handover

Efektivitas handover dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari individu maupun organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung ataupun menghambat proses komunikasi selama serah terima pasien. Apabila faktor-faktor ini tidak dikelola dengan baik, maka risiko terjadinya kesalahan komunikasi dan insiden keselamatan pasien akan meningkat.

1. Faktor Individu

a. Pengetahuan

Pengetahuan perawat mengenai prosedur handover, komunikasi efektif, dan keselamatan pasien sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan handover. Perawat yang memiliki pemahaman baik tentang metode komunikasi seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) akan lebih mampu menyampaikan informasi pasien secara lengkap, sistematis, dan akurat. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan sehingga meningkatkan risiko kesalahan tindakan.

b. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja mempengaruhi kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi klinis dan menentukan prioritas informasi yang harus disampaikan saat handover. Perawat yang lebih berpengalaman umumnya memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik, mampu mengidentifikasi kondisi pasien secara cepat, serta lebih percaya diri dalam menyampaikan

informasi kepada tim kesehatan lainnya. Namun, perawat dengan pengalaman kerja yang masih terbatas memerlukan pendampingan dan supervisi agar pelaksanaan handover tetap optimal.

c. Kemampuan komunikasi

Kemampuan komunikasi merupakan faktor penting dalam efektivitas handover. Komunikasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami membantu mencegah miskomunikasi antar tenaga kesehatan. Perawat harus mampu menyampaikan informasi secara singkat namun lengkap, serta mampu melakukan klarifikasi apabila terdapat informasi yang belum jelas. Kemampuan komunikasi yang kurang baik dapat menyebabkan kesalahan interpretasi informasi pasien dan berdampak pada keselamatan pasien.

d. Motivasi Kerja

Motivasi kerja mempengaruhi kesungguhan perawat dalam melaksanakan handover sesuai standar. Perawat yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan aktif dalam proses serah terima pasien. Sebaliknya, rendahnya motivasi kerja dapat menyebabkan handover dilakukan secara terburu-buru, tidak lengkap, dan kurang efektif (Sesrianty et al., 2023).

2. Faktor Organisasi

a. SOP rumah sakit

Motivasi kerja mempengaruhi kesungguhan perawat dalam melaksanakan handover sesuai standar. Perawat yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan aktif dalam proses serah terima pasien. Sebaliknya, rendahnya motivasi kerja dapat menyebabkan handover dilakukan secara terburu-buru, tidak lengkap, dan kurang efektif.

b. Supervisi kepala ruangan

Supervisi kepala ruangan berperan penting dalam memastikan handover berjalan sesuai prosedur. Kepala ruangan bertugas melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan handover. Supervisi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan perawat terhadap SOP, memperbaiki kualitas komunikasi, serta membantu mengidentifikasi kendala dalam proses handover. Dukungan dan arahan dari kepala ruangan juga dapat meningkatkan motivasi perawat dalam melaksanakan handover secara optimal (Rusmianingsih et al., 2024)

c. Keselamatan pasien

Budaya keselamatan pasien merupakan nilai dan perilaku yang mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang aman. Budaya keselamatan yang baik mendorong tenaga kesehatan untuk terbuka dalam komunikasi,

aktif melaporkan kesalahan, dan bekerja sama dalam menjaga keselamatan pasien. Dalam lingkungan kerja yang memiliki budaya keselamatan tinggi, proses handover biasanya dilakukan lebih teliti, sistematis, dan bertanggung jawab.

d. Beban kerja

Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi efektivitas handover karena perawat sering mengalami kelelahan fisik maupun mental. Jumlah pasien yang banyak, keterbatasan tenaga perawat, dan tingginya tuntutan pelayanan dapat menyebabkan handover dilakukan secara terburu-buru sehingga informasi penting tidak tersampaikan dengan lengkap. Beban kerja yang berlebihan juga dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kesalahan komunikasi.

3. Faktor Lingkungan

a. Kebisingan

Kebisingan merupakan salah satu hambatan utama dalam proses handover. Suara bising yang berasal dari alat medis, percakapan petugas, keluarga pasien, maupun aktivitas di sekitar ruangan dapat mengurangi konsentrasi perawat saat menyampaikan maupun menerima informasi pasien. Kondisi ini menyebabkan informasi penting berisiko tidak terdengar dengan jelas atau salah dipahami oleh penerima handover. Kebisingan yang tinggi juga dapat menurunkan kualitas komunikasi dan meningkatkan potensi terjadinya kesalahan tindakan yang berdampak pada keselamatan pasien.

b. Gangguan atau interupsi

Gangguan atau interupsi selama handover dapat berupa telepon masuk, pertanyaan dari keluarga pasien, panggilan dari tenaga kesehatan lain, maupun kondisi pasien yang mendadak memburuk. Interupsi yang terjadi secara berulang dapat memutus alur komunikasi dan menyebabkan informasi penting terlupakan atau tidak tersampaikan secara lengkap. Selain itu, interupsi juga dapat mengurangi fokus dan konsentrasi perawat sehingga meningkatkan risiko miskomunikasi antar tenaga kesehatan.

c. Kondisi ruangan

Kondisi ruangan tempat pelaksanaan handover juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Ruangan yang sempit, tidak nyaman, kurang pencahayaan, atau terlalu ramai dapat menghambat proses penyampaian informasi pasien. Sebaliknya, ruangan yang tenang, nyaman, dan memiliki privasi yang baik akan membantu tenaga kesehatan lebih fokus dalam melakukan handover. Kondisi ruangan yang mendukung juga membantu

menjaga kerahasiaan informasi pasien serta meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan.

I. Hambatan dalam Pelaksanaan Handover

Evaluasi efektivitas handover dilakukan untuk menilai apakah proses serah terima pasien telah berjalan secara optimal, lengkap, dan sesuai standar. Namun, apabila terdapat hambatan seperti beban kerja tinggi, waktu yang terbatas, kurangnya pelatihan komunikasi, tidak adanya standar baku, dokumentasi yang tidak lengkap, serta gangguan lingkungan kerja, maka efektivitas handover dapat menurun. Hambatan dalam pelaksanaan handover meliputi :

1. Beban kerja tinggi

Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan perawat mengalami kelelahan fisik dan mental sehingga proses handover dilakukan secara terburu-buru. Jumlah pasien yang banyak dan keterbatasan tenaga perawat juga dapat mengurangi fokus dalam menyampaikan informasi penting pasien, sehingga meningkatkan risiko miskomunikasi dan kesalahan pelayanan.

2. Waktu terbatas

Pelaksanaan handover sering dilakukan dalam waktu yang singkat, terutama saat pergantian shift yang padat. Keterbatasan waktu dapat menyebabkan informasi pasien tidak disampaikan secara lengkap dan detail. Akibatnya, beberapa kondisi penting pasien berpotensi terlewat dan dapat mempengaruhi keselamatan pasien.

3. Kurangnya pelatihan komunikasi

Sebagian tenaga kesehatan belum mendapatkan pelatihan komunikasi efektif seperti metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Kurangnya keterampilan komunikasi menyebabkan penyampaian informasi menjadi tidak sistematis, kurang jelas, dan sulit dipahami oleh penerima handover.

4. Tidak adanya standar baku

Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) atau format handover yang baku menyebabkan setiap perawat memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan informasi yang disampaikan dan meningkatkan risiko kehilangan data penting pasien selama proses handover.

5. Dokumentasi kurang lengkap

Dokumentasi handover yang tidak lengkap dapat menyebabkan informasi penting mengenai kondisi pasien, terapi, maupun tindakan yang telah dilakukan tidak tercatat dengan baik. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahan tindakan, keterlambatan pelayanan, dan ketidaksesuaian dalam perawatan pasien.

6. Gangguan lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang bising, ramai, dan sering terjadi interupsi dapat mengganggu konsentrasi tenaga kesehatan selama handover. Gangguan seperti suara alat medis, telepon, maupun pertanyaan dari pihak lain dapat menyebabkan informasi pasien tidak tersampaikan secara optimal dan meningkatkan risiko miskomunikasi.

Timbang terima yang efektif akan berdampak terhadap asuhan keperawatan yang aman, komprehensif, dan berkesinambungan. Komunikasi efektif dalam pelaksanaan timbang terima dengan memperhatikan ketepatan waktu, keakuratan dan kelengkapan informasi, serta dapat diterima oleh penerima informasi, sehingga dapat mengurangi kesalahan intervensi (Rusmianingsih et al., 2024).

J. Strategi Meningkatkan Efektivitas Handover

Efektivitas handover sangat berpengaruh terhadap kesinambungan pelayanan dan keselamatan pasien. Handover yang tidak efektif dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahan tindakan, hingga kejadian tidak diharapkan (KTD). Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan handover agar proses komunikasi antar tenaga kesehatan berjalan optimal, sistematis, dan aman bagi pasien. Peningkatan efektivitas handover sangat penting untuk mendukung komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Pelatihan SBAR

Pelatihan komunikasi efektif membantu meningkatkan kemampuan perawat dalam menyampaikan informasi klinis. Manajemen rumah sakit perlu mengadakan pelatihan simulasi komunikasi SBAR untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan (*self-disclosure*) tanpa rasa takut disalahkan (*blame-free culture*). Budaya ini dapat dibangun melalui penerapan sistem pelaporan insiden tanpa sanksi dan dukungan pimpinan terhadap komunikasi terbuka, serta pemberian umpan balik yang konstruktif. Lingkungan kerja yang aman secara psikologis (*psychological safety*) akan mendorong perawat dan bidan untuk lebih berani menyampaikan informasi klinis, terutama

pada komponen recommendation dalam komunikasi SBAR, sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien (Diel et al., 2026).

2. Standarisasi SOP

Penggunaan SOP baku membantu mengurangi variasi pelaksanaan handover. Standar Operasional Prosedur (SOP) handover merupakan pedoman tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan serah terima pasien. SOP yang terstandar membantu menciptakan keseragaman proses komunikasi antar tenaga kesehatan sehingga informasi pasien dapat disampaikan secara lengkap dan konsisten. Hasil penelitian (Hasibuan et al., 2022) menunjukkan 61,5% perawat telah melakukan/melaksanakan handover sesuai SOP dengan baik dalam beberapa proses, proses persiapan, pelaksanaan dan post handover.

3. Supervisi Kepala Ruangan

Pengawasan rutin membantu meningkatkan kepatuhan perawat. Supervisi kepala ruangan merupakan proses pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan handover oleh perawat pelaksana. Kepala ruangan memiliki peran penting dalam memastikan handover dilakukan sesuai SOP dan standar keselamatan pasien (Sesrianty & Harahap, 2021).

4. Penggunaan Checklist

Checklist membantu memastikan seluruh informasi penting tersampaikan. Checklist handover merupakan daftar poin penting yang digunakan untuk memastikan seluruh informasi pasien tersampaikan secara lengkap selama proses serah terima.

5. Pengembangan Budaya Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan pasien mendorong tenaga kesehatan lebih terbuka dalam komunikasi. Budaya keselamatan pasien merupakan nilai, sikap, perilaku, dan komitmen tenaga kesehatan dalam menciptakan pelayanan yang aman bagi pasien. Budaya keselamatan yang baik sangat mendukung efektivitas handover karena mendorong tenaga kesehatan untuk lebih terbuka, teliti, dan bertanggung jawab dalam komunikasi klien. Dampak budaya terhadap handover :

- a. Handover dilakukan lebih teliti dan bertanggung jawab
- b. Meningkatkan kualitas komunikasi
- c. Mengurangi risiko kejadian tidak diharapkan
- d. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit

Budaya keselamatan pasien yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung komunikasi efektif dan keselamatan pasien secara berkelanjutan

Strategi peningkatan efektivitas handover sangat penting untuk mendukung keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Pelatihan SBAR, standarisasi

SOP, supervisi kepala ruangan, penggunaan checklist, serta pengembangan budaya keselamatan pasien merupakan langkah yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan. Dengan penerapan strategi tersebut, proses handover dapat berjalan lebih sistematis, lengkap, dan aman sehingga risiko kesalahan pelayanan dapat diminimalkan dan keselamatan pasien dapat terjaga secara optimal.

K. Simpulan

Handover merupakan proses komunikasi penting dalam pelayanan keperawatan yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Handover yang efektif mampu menjamin kesinambungan pelayanan, mengurangi kesalahan medis, meningkatkan kualitas komunikasi, dan menurunkan insiden keselamatan pasien. Evaluasi efektivitas handover perlu dilakukan secara berkala melalui observasi, audit dokumentasi, kuesioner, dan analisis incident report. Penggunaan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR terbukti meningkatkan efektivitas handover dan keselamatan pasien. Upaya peningkatan efektivitas handover memerlukan dukungan manajemen, pelatihan berkelanjutan, supervisi, serta pengembangan budaya keselamatan pasien di rumah sakit.

Referensi

- Bressan, V., Mio, M., & Palese, A. (2020). Nursing handovers and patient safety: Findings from an umbrella review. *Journal of Advanced Nursing*, 76(4), 927–938.
- Daicampi, C., & Cesaro, E. (2025). Impact of Bedside Handover on Patient Perceptions and Hospital Organizational Outcomes: A Systematic Review. *Journal of Nursing Management*, 2025, 7–9.
- Dewi Mulfiyanti, & Andi Satriana. (2022). The Correlation between the use of the SBAR Effective Communication Method and the Handover Implementation of Nurses on Patient Safety. *International Journal of Public Health Excellence (IJPHE)*, 2(1 SE-Articles), 376–380. <https://doi.org/10.55299/ijphe.v2i1.275>
- Diel, M. M., Ayuningtyas, N., Khanaya, K., Amelia, N., Kesehatan, I., Madani, U. Y., Kesehatan, F. I., & Madani, U. Y. (2026). KOMUNIKASI SBAR : PERAN SELF EFFICACY DAN SELF DISCLOSURE PROFESI KESEHATAN RS SWASTA X DI TANGERANG. *Jurnal Keperawatan Malang*, 11(01), 41–60.
- Globocan. (2022). *Global Cancer Observatory: Indonesia*. <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/360-indonesia-fact-sheet.pdf>
- Hasibuan, L. F., Efendy, I., & Afriany, M. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Handover, Komunikasi Teraupetik dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2021. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(1), 48–62.
- Istiningtyas, A. (2016). HUBUNGAN SUMBERDAYA DENGAN PELAKSANAAN HANDOVER SEBAGAI SASARAN KESELAMATAN PASIEN. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*.
- Priantoro, H. (2018). Hubungan Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Dengan Kejadian Burnout Perawat Dalam Menangani Pasien Bpjs. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(3), 9–16. <https://doi.org/10.33221/jikes.v16i3.33>
- Rusmianingsih, N., Anggraini, D., Rayatin, L., Mayenti, F., Tarigan, Y. Z., Ekdha, A. U. A., & Zuraidah, Z. (2024). BUKU AJAR KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN. In *Nuansa Fajar Cemerlang*. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Sesrianty, V., Andriani, Y., & Putra, A. M. (2023). MOTIVASI PERAWAT BERHUBUNGAN DENGAN KOMUNIKASI. *Human Care Journal*, 8(1), 89–97.
- Sesrianty, V., & Harahap, H. B. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Supervisi Dengan Penerapan Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 11(1), 51–60.

- Xuan, B. M., Nurse, S., Teng, N., General, F., & Chiew-jiat, R. N. S. (n.d.). *A SYSTEMATIC REVIEW ON THE STRUCTURED HANDOVER*.
<https://doi.org/10.1111/jonm.12936>
- Yun, J., Lee, Y. J., Kang, K., & Park, J. (2023). Effectiveness of SBAR-based simulation programs for nursing students: a systematic review. *BMC Medical Education*, 23(1), 507.

Glosarium

Background	: Bagian SBAR yang berisi informasi latar belakang atau riwayat pasien yang relevan.
Beban kerja	: Jumlah tugas atau tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan tenaga kesehatan dalam periode tertentu
Handover	: Istilah lain serah terima pasien antar tenaga kesehatan di ruangan rawat pada tiap shift
Motivasi Kerja	: Dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi semangat dan kinerja tenaga kesehatan dalam bekerja
Outcome	: Hasil atau dampak yang diperoleh dari suatu proses pelayanan kesehatan
Patient Safety	: Keselamatan pasien
Recommendation:	Bagian dari metode SBAR yang berisi saran atau tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap pasien
SBAR	: Metode komunikasi terstruktur yang terdiri dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation
Situation	: Bagian SBAR yang menjelaskan kondisi utama atau masalah pasien saat ini.
SOP	: Pedoman atau aturan baku yang digunakan dalam pelaksanaan suatu tindakan di fasilitas kesehatan (Standar Operasional Prosedur)
Supervisi	: Proses pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan agar sesuai standar
Verifikasi	: Proses memastikan kembali kebenaran dan ketepatan informasi yang diterima

PROFIL PENULIS



Dr. Muhammad Syahid Hidayat BS, SH, SKep, MH, MS

lahir di Demak, 1 November 1977. Penulis menempuh pendidikan tinggi di Western Michigan University, Amerika Utara dan National Cheng Kung University, Taiwan. Saat ini, beliau bekerja di Kementerian Kesehatan dan mengajar di beberapa Kampus Keperawatan.

Dr. Hidayat aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk penulisan buku, publikasi ilmiah, dan seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hidayat.ms5758@gmail.com

Motto: "Melayani dengan hati, meneliti dengan pikiran, berbagi dengan jiwa."



Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 1990. Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia mulai S1, S2 dan Profesi. Penulis menyelesaikan S1 tahun 1999, S2 tahun 2005 dan Spesialis keperawatan Maternitas tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Doktorat pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) tahun 2019.

Keahlian penulis adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen SDM Kesehatan. Penulis Sebagai dosen pengajar Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh. Selain mengajar, penulis aktif sebagai Penulis aktif dalam pelatihan, workshop, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Informasi publikasi dapat diakses pada Google Scholar. Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang telah mempunyai ISBN dari IKAPI dan Prodi DIII Keperawatan Banda Aceh.

Selama ini penulis aktif organisasi diantaranya seperti Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (Ketua Regional Aceh 2020-2024). Organisasi berikutnya yang ditekuni penulis adalah Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI; ketua IPEMI Aceh 2009-2024). Demikian juga penulis aktif dalam ikatan alumni Universitas Indonesia (Provinsi Aceh).

Email: halimatussakdiah@poltekkesaceh.ac.id

Motto: "Menulis meninggalkan jejak ilmu dan membaca membuka jalan menuju perubahan."

PROFIL PENULIS

Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., PhD.

Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 16 Agustus 1967.

Pendidikan Yang telah ditempuh: S1 Pada program studi Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 manajemen keperawatan pada Universitas Indonesia lulus tahun 2001. Menamatkan pendidikan pada jenjang doctoral phylosofi in nursing di Lincoln University Malaysia tahun 2025. Saat ini sebagai Direktur Akademi Keperawatan Bina Insan Jakarta



Ns. Fitriana Dewi, S. Kep., M. Kep.

Lahir di Lhokseumawe, 12 September 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia Depok dan lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 menjadi Pengajar pada Akademi Keperawatan

Aceh Utara Aceh dan bekerja sampai saat ini. Pada 2020 Akademi Keperawatan beralih pengelolaan menjadi bagian dari Poltekkes Kemenkes Aceh. Penulis mengampu beberapa mata kuliah keperawatan antara lain Manajemen Keperawatan, Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan, Manajemen Patient Safety, dan Keperawatan Anak. Saat ini Penulis juga melakukan tugas tambahan sebagai bagian dari Akademik (Kurikulum) Prodi Keperawatan Aceh Utara Poltekkes Aceh. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, pendidik, melakukan penelitian dan pengabdian dosen kepada masyarakat. Ada beberapa karya ilmiah baik hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nyanyakfitriana.123@gmail.com

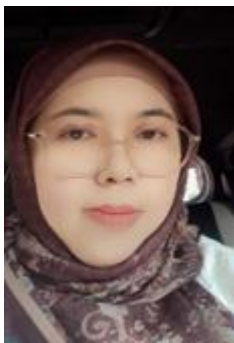
Motto: "Jangan tunggu hari esok bila dapat dikerjakan hari ini"

PROFIL PENULIS



Ns. Asih Minarningtyas, M.Kep.

Lahir di Bekasi 28 Oktober 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan Akper RSPAD Gatot Soebroto 1991, S1 + Ners FIK UI 2003 dan Magister Manajemen Keperawatan FIK UI 2011. Pernah bekerja sebagai Perawat Pelaksana di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 1992 – 1995 dan sejak 1995 bergabung di Akper Bani Saleh yang saat menjadi Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Dalam berorganisasi pernah menjadi pengurus Pusat Asosiasi Institusi Pendidikan Vocasi Indonesia, (AIPVIKI) Bidang Diklat di tahun 2015 – 2019 dan saat ini sebagai Pengurus AIPVIKI Regional Jawa Barat Bidang Belmewa tahun 2024 – 2028. Penulis juga Aktif pada Organisasi Profesi DPD PPNI Kota Bekasi sejak tahun 2015 sampai saat ini. Penulis menjadi dosen pengampu Mata Kuliah Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan dan Keperawatan Luka. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai narasumber, penulis modul / buku, publikasi, seminar dan pengabdian masyarakat. serta menjadi anggota aktif dalam NCI (Nursing Centre Indonesia), RLI (Rawat Luka Indonesia), Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: asih@ubs.ac.id



Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

lahir di Karanganyar , 25 Mei 1975 . Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus patahun 2025. Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2025 sebagai Dosen Part Timer di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta . Saat ini, penulis bekerja di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dan di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta dan mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan.. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriwahyuni250522@gmail.com

Motto: "Never stop creating, as every moment is a chance to leave a meaningful legacy.

PROFIL PENULIS



Ns. Vera Sesrianty, M.Kep.

Lahir di Duri, 2 November 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Pendidikan Diploma pada Akademi Keperawatan Perintis Bukittinggi lulus tahun 2000, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas Padang lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Keperawatan Peminatan manajemen Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali Karir pekerjaan bermula sebagai perawat Honorer di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi (2000-2001), sebagai Dosen di Akper Nabila Padang Panjang (2005-2009). Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Perintis Indonesia (2009 sekarang). Penulis mengampu pada mata kuliah seperti Manajemen Keperawatan, Manajemen Patient Safety, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, dan mata kuliah lainnya. Mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristekdikti dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: verasesrianty@gmail.com

Motto : "Belajar Bersabar, Ikhlas dan Tangguh"

Sinopsis

Bunga rampai “Keselamatan Pasien melalui Handover Keperawatan yang Efektif” mengulas peran krusial proses serah terima (handover) dalam menjaga kesinambungan asuhan dan mencegah insiden keselamatan pasien di layanan kesehatan. Disusun secara runtut dan aplikatif, buku ini menegaskan bahwa handover bukan sekadar pergantian shift, melainkan momen komunikasi klinis yang menentukan akurasi informasi, ketepatan keputusan, serta keamanan tindakan keperawatan berikutnya.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar keselamatan pasien dalam pelayanan keperawatan sebagai fondasi berpikir (Bab 1), lalu memperjelas pengertian dan tujuan handover untuk memastikan kesinambungan asuhan (Bab 2). Selanjutnya, buku ini menekankan prinsip komunikasi efektif—kejelasan, kelengkapan, ketepatan, dan konfirmasi—sebagai inti handover bermutu (Bab 3). Pada bagian inti, pembaca diajak memahami dan menerapkan metode SBAR (Situation–Background–Assessment–Recommendation) sebagai kerangka komunikasi yang terstandar agar pesan klinis tersampaikan cepat, ringkas, dan aman (Bab 4). Buku ini juga menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas handover, seperti beban kerja, lingkungan, budaya organisasi, keterampilan komunikasi, serta dukungan dokumentasi (Bab 5), dan menegaskan peran perawat sebagai garda terdepan pencegahan kesalahan melalui komunikasi yang bertanggung jawab, kolaboratif, dan berorientasi keselamatan (Bab 6). Di bagian akhir, disajikan pendekatan evaluasi efektivitas handover beserta indikator yang dapat digunakan untuk menilai dampaknya terhadap keselamatan pasien dan perbaikan mutu layanan (Bab 7).

Buku ini ditujukan bagi perawat klinis, manajer keperawatan, pendidik, mahasiswa, serta tim mutu dan keselamatan pasien yang membutuhkan rujukan praktis untuk membangun komunikasi handover yang konsisten, terstandar, dan berdampak nyata dalam menurunkan risiko kesalahan serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

Bunga rampai “Keselamatan Pasien melalui Handover Keperawatan yang Efektif” mengulas peran krusial proses serah terima (handover) dalam menjaga kesinambungan asuhan dan mencegah insiden keselamatan pasien di layanan kesehatan. Disusun secara runtut dan aplikatif, buku ini menegaskan bahwa handover bukan sekadar pergantian shift, melainkan momen komunikasi klinis yang menentukan akurasi informasi, ketepatan keputusan, serta keamanan tindakan keperawatan berikutnya.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar keselamatan pasien dalam pelayanan keperawatan sebagai fondasi berpikir (Bab 1), lalu memperjelas pengertian dan tujuan handover untuk memastikan kesinambungan asuhan (Bab 2). Selanjutnya, buku ini menekankan prinsip komunikasi efektif—kejelasan, kelengkapan, ketepatan, dan konfirmasi—sebagai inti handover bermutu (Bab 3). Pada bagian inti, pembaca diajak memahami dan menerapkan metode SBAR (Situation-Background-Assessment-Recommendation) sebagai kerangka komunikasi yang terstandar agar pesan klinis tersampaikan cepat, ringkas, dan aman (Bab 4). Buku ini juga menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas handover, seperti beban kerja, lingkungan, budaya organisasi, keterampilan komunikasi, serta dukungan dokumentasi (Bab 5), dan menegaskan peran perawat sebagai garda terdepan pencegahan kesalahan melalui komunikasi yang bertanggung jawab, kolaboratif, dan berorientasi keselamatan (Bab 6). Di bagian akhir, disajikan pendekatan evaluasi efektivitas handover beserta indikator yang dapat digunakan untuk menilai dampaknya terhadap keselamatan pasien dan perbaikan mutu layanan (Bab 7).

Buku ini ditujukan bagi perawat klinis, manajer keperawatan, pendidik mahasiswa, serta tim mutu dan keselamatan pasien yang membutuhkan rujukan praktis untuk membangun komunikasi handover yang konsisten, terstandar, dan berdampak nyata dalam menurunkan risiko kesalahan serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-37-4 (PDF)



9

786347

756374